



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**SK PROFIL INDIKATOR MUTU SAKIT PRIMA
HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor

Tentang
SK Profil Indikator Mutu Rumah Sakit Prima Husada Malang Tahun 2026

Disusun oleh
Ketua Komite PMKP



(dr. Ari Putriani, Sp. PK)

Ditetapkan oleh:
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 004.5/I-KEP/DIR/II/2026
TENTANG
INDIKATOR MUTU DAN KAMUS INDIKATOR RS PRIMA HUSADA
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi, nilai pelayanan kepada pasien;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Malang
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu penetapan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada profil indikator mutu Rumah Sakit Prima Husada Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.14/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Malang;
6. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 200.50/DPM/I-KEP/DIR/II/2022 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Indikator Mutu RS Prima Husada Malang
- Kesatu : Menetapkan indikator mutu RS Prima Husada Malang
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 03 Januari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKITPRIMA HUSADA
NOMOR

TENTANG PROFIL INDIKATOR
MUTUDAN KAMUS INDIKATOR
MUTU
RS PRIMA HUSADA MALANG

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU NASIONAL	STANDART	KETERANGAN
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	INM
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	INM
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	INM
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	INM
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	INM
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	INM
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	INM
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	INM
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	INM
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	INM
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	INM
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	INM
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	INM
14	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)	100%	SKP
15	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	SKP
16	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap	100%	SKP
17	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	SKP
18	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	100%	SKP

19	Kepatuhan pemasangan handrell dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	100%	SKP
20	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus	100%	IMP Klinis (Rawat Inap)
21	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus	100%	IMP Klinis (Rawat Inap)
22	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM	100%	IMP Klinis (Rawat Inap)
23	Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i>	0	IMP Tujuan Strategis (PIPP)
24	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	100%	IMP Manajemen Risiko (IPSRs)
25	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	100%	IMP Perbaikan Sistem (Farmasi)
26	Ketidaklengkapan E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI	0%	IGD
27	Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS	0	IGD
28	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD	0	IGD
29	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0	Rawat Inap
30	Ketidakpatuhan DPJP dalam pelaksanaan visite pasien	0%	Rawat Inap
31	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Rawat Inap
32	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU	0%	ICU / HCU
33	Kejadian Kesalahan saat hand over (serah terima)	0	ICU / HCU
34	Kejadian Keterlambatan pemasangan intubasi pasien	0	ICU / HCU
35	Kepatuhan DPJP terhadap Jadwal Praktek	100%	Rawat Jalan
36	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di irja	0%	Rawat Jalan
37	Target Pasien PRB dan iterasi	100%	Rawat Jalan
38	Pelayanan tidak sesuai program terapi	0%	Fisioterapi
39	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas	0%	Maternitas
40	Angka kematian ibu	0%	Maternitas
41	Kejadian perdarahan post partum	0	Maternitas
42	Kejadian partus macet	0	Maternitas

43	Kejadian eklamsi	0	Maternitas
44	Kejadian pre eklamsi	0	Maternitas
45	Kejadian infeksi nifas	0	Maternitas
46	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	Maternitas
47	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	Maternitas
48	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	Maternitas
49	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	Maternitas
50	Angka Kematian Bayi	0	Neonatologi
51	Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi	0	Neonatologi
52	Kejadian SHK yang di tolak Dinkes	0	Neonatologi
53	Kejadian re operasi	0	IKO
54	Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO	100%	IKO
55	Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi	0%	Laboratorium
56	Kejadian Ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	0	Radiologi
57	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi	0	Radiologi
58	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	Instalasi Gizi
59	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	Instalasi Gizi
60	Angka Kelengkapan Asuhan Gizi	100%	Instalasi Gizi
61	Kejadian kesalahan pemberian diet	0	Instalasi Gizi
62	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	Instalasi Gizi
63	Kejadian makanan basi	0	Instalasi Gizi
64	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	Farmasi
65	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	Farmasi

66	Keterlambatan sediaan farmasi datang	0	Pengadaan Farmasi
67	Kesalahan pembelian sediaan farmasi	0	Pengadaan Farmasi
68	Kepatuhan kesesuaian Selisih stok opname	0	Pengadaan Farmasi
69	Resptime memasukkan master barang baru 1X24 Jam	0	Pengadaan Farmasi
70	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	$\leq 2 \%$	PPI
71	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	$\leq 3,5\%$	PPI
72	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	$\leq 5,8 \%$	PPI
73	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	$\leq 4,7 \%$	PPI
74	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	$\leq 5 \%$	PPI
75	Angka Decubitus	0%	PPI
76	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	PPI
77	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	SDM
78	Angka turn over staf	0%	SDM
79	Kesalahan pendaftaran pasien	0	Pendaftaran
80	Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	0	Pendaftaran
81	Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI	0	Pendaftaran
82	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	0	Rawat Jalan
83	Ketidakpatuhan pembuatan PCRA	0	K3RS
84	Klaim pending IRJA <0,5%	<0,5%	Asuransi Center
85	Klaim pending IRNA <0,1%	<0,1%	Asuransi Center
86	Klaim tidak layak IRNA	0%	Asuransi Center
87	Klaim tidak layak IRJA	0%	Asuransi Center
88	Audit pasca klaim IRJA <1 juta	<1 juta	Asuransi Center
89	Audit pasca klaim IRNA 1-2 juta	1-2 juta	Asuransi Center

90	Selisih klaim (tarif RS > INACBgs) IRJA <50 juta	<50 juta	Asuransi Center
91	Selisih klaim RITL 50 - 100 juta	50-100 juta	Asuransi Center
92	Waktu tanggap respon dan penanganan pelaporan kerusakan unit	100%	IPSRS
93	Kejadian kerusakan sarana prasarana	0	IPSRS
94	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	Gudang Umum
95	Respon time menanggapi keluhan unit <10 menit	0%	Cleaning Service
96	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS (saat akhir rapat)	0%	Sekretariat
97	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	Laundry
98	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	Laundry
99	Kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril	0	CSSD
100	Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang	0	CSSD
101	Kejadian CCTV tidak terecord	0	IT
102	Kejadian Komputer dan internet lemot	100%	IT
103	Kelengkapan APD pada ruang jenazah	100%	Kama Jenazah
104	Kejadian permintaan driver yang bersamaan	0%	Driver
105	Kejadian Oncall driver	0	Driver
106	Penggunaan ambulance Luar RS	0	Driver
107	Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor (	0	Security
108	Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap	0	Security
109	Kesalahan pelunasan yang dilakukan	0	Kasir
110	Keterlambatan pelunasan pembayaran	0	Kasir
111	kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit	0	Kasir
112	Keterlambatan pengantaran obat	0	Primantara
113	Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	PKRS

114	Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi "Read Back" pada Instruksi Verbal	100%	PKRS
115	Angka Kepatuhan Petugas dalam Survei kelengkapan Form Edukasi Kolaborasi Oleh PPA	100%	PKRS
116	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	100%	PKRS
117	Angka Kepatuhan Pasien Mengambil Obat di Rumah Sakit	100%	PROGNAS TB
118	Angka Kepatuhan Petugas dalam Melakukan Edukasi Kelompok sebagai Upaya Pencegahan Penularan TB (4x/bln)	100%	PROGNAS TB
119	Kepatuhan DPJP terhadap PPK/CP TBC	100%	PROGNAS TB
120	Angka kepatuhan pengisian Kartu K4 KB	100%	PROGNAS KB
121	Angka Ibu Pasca Melahirkan dan Pasca Tindakan Curettage yang Mendapatkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Keluarga Berencana (KB)	100%	PROGNAS KB
122	Angka Pelaksanaan Pelayanan Konseling KB bagi Calon Peserta dan Peserta Program KB	100%	PROGNAS KB
123	Angka Pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting	100%	PROGNAS STUNTING
124	Angka Kepatuhan Petugas dalam Memberikan edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln)	100%	PROGNAS STUNTING

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan Tenaga Kesehatan
b) Dasar Pemikiran	Kebersihan tangan merupakan tindakan paling efektif dalam mencegah Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAIs). Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur kebersihan tangan berkontribusi langsung terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan sesuai standar untuk menurunkan risiko infeksi nosokomial
e) Definisi Operasional	Persentase tindakan kebersihan tangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai indikasi 5 momen kebersihan tangan dibandingkan dengan seluruh kesempatan (opportunity) yang seharusnya dilakukan kebersihan tangan dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar sesuai indikasi
i) Denominator (Penyebut)	Jumlah seluruh kesempatan (opportunity) kebersihan tangan yang terobservasi
j) Target Pencapaian	≥ 85% (atau sesuai standar RS, misalnya ≥ 90%)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Eksklusi: Petugas non klinis yang tidak kontak langsung dengan pasien
l) Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung (direct observation) menggunakan metode audit oleh observer terlatih
n) Sumber Data	Hasil observasi kepatuhan kebersihan tangan di unit pelayanan
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist observasi kebersihan tangan berdasarkan 5 momen kebersihan tangan
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh tenaga kesehatan di area pelayanan pasien. Sampel: Minimal 200 opportunity per bulan (atau sesuai standar PPI), diambil secara random sampling dan tersebar di seluruh unit pelayanan
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan setiap bulan dan direkap triwulan

s) Penyajian Data	Grafik tren (run chart), tabel capaian per unit, diagram batang per profesi
t) Penanggung Jawab	Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi), Kepala Ruangan, Komite PMKP

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
b) Dasar Pemikiran	Penggunaan APD merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian infeksi serta perlindungan tenaga kesehatan dari paparan risiko biologis, kimia, dan fisik. Ketidakpatuhan penggunaan APD meningkatkan risiko penularan infeksi dan kejadian kecelakaan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam menggunakan APD sesuai standar dan indikasi untuk melindungi pasien dan petugas
e) Definisi Operasional	Persentase tenaga kesehatan yang menggunakan APD sesuai jenis dan indikasi tindakan (masker, sarung tangan, gown, face shield, dll.) dibandingkan dengan seluruh kesempatan penggunaan APD yang terobservasi dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah penggunaan APD yang sesuai standar dan indikasi saat observasi
i) Denominator (Penyebut)	Jumlah seluruh kesempatan penggunaan APD yang seharusnya dilakukan berdasarkan indikasi
j) Target Pencapaian	≥ 95%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh tenaga kesehatan dan petugas yang melakukan tindakan klinis atau berisiko paparan. Eksklusi: Petugas administrasi/non-klinis tanpa risiko paparan langsung
l) Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung oleh tim PPI / supervisor menggunakan checklist
n) Sumber Data	Hasil audit kepatuhan APD di unit pelayanan
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist observasi penggunaan APD sesuai standar PPI
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh tenaga kesehatan di area pelayanan. Sampel: Minimal 100–200 observasi per bulan (d disesuaikan jumlah unit), diambil dengan random sampling atau purposive sampling pada area risiko tinggi (IGD, OK, ICU, isolasi)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, pelaporan dalam rapat mutu dan PPI setiap bulan, rekap triwulan
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel capaian per unit, diagram batang per jenis APD
t) Penanggung Jawab	Tim PPI, Kepala Ruangan, Komite PMKP, K3RS

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
b) Dasar Pemikiran	Identifikasi pasien yang benar merupakan sasaran keselamatan pasien untuk mencegah kesalahan pemberian obat, tindakan, pemeriksaan, dan prosedur lainnya. Ketidakpatuhan identifikasi pasien dapat menyebabkan kejadian tidak diharapkan (KTD).
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum pemberian pelayanan/tindakan
e) Definisi Operasional	Persentase tenaga kesehatan yang melakukan identifikasi pasien dengan menggunakan minimal dua identitas (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis) sebelum pemberian obat, transfusi darah, tindakan, pengambilan spesimen, dan prosedur lainnya dibandingkan dengan seluruh kesempatan yang terobservasi
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah tindakan pelayanan yang didahului dengan identifikasi pasien sesuai standar (minimal dua identitas)
i) Denominator (Penyebut)	Jumlah seluruh tindakan pelayanan yang seharusnya dilakukan identifikasi pasien berdasarkan hasil observasi
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung (pemberian obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, transfusi, dll.). Eksklusi: Pasien gawat darurat yang tidak sadar tanpa identitas dan dalam kondisi penyelamatan jiwa (dicatat sebagai pengecualian klinis).
l) Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung (direct observation) oleh tim mutu/PPI/supervisor
n) Sumber Data	Hasil observasi di unit pelayanan (rawat inap, IGD, rawat jalan, OK, ICU, dll.)
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist observasi kepatuhan identifikasi pasien sesuai standar keselamatan pasien
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh tenaga kesehatan di area pelayanan pasien. Sampel: Minimal 100–200 observasi per bulan, diambil secara random sampling dan tersebar di seluruh unit pelayanan

q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat mutu unit dan PMKP, rekap triwulan
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel capaian per unit, diagram batang per profesi
t) Penanggung Jawab	Komite PMKP, Kepala Ruangan, Kepala Instalasi, Komite Keselamatan Pasien

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi
b) Dasar Pemikiran	Seksio sesarea emergensi memerlukan respons cepat untuk mencegah morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi. Standar pelayanan menyarankan waktu tanggap (decision to incision time) maksimal 30 menit pada kondisi emergensi kategori 1.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Ketepatan Waktu (Timeliness)
d) Tujuan	Menjamin pelaksanaan operasi seksio sesarea emergensi dilakukan secara cepat dan tepat waktu sesuai standar untuk menurunkan risiko komplikasi ibu dan bayi
e) Definisi Operasional	Persentase kasus seksio sesarea emergensi yang dilakukan dengan waktu ≤ 30 menit sejak keputusan operasi ditegakkan sampai insisi pertama dilakukan
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus seksio sesarea emergensi dengan waktu tanggap ≤ 30 menit
i) Denominator (Penyebut)	Total kasus seksio sesarea emergensi dalam periode tertentu
j) Target Pencapaian	$\geq 90\%$ kasus dilakukan ≤ 30 menit
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua pasien dengan indikasi seksio sesarea emergensi (kategori 1 dan 2). Eksklusi: Seksio sesarea elektif atau terencana
l) Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan laporan kamar operasi
n) Sumber Data	Rekam medis, buku register OK, laporan partograf, dan catatan anestesi
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit waktu tanggap SC emergensi
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh kasus seksio sesarea emergensi. Sampel: Total sampling (seluruh kasus dalam periode berjalan)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan pada rapat mutu maternitas dan PMKP, rekap triwulan
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel capaian, analisis kasus yang melebihi 30 menit
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Bedah Sentral, Kepala Ruang Maternitas, Komite Medik, Komite PMKP

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan
b) Dasar Pemikiran	Waktu tunggu yang lama dapat menurunkan kepuasan pasien, meningkatkan keluhan/komplain, serta mempengaruhi persepsi mutu pelayanan. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu dimensi mutu pelayanan kesehatan.
c) Dimensi Mutu	Ketepatan Waktu (Timeliness), Berorientasi pada Pasien, Efisiensi
d) Tujuan	Meningkatkan ketepatan waktu pelayanan rawat jalan sehingga pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar waktu yang ditetapkan
e) Definisi Operasional	Rata-rata waktu tunggu pasien rawat jalan sejak selesai pendaftaran sampai dilayani oleh dokter di poliklinik dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Menit
h) Numerator (Pembilang)	Total waktu tunggu seluruh pasien rawat jalan dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien rawat jalan yang dilayani dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 60 menit (atau sesuai standar RS, misalnya ≤ 30 menit)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat jalan yang telah terdaftar dan mendapatkan pelayanan dokter. Eksklusi: Pasien batal berobat, pasien gawat darurat yang langsung ditangani tanpa melalui alur rawat jalan reguler.
l) Formula	$\text{Rata-rata waktu tunggu} = \frac{\text{Total waktu tunggu (menit)}}{\text{Total pasien yang dilayani}}$
m) Metode Pengumpulan Data	Pencatatan waktu melalui sistem antrian elektronik atau observasi manual
n) Sumber Data	Sistem informasi rumah sakit (SIMRS), buku register poliklinik
o) Instrumen Pengambilan Data	Rekap laporan waktu pendaftaran dan waktu mulai pelayanan dokter
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh pasien rawat jalan. Sampel: Total sampling per hari atau sampling minimal 100 pasien per bulan (bila jumlah besar)
q) Periode Pengumpulan Data	Harian, direkap bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat mutu rawat jalan dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren rata-rata waktu tunggu bulanan, diagram batang per poliklinik
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Unit Pendaftaran, Komite PMKP

6. Penundaan Operasi Elektif

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Penundaan Operasi Elektif
b) Dasar Pemikiran	Penundaan operasi elektif dapat berdampak pada keselamatan pasien, kepuasan pasien, efisiensi pelayanan, serta manajemen jadwal kamar operasi. Tingginya angka penundaan menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam perencanaan praoperatif, kesiapan pasien, tenaga medis, maupun sarana prasarana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk meningkatkan mutu pelayanan bedah.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Efisiensi, Keselamatan, dan Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Mengukur dan menurunkan angka penundaan operasi elektif guna meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien.
e) Definisi Operasional	Penundaan operasi elektif adalah kejadian tidak terlaksananya operasi yang telah dijadwalkan pada hari yang sama sesuai jadwal awal karena alasan medis maupun non-medis.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus operasi elektif yang ditunda pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh operasi elektif yang dijadwalkan pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 5%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien dengan operasi elektif terjadwal pada periode pengukuran. Eksklusi: Operasi cito/emergensi, pasien batal operasi atas permintaan sendiri sebelum hari tindakan.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah operasi elektif yang ditunda}}{\text{Total operasi elektif terjadwal}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi dan telaah dokumen rekam medis serta jadwal kamar operasi
n) Sumber Data	Buku jadwal kamar operasi, rekam medis, laporan harian kamar operasi
o) Instrumen Pengambilan Data	Formulir monitoring penundaan operasi elektif
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien yang dijadwalkan operasi elektif (total populasi)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel, grafik tren (run chart), dan diagram batang
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Bedah Sentral / Kepala Kamar Operasi dan Komite Mutu Rumah Sakit

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Waktu Visite Dokter
b) Dasar Pemikiran	Visite dokter yang dilakukan tepat waktu merupakan bagian penting dalam kesinambungan asuhan, pengambilan keputusan klinis, dan percepatan terapi pasien. Ketidaktepatan waktu visite dapat berdampak pada keterlambatan tindakan medis, perpanjangan hari rawat, serta menurunkan kepuasan pasien. Monitoring indikator ini diperlukan untuk menjamin mutu pelayanan rawat inap.
c) Dimensi Mutu	Ketepatan Waktu (Timeliness), Efektivitas, Keselamatan, Berfokus pada Pasien
d) Tujuan	Mengukur dan meningkatkan kepatuhan dokter dalam melaksanakan visite sesuai jadwal yang telah ditetapkan rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan waktu visite dokter adalah pelaksanaan visite oleh DPJP sesuai waktu yang ditetapkan dalam regulasi rumah sakit (misalnya pukul 08.00–14.00 WIB atau sesuai kebijakan internal RS) dan terdokumentasi dalam rekam medis pada hari perawatan pasien.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah visite dokter yang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan pada periode pengukuran
i) Denominator (Penyebut)	Total kewajiban visite dokter pada pasien rawat inap dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 90% (dapat disesuaikan dengan standar internal rumah sakit)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat inap yang menjadi tanggung jawab DPJP dan wajib divisite pada hari pengukuran. Eksklusi: Pasien pulang sebelum waktu visite, pasien pindah ruangan sebelum jadwal visite, kondisi force majeure yang terdokumentasi.
l) Formula	$(\text{Jumlah visite tepat waktu} \div \text{Total kewajiban visite}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan verifikasi buku/daftar visite harian
n) Sumber Data	Rekam medis pasien rawat inap, buku visite ruangan, SIMRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit kepatuhan waktu visite dokter
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien rawat inap pada periode pengukuran (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruangan Rawat Inap, Komite Medik, dan Komite Mutu Rumah Sakit

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
b) Dasar Pemikiran	Hasil pemeriksaan laboratorium dengan nilai kritis (critical value) berpotensi mengancam keselamatan pasien dan memerlukan tindakan segera. Keterlambatan pelaporan dapat menyebabkan keterlambatan terapi dan meningkatkan risiko morbiditas maupun mortalitas. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan ketepatan dan kecepatan pelaporan hasil kritis sebagai bagian dari keselamatan pasien.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Ketepatan Waktu (Timeliness), Efektivitas
d) Tujuan	Mengukur kepatuhan petugas laboratorium dalam melaporkan hasil kritis kepada DPJP/unit terkait sesuai standar waktu yang ditetapkan rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Pelaporan hasil kritis laboratorium adalah penyampaian hasil pemeriksaan dengan nilai kritis oleh petugas laboratorium kepada DPJP/perawat/unit terkait dalam batas waktu yang ditetapkan (misal ≤30 menit setelah hasil tervalidasi), serta terdokumentasi dengan baik.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah hasil kritis yang dilaporkan sesuai standar waktu yang ditetapkan pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dengan nilai kritis pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 100% kepatuhan pelaporan tepat waktu
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dengan nilai kritis sesuai daftar critical value RS. Eksklusi: Hasil kritis yang terjadi pada pasien yang sudah meninggal atau pulang sebelum hasil tervalidasi dan terdokumentasi jelas.
l) Formula	$(\text{Jumlah hasil kritis dilaporkan tepat waktu} \div \text{Total hasil kritis}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit log sistem laboratorium dan telaah dokumentasi pelaporan (buku/format pelaporan hasil kritis)
n) Sumber Data	SIMRS/LIS (Laboratory Information System), buku laporan hasil kritis, rekam medis pasien
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit pelaporan hasil kritis laboratorium
p) Populasi / Sampel	Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dengan nilai kritis (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium dan Komite Mutu Rumah Sakit

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
b) Dasar Pemikiran	Formularium Nasional (Fornas) merupakan acuan dalam pemilihan obat yang rasional, efektif, aman, dan cost-effective terutama dalam era JKN. Ketidakpatuhan terhadap Fornas dapat berdampak pada pembiayaan pelayanan, klaim BPJS, serta mutu terapi pasien. Oleh karena itu, diperlukan monitoring kepatuhan penggunaan Fornas sebagai bagian dari kendali mutu dan kendali biaya.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Efisiensi, Keselamatan, dan Kepatuhan terhadap Regulasi
d) Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan dokter dalam meresepkan obat sesuai Formularium Nasional.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional adalah persentase peresepan obat pada pasien JKN yang sesuai dengan daftar obat dalam Formularium Nasional yang berlaku pada periode pengukuran.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah item obat yang diresepkan sesuai dengan Formularium Nasional pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh item obat yang diresepkan pada pasien JKN dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 90% (atau sesuai kebijakan rumah sakit)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh resep pasien JKN rawat jalan dan rawat inap pada periode pengukuran. Eksklusi: Obat yang tidak tercantum dalam Fornas namun memiliki justifikasi medis dan persetujuan Komite Farmasi dan Terapi (KFT).
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah item obat sesuai Fornas}}{\text{Total item obat yang diresepkan pada pasien JKN}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit resep dan telaah kesesuaian dengan daftar Formularium Nasional
n) Sumber Data	Resep pasien, SIMRS/farmasi, daftar Formularium Nasional terbaru
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kepatuhan penggunaan Formularium Nasional
p) Populasi / Sampel	Seluruh resep pasien JKN (total sampling atau sampling acak sesuai kebijakan RS)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi, Komite Farmasi dan Terapi (KFT), dan Komite Mutu Rumah Sakit

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
b) Dasar Pemikiran	Clinical Pathway (CP) merupakan panduan tata laksana terstandar untuk diagnosis tertentu yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi biaya. Ketidakpatuhan terhadap CP dapat menyebabkan variasi praktik klinis, peningkatan biaya, serta risiko komplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring kepatuhan terhadap implementasi Clinical Pathway.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Efisiensi, Keselamatan, dan Kepatuhan terhadap Standar
d) Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan sesuai Clinical Pathway yang telah ditetapkan rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan terhadap Clinical Pathway adalah kesesuaian tata laksana pasien dengan diagnosis tertentu terhadap item/intervensi yang tercantum dalam dokumen CP rumah sakit, mulai dari asesmen, pemeriksaan penunjang, terapi, hingga rencana pemulangan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus yang tata laksananya sesuai dengan Clinical Pathway pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total kasus dengan diagnosis yang memiliki Clinical Pathway pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 80%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien dengan diagnosis yang sudah memiliki Clinical Pathway dan dirawat pada periode pengukuran. Eksklusi: Pasien dengan komplikasi khusus atau komorbid berat yang memerlukan deviasi klinis dengan justifikasi tertulis dari DPJP.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah kasus sesuai Clinical Pathway}}{\text{Total kasus dengan CP}} \times 100\% \right)$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan telaah dokumen Clinical Pathway
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, dokumen Clinical Pathway, SIMRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kepatuhan Clinical Pathway (checklist item CP)
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien dengan diagnosis yang memiliki Clinical Pathway (total sampling atau sampling acak sesuai kebijakan RS)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang, serta analisis deviasi
t) Penanggung Jawab	Komite Medik, Ketua SMF terkait, dan Komite Mutu Rumah Sakit

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
b) Dasar Pemikiran	Pasien jatuh merupakan salah satu insiden keselamatan pasien yang dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat, memperpanjang lama rawat, dan meningkatkan biaya pelayanan. Upaya pencegahan melalui skrining risiko jatuh dan implementasi intervensi yang sesuai harus dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring kepatuhan terhadap pelaksanaan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Berfokus pada Pasien
d) Tujuan	Mengukur dan meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan asesmen dan intervensi pencegahan risiko pasien jatuh sesuai standar rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan skrining risiko jatuh (misalnya menggunakan skala Morse/Skala lain sesuai kebijakan RS) serta penerapan intervensi pencegahan pada pasien dengan risiko jatuh, yang terdokumentasi dalam rekam medis.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien yang telah dilakukan asesmen risiko jatuh dan diberikan intervensi sesuai hasil skrining pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien rawat inap yang wajib dilakukan asesmen risiko jatuh pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat inap yang dirawat ≥ 24 jam. Eksklusi: Pasien dengan kondisi terminal/meninggal < 24 jam sejak masuk, pasien rawat jalan.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pasien dilakukan asesmen \& intervensi sesuai standar}}{\text{Total pasien wajib asesmen}} \times 100\% \right)$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan observasi langsung implementasi intervensi di ruangan
n) Sumber Data	Rekam medis (lembar asesmen risiko jatuh), checklist intervensi, laporan insiden keselamatan pasien
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien rawat inap (total sampling atau sampling acak sesuai kebijakan RS)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang, serta analisis kejadian jatuh
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruangan Rawat Inap, Komite Keperawatan, dan Komite Mutu Rumah Sakit

12. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain
b) Dasar Pemikiran	Komplain pasien dan keluarga merupakan bagian dari umpan balik penting dalam peningkatan mutu pelayanan. Respons yang cepat dan tepat terhadap komplain dapat meningkatkan kepuasan pasien, mencegah eskalasi masalah, serta memperbaiki citra rumah sakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring terhadap kecepatan waktu tanggap komplain.
c) Dimensi Mutu	Berfokus pada Pasien, Ketepatan Waktu (Timeliness), Responsivitas
d) Tujuan	Mengukur dan meningkatkan kecepatan respons rumah sakit dalam menindaklanjuti komplain pasien/keluarga sesuai standar waktu yang ditetapkan.
e) Definisi Operasional	Kecepatan waktu tanggap komplain adalah interval waktu sejak komplain diterima secara resmi (lisan/tertulis/media elektronik) hingga diberikan respons awal kepada pelapor sesuai standar waktu yang ditetapkan rumah sakit (misalnya $\leq 1 \times 24$ jam).
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah komplain yang mendapatkan respons awal sesuai standar waktu yang ditetapkan pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh komplain yang diterima pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	$\geq 90\%$ ditindaklanjuti $\leq 1 \times 24$ jam (atau sesuai kebijakan RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh komplain yang tercatat secara resmi melalui kotak saran, customer service, media sosial resmi, telepon, atau surat tertulis. Eksklusi: Keluhan yang tidak teridentifikasi (anonim tanpa informasi yang dapat diverifikasi) atau bukan terkait pelayanan rumah sakit.
l) Formula	$(\text{Jumlah komplain yang ditanggapi} \leq \text{standar waktu} \div \text{Total komplain}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi dan audit buku/register komplain serta verifikasi waktu respons
n) Sumber Data	Buku register komplain, laporan customer service, email resmi, media sosial resmi RS, SIMRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring dan rekap waktu tanggap komplain
p) Populasi / Sampel	Seluruh komplain yang masuk pada periode pengukuran (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang, serta analisis jenis komplain
t) Penanggung Jawab	Kepala Humas/Customer Service, Kepala Unit Terkait, dan Komite Mutu Rumah Sakit

13. Kepuasan Pasien

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepuasan Pasien
b) Dasar Pemikiran	Kepuasan pasien merupakan indikator penting dalam menilai mutu pelayanan rumah sakit. Tingkat kepuasan mencerminkan persepsi pasien terhadap pelayanan medis, keperawatan, fasilitas, komunikasi, dan kenyamanan selama menerima pelayanan. Monitoring kepuasan pasien secara berkala diperlukan sebagai dasar perbaikan mutu berkelanjutan.
c) Dimensi Mutu	Berfokus pada Pasien (Patient Centered Care), Efektivitas, Responsivitas
d) Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan.
e) Definisi Operasional	Kepuasan pasien adalah tingkat penilaian pasien terhadap pelayanan yang diterima, yang diukur melalui kuesioner kepuasan dengan skala tertentu (misalnya skala Likert) mencakup aspek pelayanan medis, keperawatan, administrasi, fasilitas, dan kenyamanan.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelayanan
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh responden yang mengisi kuesioner kepuasan pada periode pengukuran
j) Target Pencapaian	≥ 76,61% pasien menyatakan puas/sangat puas (atau nilai rata-rata ≥ 3,5 dari skala 1–4, sesuai kebijakan RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien rawat jalan dan rawat inap yang telah menerima pelayanan dan bersedia mengisi kuesioner. Eksklusi: Pasien dalam kondisi tidak sadar, gangguan komunikasi berat tanpa pendamping, atau tidak bersedia mengisi kuesioner.
l) Formula	$(\text{Jumlah pasien puas \& sangat puas} \div \text{Total responden}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Survei menggunakan kuesioner (manual atau elektronik)
n) Sumber Data	Kuesioner kepuasan pasien, hasil survei online/offline, SIMRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner kepuasan pasien (skala Likert)
p) Populasi / Sampel	Pasien rawat jalan dan rawat inap (sampling acak atau total sampling sesuai kebijakan RS)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan atau Triwulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang, diagram pie per dimensi pelayanan
t) Penanggung Jawab	Kepala Humas/Customer Service, Kepala Unit Pelayanan, dan Komite Mutu Rumah Sakit

14. Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (Farmasi)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Verifikasi Identitas Pasien Sebelum Pemberian Obat Pasien Rawat Jalan (Farmasi)
b) Dasar Pemikiran	Kesalahan identifikasi pasien merupakan salah satu penyebab utama medication error. Verifikasi identitas pasien sebelum penyerahan obat merupakan bagian dari sasaran keselamatan pasien untuk memastikan obat diberikan kepada pasien yang benar. Monitoring indikator ini diperlukan untuk mencegah kesalahan pemberian obat dan meningkatkan keselamatan pasien.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Kepatuhan terhadap Standar, Efektivitas
d) Tujuan	Mengukur dan meningkatkan kepatuhan petugas farmasi dalam melakukan verifikasi identitas pasien sebelum penyerahan obat rawat jalan.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan verifikasi identitas pasien adalah tindakan petugas farmasi mencocokkan minimal dua identitas pasien (misalnya nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis) sebelum menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga, sesuai standar prosedur operasional dan terdokumentasi.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah penyerahan obat rawat jalan yang dilakukan dengan verifikasi identitas sesuai standar pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh penyerahan obat rawat jalan pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh proses penyerahan obat kepada pasien rawat jalan pada periode pengukuran. Eksklusi: Obat yang dikirim langsung ke unit pelayanan (bukan penyerahan langsung ke pasien) dan kondisi gangguan sistem dengan dokumentasi resmi.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah penyerahan obat dengan verifikasi identitas sesuai standar}}{\text{Total penyerahan obat rawat jalan}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung, audit rekam resep, dan checklist kepatuhan petugas
n) Sumber Data	Resep pasien, SIMRS/farmasi, form observasi kepatuhan
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit/observasi verifikasi identitas pasien sebelum penyerahan obat
p) Populasi / Sampel	Seluruh penyerahan obat rawat jalan (total sampling atau sampling acak sesuai kebijakan RS)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi dan Komite Mutu Rumah Sakit

15. Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (Radiologi)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Pelaporan Hasil Kritis Radiologi
b) Dasar Pemikiran	Hasil pemeriksaan radiologi dengan temuan kritis (critical findings) berpotensi mengancam keselamatan pasien dan memerlukan tindakan segera. Keterlambatan pelaporan dapat menyebabkan keterlambatan terapi serta meningkatkan risiko komplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi sebagai bagian dari sasaran keselamatan pasien.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Ketepatan Waktu (Timeliness), Efektivitas
d) Tujuan	Mengukur kepatuhan tenaga radiologi dalam melaporkan hasil kritis kepada DPJP/unit terkait sesuai standar waktu yang ditetapkan rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi adalah penyampaian temuan radiologi yang termasuk kategori kritis kepada DPJP/unit terkait dalam batas waktu yang ditetapkan (misalnya ≤ 30 menit setelah hasil dibaca/divalidasi dokter radiologi), serta terdokumentasi dengan mekanisme komunikasi efektif (termasuk read-back).
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah hasil radiologi dengan temuan kritis yang dilaporkan sesuai standar waktu pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh hasil radiologi dengan temuan kritis pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	100% dilaporkan sesuai standar waktu
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh hasil pemeriksaan radiologi dengan temuan kritis sesuai daftar critical findings RS. Eksklusi: Hasil kritis pada pasien yang sudah meninggal atau pulang sebelum hasil tervalidasi dan terdokumentasi jelas.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah hasil kritis radiologi dilaporkan tepat waktu}}{\text{Total hasil kritis radiologi}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit laporan radiologi dan telaah dokumentasi komunikasi hasil kritis
n) Sumber Data	Sistem Informasi Radiologi (RIS), rekam medis, buku/log pelaporan hasil kritis
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit pelaporan hasil kritis radiologi
p) Populasi / Sampel	Seluruh hasil radiologi dengan temuan kritis (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang, serta analisis jenis temuan kritis
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Radiologi dan Komite Mutu Rumah Sakit

16. Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat-obatan High Alert di rawat inap

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Penempelan Label Obat LASA dan Obat-obatan High Alert di Rawat Inap
b) Dasar Pemikiran	Obat LASA (Look Alike Sound Alike) dan obat High Alert merupakan obat dengan risiko tinggi menyebabkan kesalahan pemberian obat (medication error) yang dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien. Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan sistem identifikasi yang jelas melalui penempelan label khusus sesuai standar rumah sakit. Monitoring kepatuhan pelabelan diperlukan untuk menjamin implementasi keselamatan pasien berjalan optimal.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas (Effectiveness), Kepatuhan terhadap Standar
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melakukan penempelan label obat LASA dan High Alert sesuai standar guna mencegah kejadian medication error di ruang rawat inap.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan High Alert adalah persentase obat kategori LASA dan High Alert yang tersedia di ruang rawat inap dan telah ditempelkan label khusus sesuai dengan standar dan daftar resmi rumah sakit pada periode tertentu.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah obat LASA dan High Alert di ruang rawat inap yang telah ditempel label sesuai standar pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh obat LASA dan High Alert yang tersedia di ruang rawat inap yang seharusnya diberi label pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	100% obat LASA dan High Alert diberi label sesuai standar.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh obat yang termasuk dalam daftar LASA dan High Alert rumah sakit dan tersedia di ruang rawat inap. Eksklusi: Obat yang tidak termasuk dalam daftar LASA dan High Alert rumah sakit atau obat yang tidak tersedia saat periode audit.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah obat LASA dan High Alert yang diberi label sesuai standar}}{\text{Total obat LASA dan High Alert yang tersedia}} \times 100\% \right)$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung dan audit kepatuhan menggunakan checklist oleh tim mutu atau instalasi farmasi.
n) Sumber Data	Daftar resmi obat LASA dan High Alert rumah sakit, stok obat di ruang rawat inap, dan hasil audit lapangan.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit kepatuhan pelabelan obat LASA dan High Alert.
p) Populasi / Sampel	Seluruh obat LASA dan High Alert yang tersedia di seluruh ruang rawat inap (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), serta analisis tingkat kepatuhan per ruang rawat inap.

t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Ruang Rawat Inap, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
---------------------	---

17. Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi (IKO)
b) Dasar Pemikiran	Kesalahan lokasi operasi (wrong site surgery) merupakan kejadian sentinel yang dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien. Penandaan lokasi operasi merupakan bagian dari Sasaran Keselamatan Pasien dan prosedur Surgical Safety Checklist yang wajib dilaksanakan sebelum tindakan operasi. Monitoring kepatuhan diperlukan untuk memastikan seluruh prosedur penandaan dilakukan sesuai standar.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Kepatuhan terhadap Standar, Efektivitas
d) Tujuan	Menjamin seluruh tindakan operasi dilakukan pada lokasi yang benar melalui kepatuhan terhadap prosedur penandaan lokasi operasi sesuai standar rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan penandaan lokasi operasi adalah persentase pasien yang menjalani tindakan operasi yang telah dilakukan penandaan lokasi operasi secara benar, jelas, dan terdokumentasi sesuai standar sebelum tindakan dilakukan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien operasi yang dilakukan penandaan lokasi operasi sesuai standar dan terdokumentasi pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh pasien yang menjalani tindakan operasi yang memerlukan penandaan lokasi pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	100% tindakan operasi dilakukan penandaan lokasi sesuai standar.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien yang menjalani tindakan operasi yang memerlukan penandaan lokasi (operasi elektif maupun emergensi). Eksklusi: Operasi yang tidak memerlukan penandaan lokasi (misal: operasi dengan satu lokasi yang tidak ambigu sesuai kebijakan rumah sakit).
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pasien yang dilakukan penandaan lokasi sesuai standar}}{\text{Total pasien operasi yang memerlukan penandaan lokasi}} \times 100\% \right)$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis, observasi langsung di kamar operasi, dan telaah checklist keselamatan operasi (Surgical Safety Checklist).
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, Form Surgical Safety Checklist, buku register kamar operasi.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kepatuhan penandaan lokasi operasi.
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien yang menjalani tindakan operasi pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), dan analisis kepatuhan per DPJP atau per kamar operasi.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Kamar Operasi, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Ketua Komite Medik

18. Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 Langkah Cuci Tangan (PPI)
b) Dasar Pemikiran	Kebersihan tangan merupakan langkah paling efektif dalam mencegah infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs). Pelaksanaan 6 langkah cuci tangan sesuai standar WHO merupakan bagian dari Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Monitoring kepatuhan diperlukan untuk menurunkan angka infeksi dan meningkatkan keselamatan pasien.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Kepatuhan terhadap Standar
d) Tujuan	Mengukur dan meningkatkan kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan cuci tangan dengan 6 langkah sesuai standar.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan 6 langkah cuci tangan adalah pelaksanaan kebersihan tangan oleh petugas kesehatan sesuai dengan 6 langkah teknik hand hygiene pada momen yang tepat (5 momen hand hygiene) dan dilakukan secara lengkap sesuai prosedur.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah tindakan cuci tangan yang dilakukan lengkap sesuai 6 langkah pada periode observasi
i) Denominator (Penyebut)	Total kesempatan (opportunity) petugas untuk melakukan cuci tangan pada periode observasi
j) Target Pencapaian	≥ 85% (atau sesuai kebijakan rumah sakit)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh petugas kesehatan (dokter, perawat, bidan, tenaga penunjang medis) yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Eksklusi: Petugas non-klinis tanpa kontak pasien langsung.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pelaksanaan 6 langkah sesuai standar}}{\text{Total kesempatan cuci tangan}} \times 100\% \right)$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung oleh tim PPI menggunakan metode surveillance
n) Sumber Data	Form observasi hand hygiene, laporan PPI
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist observasi 6 langkah dan 5 momen hand hygiene
p) Populasi / Sampel	Petugas kesehatan di seluruh unit pelayanan (sampling observasi sesuai kebijakan PPI)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang per unit pelayanan
t) Penanggung Jawab	Ketua Tim PPI, Kepala Ruangan, dan Komite Mutu Rumah Sakit

19. Kepatuhan pemasangan handrell dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Pemasangan Handrail dan Penguncian Roda Brankar (IGD, IRNA, IKO)
b) Dasar Pemikiran	Pasien jatuh dari brankar atau tempat tidur akibat handrail tidak terpasang dan roda tidak terkunci merupakan risiko keselamatan pasien yang dapat menyebabkan cedera serius. Pencegahan risiko jatuh menjadi bagian penting dalam Sasaran Keselamatan Pasien. Monitoring kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar diperlukan untuk meminimalkan insiden keselamatan pasien.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Kepatuhan terhadap Standar, Efektivitas
d) Tujuan	Mengukur dan meningkatkan kepatuhan petugas dalam memastikan handrail terpasang dan roda brankar terkunci saat pasien berada di atas brankar/tempat tidur atau saat proses transfer pasien.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan adalah tindakan petugas memastikan kedua handrail terpasang dan roda brankar dalam kondisi terkunci saat pasien tidak dalam proses perpindahan aktif, sesuai standar prosedur operasional rumah sakit, yang dibuktikan melalui observasi langsung.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah brankar/tempat tidur yang handrail terpasang dan roda terkunci sesuai standar pada saat observasi
i) Denominator (Penyebut)	Total brankar/tempat tidur dengan pasien yang diobservasi pada periode pengukuran
j) Target Pencapaian	≥ 95% (atau sesuai kebijakan rumah sakit)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien yang berada di brankar/tempat tidur di IGD, IRNA, dan IKO pada saat observasi. Eksklusi: Pasien dalam proses transfer aktif dengan pengawasan langsung petugas, atau tindakan medis yang mengharuskan handrail terbuka dengan dokumentasi jelas.
l) Formula	$(\text{Jumlah brankar sesuai standar keselamatan} \div \text{Total brankar yang diobservasi}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung oleh tim mutu atau kepala ruangan menggunakan checklist
n) Sumber Data	Hasil observasi lapangan dan form monitoring keselamatan pasien
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist observasi kepatuhan handrail dan penguncian roda brankar
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien di IGD, IRNA, dan IKO (sampling observasi sesuai kebijakan RS)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi per unit (IGD, IRNA, IKO), grafik tren (run chart), diagram batang
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruangan IGD, IRNA, IKO dan Komite Mutu Rumah Sakit

20. Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning Pasien DM dengan Ulkus
b) Dasar Pemikiran	Pasien Diabetes Melitus (DM) dengan ulkus memiliki risiko tinggi komplikasi, infeksi berulang, dan rawat ulang. Discharge planning yang lengkap dan terstruktur penting untuk memastikan kesinambungan perawatan di rumah, kepatuhan terapi, serta pencegahan kekambuhan. Monitoring kepatuhan pengisian form discharge planning diperlukan untuk menjamin mutu asuhan dan menurunkan angka readmisi.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Berfokus pada Pasien, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Mengukur dan meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengisi form discharge planning pasien DM dengan ulkus secara lengkap sesuai standar rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan pengisian form discharge planning adalah kelengkapan pengisian seluruh item wajib pada form discharge planning pasien DM dengan ulkus (edukasi perawatan luka, kontrol gula darah, jadwal kontrol, terapi obat, tanda bahaya, rujukan bila perlu) sebelum pasien dipulangkan, yang terdokumentasi dalam rekam medis.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien DM dengan ulkus yang form discharge planning-nya terisi lengkap sesuai standar pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien DM dengan ulkus yang pulang pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 90% (atau sesuai kebijakan rumah sakit)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat inap dengan diagnosis DM disertai ulkus yang pulang pada periode pengukuran. Eksklusi: Pasien meninggal dunia, pulang atas permintaan sendiri (APS), atau dirujuk ke fasilitas lain sebelum proses discharge planning selesai.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah form discharge planning terisi lengkap}}{\text{Total pasien DM dengan ulkus yang pulang}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan telaah kelengkapan form discharge planning
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, form discharge planning, SIMRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kelengkapan discharge planning pasien DM dengan ulkus
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien DM dengan ulkus yang pulang pada periode pengukuran (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang, serta analisis item yang paling sering tidak lengkap
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruangan Rawat Inap, Tim Edukasi/Case Manager, dan Komite Mutu Rumah Sakit

21. Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada Pasien DM dengan Ulkus
b) Dasar Pemikiran	Pasien Diabetes Melitus (DM) dengan ulkus memerlukan edukasi komprehensif terkait perawatan luka, kontrol gula darah, kepatuhan obat, nutrisi, aktivitas, serta tanda bahaya. Edukasi yang terdokumentasi dengan baik merupakan bagian penting dari kesinambungan asuhan dan pencegahan komplikasi serta amputasi. Oleh karena itu, kepatuhan pengisian form edukasi perlu dimonitor sebagai indikator mutu pelayanan.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Keselamatan (Safety), Berfokus pada Pasien, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Mengukur dan meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam memberikan dan mendokumentasikan edukasi kepada pasien DM dengan ulkus sesuai standar rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan pengisian form edukasi adalah kelengkapan dokumentasi pemberian edukasi kepada pasien DM dengan ulkus pada form edukasi yang mencakup materi wajib (perawatan luka, kontrol gula darah, terapi obat, diet, aktivitas, tanda bahaya, jadwal kontrol), disertai tanda tangan petugas dan pasien/keluarga.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien DM dengan ulkus yang form edukasinya terisi lengkap sesuai standar pada periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien DM dengan ulkus yang dirawat atau mendapatkan pelayanan pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 90% (atau sesuai kebijakan rumah sakit)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien DM dengan ulkus yang dirawat inap atau rawat jalan pada periode pengukuran. Eksklusi: Pasien dengan gangguan kesadaran berat tanpa pendamping, pasien meninggal dunia sebelum edukasi diberikan, atau pasien APS.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah form edukasi terisi lengkap}}{\text{Total pasien DM dengan ulkus}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan telaah kelengkapan form edukasi
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, form edukasi, SIMRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kelengkapan form edukasi pasien DM dengan ulkus
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien DM dengan ulkus pada periode pengukuran (total sampling atau sampling sesuai kebijakan RS)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), diagram batang, serta analisis item edukasi yang belum optimal
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruangan, Tim Edukasi/Case Manager, Komite Keperawatan, dan Komite Mutu Rumah Sakit

22. Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan PPK dan CP pada Pasien Diabetes Melitus (DM)
b) Dasar Pemikiran	Pelayanan pasien Diabetes Melitus (DM) memerlukan tata laksana yang terstandar untuk mencegah komplikasi akut maupun kronis. Penerapan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) bertujuan menjamin keseragaman dan mutu pelayanan sesuai evidence based practice. Monitoring kepatuhan diperlukan untuk memastikan pelayanan pasien DM sesuai standar yang ditetapkan rumah sakit.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas (Effectiveness), Keselamatan (Safety), Kepatuhan terhadap Standar, Efisiensi
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan tenaga medis dalam menerapkan PPK dan CP pada pasien DM guna meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan risiko komplikasi.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan PPK dan CP pasien DM adalah persentase pasien DM yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan elemen yang tercantum dalam Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) yang berlaku dan terdokumentasi lengkap di rekam medis.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien DM yang tata laksananya sesuai dengan PPK dan CP serta terdokumentasi lengkap pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh pasien dengan diagnosis DM yang dirawat atau mendapatkan pelayanan pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien dengan diagnosis Diabetes Melitus (rawat jalan maupun rawat inap sesuai kebijakan indikator). Eksklusi: Pasien DM dengan kondisi khusus/komorbid kompleks yang secara klinis memerlukan modifikasi tata laksana di luar CP serta terdokumentasi alasan medisnya.
l) Formula	$(\text{Jumlah pasien DM sesuai PPK dan CP} \div \text{Total pasien DM}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis (retrospektif) menggunakan checklist kesesuaian PPK dan CP.
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, dokumen PPK DM, dokumen Clinical Pathway DM.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kepatuhan PPK dan CP pasien DM.
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien DM pada periode pengukuran atau menggunakan metode sampling (misal 30 berkas per bulan sesuai ketentuan mutu).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), analisis kepatuhan per DPJP atau per unit pelayanan.
t) Penanggung Jawab	Ketua Komite Medik, DPJP terkait, Kepala Instalasi Rawat Jalan/Rawat Inap, Komite Mutu Rumah Sakit

23. Kejadian komplain pasien / keluarga di google review

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Komplain Pasien / Keluarga di Google Review
b) Dasar Pemikiran	Media digital seperti Google Review menjadi sarana umpan balik publik terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Komplain yang disampaikan pasien/keluarga dapat mencerminkan ketidakpuasan dan potensi masalah mutu pelayanan. Monitoring komplain diperlukan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement).
c) Dimensi Mutu	Responsivitas, Keselamatan (Safety), Efektivitas, Patient Centered Care
d) Tujuan	Mengidentifikasi, memonitor, dan menindaklanjuti komplain pasien/keluarga yang disampaikan melalui Google Review guna meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien.
e) Definisi Operasional	Kejadian komplain pasien/keluarga di Google Review adalah jumlah ulasan bernada negatif (rating ≤ 3 atau mengandung unsur keluhan pelayanan) yang diposting pada akun resmi rumah sakit dalam periode tertentu dan dapat diverifikasi kebenarannya.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome (hasil persepsi pelayanan)
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah ulasan Google Review yang mengandung komplain/keluhan terverifikasi pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh review pada akun resmi Google rumah sakit yang mengandung keluhan terkait pelayanan dan dapat diverifikasi. Eksklusi: Review spam, tidak relevan, tidak dapat diverifikasi, atau bukan terkait pelayanan rumah sakit.
l) Formula	$(\text{Jumlah review berisi komplain} \div \text{Total review}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Monitoring rutin akun Google Review rumah sakit dan verifikasi isi keluhan.
n) Sumber Data	Akun resmi Google Business/Google Review rumah sakit.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form rekapitulasi monitoring review online dan lembar tindak lanjut komplain.
p) Populasi / Sampel	Seluruh review yang masuk pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekap jumlah review dan komplain, grafik tren, analisis jenis keluhan terbanyak, serta laporan tindak lanjut.
t) Penanggung Jawab	Humas/Marketing Rumah Sakit, Unit Pengaduan Pelanggan, Komite Mutu Rumah Sakit

24. Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Petugas dalam Pemeliharaan Alat
b) Dasar Pemikiran	Pemeliharaan alat medis dan non medis secara rutin dan terjadwal sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien, keselamatan petugas, serta kelancaran pelayanan. Ketidakpatuhan terhadap jadwal dan prosedur pemeliharaan dapat menyebabkan kerusakan alat, gangguan pelayanan, bahkan risiko cedera. Oleh karena itu, diperlukan monitoring kepatuhan terhadap pelaksanaan pemeliharaan alat sesuai standar dan jadwal yang ditetapkan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas (Effectiveness), Efisiensi, Kepatuhan terhadap Standar
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan pemeliharaan alat sesuai jadwal dan prosedur guna menjamin kesiapan dan keamanan alat dalam pelayanan.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan pemeliharaan alat adalah persentase alat yang dilakukan pemeliharaan preventif sesuai jadwal dan terdokumentasi lengkap pada periode tertentu dibandingkan dengan seluruh alat yang seharusnya dilakukan pemeliharaan pada periode yang sama.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah alat yang telah dilakukan pemeliharaan sesuai jadwal dan terdokumentasi pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total alat yang dijadwalkan untuk dilakukan pemeliharaan pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh alat medis dan/atau non medis yang memiliki jadwal pemeliharaan rutin pada periode pengukuran. Eksklusi: Alat yang tidak aktif digunakan, dalam proses penghapusan, atau sedang dalam perbaikan besar (overhaul) dengan bukti dokumentasi resmi.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah alat yang dipelihara sesuai jadwal}}{\text{Total alat yang dijadwalkan pemeliharaan}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen pemeliharaan alat dan pengecekan fisik secara sampling.
n) Sumber Data	Jadwal pemeliharaan alat, buku log pemeliharaan, sistem manajemen aset/IPSRS.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit pemeliharaan alat dan rekap jadwal preventive maintenance.
p) Populasi / Sampel	Seluruh alat yang terjadwal pemeliharaan pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi kepatuhan, grafik tren (run chart), serta analisis per unit/instalasi.
t) Penanggung Jawab	Kepala IPSRS/Bagian Sarana Prasarana, Kepala Unit Terkait, Ko

25. Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Waktu Tunggu Obat Racikan < 60 Menit
b) Dasar Pemikiran	Waktu tunggu pelayanan farmasi merupakan salah satu indikator mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Standar pelayanan minimal rumah sakit mensyaratkan waktu tunggu obat racikan tidak melebihi 60 menit untuk menjamin efisiensi dan kenyamanan pasien. Monitoring indikator ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan farmasi.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi (Efficiency), Responsivitas, Patient Centered Care, Efektivitas
d) Tujuan	Memastikan pelayanan obat racikan diberikan secara tepat waktu sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan kelancaran pelayanan.
e) Definisi Operasional	Waktu tunggu obat racikan adalah selang waktu sejak resep diterima oleh instalasi farmasi sampai obat racikan selesai disiapkan dan diserahkan kepada pasien. Indikator dihitung sebagai persentase resep obat racikan yang diselesaikan dalam waktu ≤ 60 menit pada periode tertentu.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah resep obat racikan yang diselesaikan dan diserahkan kepada pasien dalam waktu ≤ 60 menit pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh resep obat racikan yang diterima instalasi farmasi pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≥ 90% resep obat racikan selesai ≤ 60 menit (dapat disesuaikan kebijakan RS).
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh resep obat racikan rawat jalan yang diterima dan diproses oleh instalasi farmasi. Eksklusi: Resep yang tertunda karena konfirmasi dokter, kekosongan obat, sistem gangguan IT, atau faktor eksternal yang terdokumentasi.
l) Formula	$(\text{Jumlah resep racikan} \leq 60 \text{ menit} \div \text{Total resep racikan}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Pencatatan waktu penerimaan resep dan waktu penyerahan obat melalui sistem informasi farmasi atau pencatatan manual (time stamp).
n) Sumber Data	Sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) / buku register farmasi.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring waktu tunggu resep racikan / laporan sistem time tracking.
p) Populasi / Sampel	Seluruh resep obat racikan pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi, grafik tren (run chart), serta analisis jam sibuk pelayanan.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi, Apoteker Penanggung Jawab, Komite Mutu Rumah Sakit

26. Ketidaklengkapan E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Ketidaklengkapan E-RM Pengkajian Awal IGD dan SPRI
b) Dasar Pemikiran	Pengkajian awal pasien di IGD dan pengisian SPRI (Surat Perintah Rawat Inap) merupakan bagian penting dalam kesinambungan pelayanan dan keselamatan pasien. Ketidaklengkapan pengisian E-RM dapat menyebabkan kesalahan terapi, keterlambatan pelayanan, serta masalah legal. Monitoring indikator ini diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan mutu dokumentasi klinis.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Kepatuhan terhadap Standar, Efektivitas, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Menurunkan angka ketidaklengkapan pengisian E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI sehingga menjamin mutu dokumentasi dan keselamatan pasien.
e) Definisi Operasional	Ketidaklengkapan E-RM adalah persentase berkas rekam medis elektronik pasien IGD dan SPRI yang tidak terisi lengkap sesuai standar elemen wajib pengkajian awal (misal: identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosa, rencana terapi, tanda tangan/verifikasi elektronik) pada periode tertentu.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI yang tidak lengkap sesuai standar pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI yang diaudit pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≤ 5% ketidaklengkapan (atau ≥ 95% kelengkapan, sesuai kebijakan rumah sakit).
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien IGD yang dibuatkan pengkajian awal dan SPRI dalam periode audit. Eksklusi: Berkas dengan gangguan sistem (error sistem terdokumentasi) atau kasus tertentu yang memiliki alasan klinis terdokumentasi.
l) Formula	$(\text{Jumlah E-RM tidak lengkap} \div \text{Total E-RM yang diaudit}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis elektronik secara retrospektif menggunakan checklist kelengkapan.
n) Sumber Data	Sistem Rekam Medis Elektronik (E-RM) / SIMRS.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit kelengkapan E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI.
p) Populasi / Sampel	Sampel rekam medis IGD dan SPRI (misal 30–50 berkas per bulan) atau total sampling sesuai kebijakan mutu.
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi persentase ketidaklengkapan, grafik tren (run chart), serta analisis elemen yang paling sering tidak lengkap.
t) Penanggung Jawab	Kepala IGD, Kepala Unit Rekam Medis, Komite Medik, Komite Mutu Rumah Sakit

27. Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Ketidakpatuhan Staf Medis dalam Penempatan Pasien Berdasarkan EWS
b) Dasar Pemikiran	Early Warning Score (EWS) digunakan untuk mendeteksi dini perburukan kondisi pasien dan menentukan tingkat monitoring serta penempatan perawatan yang sesuai (ruang rawat biasa, high care, ICU). Ketidakpatuhan dalam penempatan pasien sesuai skor EWS dapat meningkatkan risiko keterlambatan penanganan dan kejadian tidak diharapkan. Monitoring diperlukan untuk menjamin keselamatan pasien.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Kepatuhan terhadap Standar, Responsivitas
d) Tujuan	Menurunkan kejadian ketidakpatuhan dalam penempatan pasien sesuai hasil penilaian EWS guna mencegah keterlambatan penanganan kondisi kritis.
e) Definisi Operasional	Ketidakpatuhan penempatan pasien berdasarkan EWS adalah kejadian dimana pasien dengan skor EWS tertentu tidak ditempatkan atau tidak mendapatkan tingkat monitoring sesuai dengan ketentuan/protokol rumah sakit pada periode tertentu.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome (kejadian ketidakesesuaian)
g) Satuan Pengukuran	Angka (Jumlah Kejadian)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien dengan skor EWS yang penempatannya tidak sesuai dengan protokol pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	-
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat inap yang dinilai menggunakan EWS dan memiliki skor yang mengharuskan penempatan/eskalasi monitoring tertentu. Eksklusi: Pasien dengan kondisi khusus yang secara klinis memiliki justifikasi terdokumentasi untuk tidak mengikuti rekomendasi standar EWS.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah ketidakesesuaian penempatan berdasarkan EWS}}{\text{Total pasien dengan skor EWS yang memerlukan penempatan khusus}} \times 100\% \right)$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan observasi kesesuaian skor EWS dengan lokasi perawatan pasien.
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, lembar monitoring EWS, buku register rawat inap/ICU.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kepatuhan penempatan pasien berdasarkan EWS.
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien dengan skor EWS yang memerlukan eskalasi perawatan pada periode pengukuran (total sampling atau sampling sesuai kebijakan mutu).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan

s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi jumlah dan persentase kejadian, grafik tren, serta analisis penyebab (root cause analysis) bila ditemukan kejadian.
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala ICU, Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

28. Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Asuhan Medis Dokter IGD
b) Dasar Pemikiran	IGD merupakan unit dengan risiko tinggi karena kondisi pasien yang gawat dan membutuhkan keputusan cepat. Kesalahan asuhan medis (misdiagnosis, kesalahan terapi, keterlambatan tindakan, atau kesalahan prosedur) dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien. Monitoring kejadian ini penting untuk meningkatkan mutu klinis dan keselamatan pasien.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Kepatuhan terhadap Standar, Manajemen Risiko
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD guna meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan.
e) Definisi Operasional	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD adalah setiap tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi, PPK, SPO, atau clinical pathway yang berlaku, yang berpotensi atau telah menimbulkan dampak terhadap pasien dan telah diverifikasi melalui proses audit klinis atau pelaporan insiden keselamatan pasien (IKP).
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome (kejadian klinis)
g) Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian atau Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD yang terverifikasi pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total jumlah kunjungan pasien IGD pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	0 kejadian sentinel; tren menurun untuk kejadian minor ($\leq 1\%$ dari total kunjungan).
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD yang telah diverifikasi melalui audit medis atau laporan IKP. Eksklusi: Komplikasi penyakit yang bukan akibat kesalahan medis dan telah sesuai standar pelayanan.
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Pelaporan insiden keselamatan pasien (incident reporting), audit medis, telaah rekam medis.
n) Sumber Data	Laporan IKP, rekam medis IGD, hasil audit klinis, notulen rapat komite medik.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form pelaporan insiden keselamatan pasien dan form audit medis IGD.
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien IGD pada periode pengukuran (total sampling terhadap laporan kejadian).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi jumlah kejadian, grafik tren, klasifikasi tingkat keparahan (KNC, KTC, KTD, Sentinel), serta analisis akar masalah (RCA) bila diperlukan.
t) Penanggung Jawab	Kepala IGD, Ketua Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

29. Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP

Komponen	Uraian
Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Asuhan Medis oleh DPJP
Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien
Tujuan	Menurunkan dan mencegah kejadian kesalahan asuhan medis oleh DPJP untuk meningkatkan keselamatan dan mutu pelayanan klinis
Definisi Operasional	Jumlah kejadian kesalahan asuhan medis yang dilakukan oleh DPJP berdasarkan hasil audit klinis, laporan insiden keselamatan pasien, atau telaah kasus
Numerator	Jumlah kejadian kesalahan asuhan medis DPJP
Denominator	Jumlah pasien yang ditangani oleh DPJP
Rumus	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
Standar	0 kejadian
Sumber Data	Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), rekam medis
Metode Pengumpulan Data	Audit klinis, laporan insiden
Periode Pengumpulan Data	Harian
Unit Kerja Terkait	Rawat Inap, Rawat Jalan, Komite Medis
Penanggung Jawab	Komite Medis / Ketua SMF
Analisis Data	Root Cause Analysis (RCA) pada setiap kejadian
Pelaporan	Direksi, Komite Mutu, Komite Medis
Tindak Lanjut	Pembinaan DPJP, kredensial ulang, perbaikan SOP dan clinical pathway

30. Ketidakpatuhan DPJP dalam pelaksanaan visite pasien

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Ketidakpatuhan DPJP dalam Pelaksanaan Visite Pasien
b) Dasar Pemikiran	Visite DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) merupakan bagian penting dalam pemantauan perkembangan pasien, evaluasi terapi, dan pengambilan keputusan klinis. Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan visite sesuai ketentuan rumah sakit dapat berdampak pada keterlambatan intervensi medis dan menurunkan mutu pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan monitoring kepatuhan visite DPJP.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Kontinuitas Pelayanan, Kepatuhan terhadap Standar
d) Tujuan	Menurunkan kejadian ketidakpatuhan DPJP dalam pelaksanaan visite pasien guna menjamin kesinambungan dan mutu pelayanan medis.
e) Definisi Operasional	Ketidakpatuhan visite DPJP adalah kejadian dimana DPJP tidak melaksanakan visite sesuai ketentuan (frekuensi dan waktu yang ditetapkan rumah sakit) dan/atau tidak mendokumentasikan hasil visite di rekam medis pada periode tertentu.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus pasien rawat inap dimana DPJP tidak melakukan atau tidak mendokumentasikan visite sesuai ketentuan pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien rawat inap yang menjadi tanggung jawab DPJP dan seharusnya mendapatkan visite pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat inap yang berada dalam tanggung jawab DPJP pada periode audit. Eksklusi: Pasien dengan kondisi tertentu yang memiliki justifikasi tertulis (misalnya pasien sudah rencana pulang sebelum jadwal visite atau kondisi force majeure terdokumentasi).
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah ketidakpatuhan visite DPJP}}{\text{Total pasien yang harus divisite}}\right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan daftar visite harian DPJP.
n) Sumber Data	Rekam medis pasien rawat inap, buku visite/daftar visite harian, SIMRS.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit kepatuhan visite DPJP.
p) Populasi / Sampel	Sampel rekam medis pasien rawat inap (misal 30–50 berkas per bulan) atau total sampling sesuai kebijakan mutu.
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi persentase ketidakpatuhan, grafik tren (run chart), analisis per DPJP atau per unit pelayanan.
t) Penanggung Jawab	Ketua Komite Medik, Kepala Ruang Rawat Inap, Komite Mutu Rumah Sakit

31. Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Ketidaklengkapan E-RM Asuhan Pasien Selama di Rawat Inap
b) Dasar Pemikiran	Rekam Medis Elektronik (E-RM) merupakan dokumen legal dan sumber utama informasi klinis dalam pelayanan pasien. Ketidaklengkapan dokumentasi asuhan selama rawat inap dapat berdampak pada keselamatan pasien, kesinambungan pelayanan, klaim pembiayaan, serta aspek hukum. Oleh karena itu, diperlukan monitoring untuk menjamin kelengkapan pengisian E-RM sesuai standar.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Kepatuhan terhadap Standar, Efektivitas, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Menurunkan angka ketidaklengkapan pengisian E-RM asuhan pasien selama rawat inap guna meningkatkan mutu dokumentasi dan keselamatan pasien.
e) Definisi Operasional	Ketidaklengkapan E-RM adalah persentase rekam medis elektronik pasien rawat inap yang tidak terisi lengkap sesuai elemen wajib dokumentasi asuhan (pengkajian, diagnosa, rencana terapi, implementasi, evaluasi, instruksi medis, verifikasi DPJP, dan tanda tangan elektronik) pada periode tertentu.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah E-RM pasien rawat inap yang tidak lengkap sesuai standar pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total E-RM pasien rawat inap yang diaudit pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh rekam medis elektronik pasien rawat inap yang telah selesai dirawat (pasien pulang) pada periode audit. Eksklusi: Rekam medis dengan gangguan sistem (error IT terdokumentasi) atau kasus khusus dengan justifikasi tertulis.
l) Formula	$(\text{Jumlah E-RM tidak lengkap} \div \text{Total E-RM yang diaudit}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis elektronik secara retrospektif menggunakan checklist kelengkapan dokumentasi.
n) Sumber Data	Sistem Rekam Medis Elektronik (E-RM) / SIMRS.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit kelengkapan E-RM asuhan pasien rawat inap.
p) Populasi / Sampel	Sampel rekam medis pasien rawat inap (misal 30–50 berkas per bulan) atau total sampling sesuai kebijakan mutu.
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi persentase ketidaklengkapan, grafik tren (run chart), serta analisis elemen yang paling sering tidak lengkap per profesi (dokter, perawat, dll.).
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit Rekam Medis, Kepala Ruang Rawat Inap, Ketua Komite Medik, Komite Mutu Rumah Sakit

32. Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Ketidaklengkapan E-RM Asuhan Pasien Selama di ICU dan HCU
b) Dasar Pemikiran	ICU dan HCU merupakan unit dengan tingkat kompleksitas dan risiko tinggi sehingga membutuhkan dokumentasi asuhan yang lengkap, akurat, dan real time. Ketidaklengkapan E-RM dapat berdampak pada keselamatan pasien, kesalahan terapi, hambatan komunikasi tim, serta aspek legal. Monitoring diperlukan untuk menjamin kepatuhan dokumentasi sesuai standar pelayanan intensif.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Kepatuhan terhadap Standar, Efektivitas, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Menurunkan angka ketidaklengkapan E-RM asuhan pasien di ICU dan HCU guna meningkatkan mutu dokumentasi dan keselamatan pasien kritis.
e) Definisi Operasional	Ketidaklengkapan E-RM adalah persentase rekam medis elektronik pasien ICU dan HCU yang tidak terisi lengkap sesuai elemen wajib dokumentasi (pengkajian awal dan lanjutan, monitoring harian, catatan perkembangan, instruksi medis, verifikasi DPJP, catatan tindakan, dan tanda tangan elektronik) pada periode tertentu.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah E-RM pasien ICU dan HCU yang tidak lengkap sesuai standar pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total E-RM pasien ICU dan HCU yang diaudit pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh rekam medis elektronik pasien ICU dan HCU yang telah selesai perawatan (pindah ruang/pulang/meninggal) pada periode audit. Eksklusi: Rekam medis dengan gangguan sistem terdokumentasi atau kasus tertentu dengan justifikasi tertulis.
l) Formula	$(\text{Jumlah E-RM tidak lengkap} \div \text{Total E-RM yang diaudit}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis elektronik secara retrospektif menggunakan checklist kelengkapan khusus ICU/HCU.
n) Sumber Data	Sistem Rekam Medis Elektronik (E-RM), SIMRS, dan catatan monitoring ICU/HCU.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit kelengkapan E-RM asuhan pasien ICU dan HCU.
p) Populasi / Sampel	Sampel rekam medis pasien ICU dan HCU (misal 20–30 berkas per bulan) atau total sampling sesuai kebijakan mutu.
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi persentase ketidaklengkapan, grafik tren (run chart), serta analisis elemen yang paling sering tidak lengkap per profesi (dokter, perawat, dll.).

t) Penanggung Jawab	Kepala ICU/HCU, Kepala Unit Rekam Medis, Ketua Komite Medik, Komite Mutu Rumah Sakit
---------------------	--

33. Kejadian Kesalahan saat hand over (serah terima)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Saat Hand Over (Serah Terima)
b) Dasar Pemikiran	Hand over (serah terima) merupakan proses komunikasi kritis antar tenaga kesehatan dalam pergantian shift atau antar unit pelayanan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan informasi klinis, keterlambatan tindakan, dan kejadian tidak diharapkan. Monitoring kejadian kesalahan saat hand over diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu komunikasi klinis.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Kontinuitas Pelayanan, Kepatuhan terhadap Standar
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan kejadian kesalahan komunikasi saat hand over guna meningkatkan keselamatan dan kesinambungan pelayanan pasien.
e) Definisi Operasional	Kejadian kesalahan saat hand over adalah setiap insiden yang terjadi akibat informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak disampaikan saat proses serah terima pasien antar shift atau antar unit, yang telah diverifikasi melalui laporan insiden atau audit internal.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome (kejadian insiden komunikasi)
g) Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian atau Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan yang terjadi akibat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan informasi saat hand over pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total jumlah proses hand over yang dilakukan pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh kejadian kesalahan yang terjadi akibat proses hand over dan telah diverifikasi melalui laporan insiden keselamatan pasien (IKP). Eksklusi: Kejadian yang tidak terkait dengan proses hand over atau tidak dapat diverifikasi.
l) Formula	$\frac{\text{(Jumlah kejadian kesalahan saat hand over)}}{\text{Total proses hand over}} \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Pelaporan insiden keselamatan pasien, observasi langsung proses hand over, dan audit dokumentasi serah terima.
n) Sumber Data	Laporan IKP, buku serah terima shift, rekam medis pasien.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form pelaporan insiden keselamatan pasien dan checklist audit hand over (misal menggunakan metode SBAR).
p) Populasi / Sampel	Seluruh proses hand over pada periode pengukuran (total sampling terhadap laporan kejadian).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekap jumlah kejadian, grafik tren, klasifikasi tingkat keparahan (KNC, KTC, KTD, Sentinel), serta analisis akar masalah (RCA) bila ditemukan kejadian serius.
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruangan, Kepala Instalasi Terkait, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

34. Kejadian Keterlambatan pemasangan intubasi pasien

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Keterlambatan Pemasangan Intubasi Pasien
b) Dasar Pemikiran	Pemasangan intubasi merupakan tindakan emergensi pada pasien dengan gangguan jalan napas atau gagal napas. Keterlambatan tindakan dapat menyebabkan hipoksia, henti jantung, kerusakan organ, bahkan kematian. Oleh karena itu, diperlukan monitoring untuk memastikan tindakan intubasi dilakukan secara cepat dan tepat sesuai indikasi klinis.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Responsivitas, Efektivitas, Manajemen Risiko
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan kejadian keterlambatan pemasangan intubasi guna meningkatkan keselamatan pasien dalam kondisi kritis.
e) Definisi Operasional	Kejadian keterlambatan pemasangan intubasi adalah tindakan intubasi yang dilakukan melebihi standar waktu respon yang ditetapkan rumah sakit sejak indikasi klinis ditegakkan atau keputusan intubasi dibuat, tanpa adanya alasan medis yang terdokumentasi.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome (kejadian klinis)
g) Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian atau Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian keterlambatan pemasangan intubasi yang terverifikasi pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien yang memiliki indikasi dilakukan intubasi pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	0 kejadian keterlambatan
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien dengan indikasi intubasi ICU pada periode audit. Eksklusi: Kasus dengan alasan medis atau kondisi teknis yang terdokumentasi secara jelas (misal: stabilisasi awal, persiapan alat khusus).
l) Formula	$(\text{Jumlah kejadian keterlambatan intubasi} \div \text{Total pasien dengan indikasi intubasi}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis, telaah kronologi tindakan, dan pelaporan insiden keselamatan pasien.
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, catatan tindakan emergensi, laporan IKP, buku register ICU.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kasus intubasi dan form pelaporan insiden keselamatan pasien.
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien dengan indikasi intubasi pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekap jumlah kejadian, grafik tren, analisis waktu respon rata-rata, serta analisis akar masalah (RCA) untuk kejadian serius.
t) Penanggung Jawab	Kepala ICU, Ketua Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

35. Kepatuhan DPJP terhadap Jadwal Praktek

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan DPJP terhadap Jadwal Praktek
b) Dasar Pemikiran	Kepatuhan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) terhadap jadwal praktek yang telah ditetapkan berpengaruh terhadap waktu tunggu pasien, kepuasan pasien, serta kelancaran pelayanan. Ketidaksesuaian jadwal dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan dan komplain pasien. Oleh karena itu, diperlukan monitoring kepatuhan terhadap jadwal praktek yang telah ditetapkan rumah sakit.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi (Efficiency), Responsivitas, Patient Centered Care, Kepatuhan terhadap Standar
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap jadwal praktek guna menjamin ketepatan waktu pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan DPJP terhadap jadwal praktek adalah persentase kehadiran dan pelaksanaan pelayanan oleh DPJP sesuai hari dan jam praktek yang telah ditetapkan rumah sakit pada periode tertentu.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah sesi praktek DPJP yang dilaksanakan sesuai jadwal (tepat hari dan waktu) pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total sesi jadwal praktek DPJP yang telah ditetapkan pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≥ 95% kepatuhan terhadap jadwal praktek (sesuai kebijakan rumah sakit).
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh jadwal praktek DPJP yang telah ditetapkan secara resmi oleh rumah sakit. Eksklusi: Ketidakhadiran dengan alasan resmi dan terdokumentasi (cuti, tugas luar, pelatihan, sakit) serta telah dilakukan pengganti (cover) sesuai kebijakan rumah sakit.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah sesi praktek yang terlaksana sesuai jadwal}}{\text{Total sesi jadwal praktek}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Monitoring daftar hadir DPJP, absensi elektronik/manual, dan buku jadwal praktek.
n) Sumber Data	Jadwal praktek resmi rumah sakit, daftar hadir, SIMRS/absensi elektronik.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form rekapitulasi kepatuhan jadwal praktek DPJP.
p) Populasi / Sampel	Seluruh DPJP dengan jadwal praktek pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi persentase kepatuhan per DPJP, grafik tren, dan analisis keterlambatan rata-rata.
t) Penanggung Jawab	Ketua Komite Medik, Bagian SDM/HRD, Komite Mutu Rumah Sakit

t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Pelayanan Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
---------------------	---

36. Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di irja

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Ketidaklengkapan E-RM Asuhan Pasien Selama di IRJA
b) Dasar Pemikiran	Rekam Medis Elektronik (E-RM) yang lengkap dan akurat merupakan bagian penting dari mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Ketidaklengkapan dokumentasi asuhan di Instalasi Rawat Jalan (IRJA) dapat mengganggu kontinuitas pelayanan, klaim pembiayaan, serta berisiko terhadap aspek legal dan keselamatan pasien. Oleh karena itu diperlukan monitoring terhadap kelengkapan E-RM di IRJA.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Kepatuhan terhadap Standar, Manajemen Risiko
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam melengkapi dokumentasi E-RM asuhan pasien di IRJA sesuai standar yang ditetapkan rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Ketidaklengkapan E-RM asuhan pasien di IRJA adalah kondisi dimana terdapat elemen wajib dokumentasi (anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, rencana terapi, resep, edukasi, tanda tangan/verifikasi elektronik) yang tidak terisi lengkap dalam E-RM pada hari pelayanan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah rekam medis pasien IRJA yang tidak lengkap sesuai standar pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total rekam medis pasien IRJA yang diaudit pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≤ 5% ketidaklengkapan atau ≥ 95% kelengkapan dokumentasi.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh rekam medis pasien IRJA yang telah selesai pelayanan pada periode audit. Eksklusi: Rekam medis pasien batal pelayanan atau kunjungan administratif tanpa tindakan klinis.
l) Formula	$(\text{Jumlah E-RM tidak lengkap} \div \text{Total E-RM yang diaudit}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis secara sampling atau total sampling menggunakan checklist kelengkapan E-RM.
n) Sumber Data	Sistem Rekam Medis Elektronik (SIMRS/E-RM).
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit kelengkapan E-RM IRJA.
p) Populasi / Sampel	Sampel rekam medis IRJA (misal 10–20% per bulan) atau total sampling sesuai kebijakan rumah sakit.
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kelengkapan per poli/DPJP, grafik tren, serta analisis komponen yang paling sering tidak lengkap.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan, Unit Rekam Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

37. Target Pasien PRB dan iterasi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Capaian Target Pasien PRB dan Iterasi di Rawat Jalan
b) Dasar Pemikiran	Program Rujuk Balik (PRB) dan pelayanan resep iterasi bertujuan meningkatkan kesinambungan terapi pasien penyakit kronis yang stabil, mengurangi kepadatan layanan spesialisik, serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Monitoring capaian target PRB dan iterasi diperlukan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai kebijakan dan target rumah sakit.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Efisiensi, Continuity of Care, Patient Centered Care
d) Tujuan	Meningkatkan jumlah pasien yang memenuhi kriteria PRB dan iterasi sesuai target yang ditetapkan rumah sakit atau regulator.
e) Definisi Operasional	Capaian target PRB dan iterasi adalah persentase pasien penyakit kronis stabil yang memenuhi kriteria dan telah didaftarkan dalam Program Rujuk Balik (PRB) atau mendapatkan resep iterasi sesuai ketentuan pada periode pengukuran.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien yang terdaftar dalam PRB dan/atau mendapatkan resep iterasi sesuai kriteria pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien penyakit kronis stabil yang memenuhi kriteria PRB atau iterasi pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≥ 90% dari pasien yang memenuhi kriteria
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien penyakit kronis stabil (misalnya DM, hipertensi, jantung, asma, dll.) yang memenuhi kriteria PRB/iterasi sesuai pedoman. Eksklusi: Pasien dengan kondisi tidak stabil, komplikasi akut, atau tidak memenuhi syarat administratif.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pasien PRB dan/atau iterasi}}{\text{Total pasien yang memenuhi kriteria}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap data SIMRS, laporan unit rawat jalan, dan laporan PRB/iterasi.
n) Sumber Data	SIMRS, data klaim, laporan poli spesialis, dan laporan farmasi.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form rekap monitoring PRB dan iterasi bulanan.
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien penyakit kronis yang memenuhi kriteria pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel capaian per poli/DPJP, grafik tren bulanan, serta analisis hambatan pelaksanaan PRB dan iterasi.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Instalasi Farmasi, Komite Medik, Komite Mutu

38. Pelayanan tidak sesuai program terapi (fisioterapi)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Pelayanan Fisioterapi Tidak Sesuai Program Terapi
b) Dasar Pemikiran	Pelayanan fisioterapi harus dilaksanakan sesuai program terapi yang telah ditetapkan berdasarkan asesmen dan instruksi medis. Ketidaksesuaian pelaksanaan terapi dapat mempengaruhi hasil klinis pasien, memperpanjang masa terapi, serta menurunkan mutu pelayanan. Oleh karena itu diperlukan monitoring kepatuhan terhadap program terapi yang telah direncanakan.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Keselamatan (Safety), Kepatuhan terhadap Standar, Continuity of Care
d) Tujuan	Menurunkan kejadian pelayanan fisioterapi yang tidak sesuai dengan program terapi yang telah ditetapkan.
e) Definisi Operasional	Pelayanan fisioterapi tidak sesuai program terapi adalah pelaksanaan tindakan fisioterapi yang tidak sesuai dengan rencana terapi yang terdokumentasi (jenis tindakan, frekuensi, durasi, atau teknik), tanpa adanya revisi program yang sah dan terdokumentasi.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus pelayanan fisioterapi yang tidak sesuai dengan program terapi yang terdokumentasi pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total kasus pelayanan fisioterapi yang diaudit pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≤ 5% ketidaksesuaian atau ≥ 95% kepatuhan terhadap program terapi.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien yang mendapatkan pelayanan fisioterapi dengan program terapi tertulis/elektronik. Eksklusi: Perubahan terapi yang telah direvisi dan terdokumentasi secara resmi oleh dokter/fisioterapis.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pelayanan tidak sesuai program}}{\text{Total pelayanan fisioterapi yang diaudit}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan catatan tindakan fisioterapi menggunakan checklist kesesuaian program.
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, program terapi fisioterapi, dan catatan tindakan harian fisioterapis.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kesesuaian pelayanan fisioterapi terhadap program terapi.
p) Populasi / Sampel	Sampel pelayanan fisioterapi per bulan (misal 10–20%) atau total sampling sesuai kebijakan.
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kepatuhan per fisioterapis/unit, grafik tren, serta analisis jenis ketidaksesuaian yang paling sering terjadi.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik/Fisioterapi, Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

39. Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Ketidaklengkapan E-RM Asuhan Pasien Selama di Maternitas
b) Dasar Pemikiran	Dokumentasi Rekam Medis Elektronik (E-RM) yang lengkap di unit maternitas sangat penting untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi, kesinambungan pelayanan, aspek legal, serta kelancaran klaim pembiayaan. Ketidaklengkapan dokumentasi dapat meningkatkan risiko klinis dan administratif. Oleh karena itu diperlukan monitoring rutin terhadap kelengkapan E-RM di unit maternitas.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Kepatuhan terhadap Standar, Manajemen Risiko
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam melengkapi dokumentasi E-RM asuhan pasien di unit maternitas sesuai standar yang berlaku.
e) Definisi Operasional	Ketidaklengkapan E-RM maternitas adalah kondisi dimana terdapat elemen wajib dokumentasi yang tidak terisi lengkap dan benar, seperti asesmen awal ibu, catatan perkembangan persalinan (partograf), tindakan medis/kebidanan, monitoring ibu dan bayi, informed consent, resume medis, serta verifikasi elektronik oleh tenaga kesehatan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah rekam medis pasien maternitas yang tidak lengkap sesuai standar pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total rekam medis pasien maternitas yang diaudit pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≤ 5% ketidaklengkapan atau ≥ 95% kelengkapan dokumentasi.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh rekam medis pasien maternitas (persalinan normal, tindakan operatif, perawatan nifas) yang telah selesai pelayanan pada periode audit. Eksklusi: Kasus rujukan keluar sebelum tindakan atau pasien batal pelayanan tanpa tindakan klinis.
l) Formula	$(\text{Jumlah E-RM tidak lengkap} \div \text{Total E-RM yang diaudit}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis menggunakan checklist kelengkapan E-RM maternitas.
n) Sumber Data	Sistem Rekam Medis Elektronik (SIMRS/E-RM), partograf elektronik/manual yang terdokumentasi.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist audit kelengkapan E-RM maternitas.
p) Populasi / Sampel	Sampel rekam medis maternitas (misal 10–20% per bulan) atau total sampling sesuai kebijakan rumah sakit.
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kelengkapan per ruangan/DPJP/bidan, grafik tren, serta analisis komponen yang paling sering tidak lengkap.
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruang Maternitas, Kepala Instalasi Kebidanan, Unit Rekam Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

40. Angka kematian ibu

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kematian Ibu (AKI) di Rumah Sakit
b) Dasar Pemikiran	Angka Kematian Ibu merupakan indikator utama mutu pelayanan kebidanan dan maternitas. Kematian ibu mencerminkan kualitas pelayanan antenatal, intrapartum, dan postpartum, serta kesiapan fasilitas dalam menangani komplikasi obstetri. Monitoring AKI penting untuk evaluasi sistem pelayanan dan pencegahan kematian yang dapat dicegah (preventable death).
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Manajemen Risiko, Continuity of Care
d) Tujuan	Menurunkan angka kematian ibu dan mengidentifikasi faktor penyebab kematian untuk dilakukan perbaikan sistem pelayanan.
e) Definisi Operasional	Kematian ibu adalah kematian seorang perempuan saat hamil, bersalin, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, yang disebabkan oleh penyebab terkait atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, dan bukan karena sebab kecelakaan atau insidental.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Rasio per 1.000 kelahiran hidup atau jumlah kasus
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kematian ibu yang terjadi di rumah sakit dalam periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Jumlah kelahiran hidup di rumah sakit pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	0 kematian yang dapat dicegah (preventable death) atau sesuai target internal/regulator.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh kematian ibu yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan ≤ 42 hari postpartum yang dirawat di rumah sakit. Eksklusi: Kematian akibat kecelakaan atau penyebab yang tidak berhubungan dengan kehamilan.
l) Formula	$(\text{Jumlah kematian ibu} \div \text{Jumlah kelahiran hidup}) \times 1.000$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi data maternitas, laporan kematian, dan audit maternal perinatal.
n) Sumber Data	Rekam medis, register persalinan, laporan kematian, laporan komite medis.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kematian maternal dan laporan surveilans kematian ibu.
p) Populasi / Sampel	Seluruh kasus persalinan dan kematian ibu dalam periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan (direkap tahunan).
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan, termasuk audit kasus per kasus.
s) Penyajian Data	Rasio AKI per 1.000 kelahiran hidup, grafik tren tahunan, serta analisis akar masalah melalui Audit Maternal Perinatal (AMP).
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas, Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Audit Maternal Perinatal

41. Kejadian perdarahan post partum

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Perdarahan Post Partum (PPP)
b) Dasar Pemikiran	Perdarahan post partum merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu. Monitoring kejadian PPP penting untuk mengevaluasi mutu pelayanan persalinan, kesiapan tenaga kesehatan, serta efektivitas tata laksana aktif kala III dan penanganan komplikasi obstetri.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Manajemen Risiko
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan angka kejadian perdarahan post partum melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan obstetri.
e) Definisi Operasional	Perdarahan post partum adalah kehilangan darah ≥ 500 ml setelah persalinan pervaginam atau ≥ 1.000 ml setelah seksio sesarea, atau perdarahan yang menyebabkan instabilitas hemodinamik dalam 24 jam pertama setelah persalinan.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus perdarahan post partum pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total persalinan (pervaginam dan seksio sesarea) pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh ibu yang melahirkan di rumah sakit (normal maupun operatif). Eksklusi: Pasien rujukan dengan perdarahan yang sudah terjadi sebelum masuk rumah sakit (dicatat terpisah sebagai kasus rujukan).
l) Formula	$(\text{Jumlah kasus PPP} \div \text{Total persalinan}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi register persalinan, audit rekam medis maternitas, dan laporan komplikasi obstetri.
n) Sumber Data	Rekam medis, partograf, laporan tindakan obstetri, dan laporan komplikasi.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit komplikasi obstetri dan checklist manajemen PPP.
p) Populasi / Sampel	Seluruh persalinan pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel dan grafik tren kejadian PPP, analisis faktor risiko, serta evaluasi kepatuhan manajemen aktif kala III.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas, Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Audit Maternal Perinatal

42. Kejadian partus macet

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Partus Macet
b) Dasar Pemikiran	Partus macet merupakan komplikasi persalinan yang dapat meningkatkan risiko perdarahan, infeksi, ruptur uteri, asfiksia neonatorum, hingga kematian ibu dan bayi. Monitoring kejadian partus macet penting untuk mengevaluasi kualitas pemantauan persalinan (partograf), ketepatan pengambilan keputusan klinis, serta kesiapan tindakan operatif.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Manajemen Risiko, Continuity of Care
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan kejadian partus macet melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar pemantauan dan tata laksana persalinan.
e) Definisi Operasional	Partus macet adalah persalinan yang tidak mengalami kemajuan sesuai kurva partograf atau terjadi hambatan kemajuan persalinan (misalnya pembukaan tidak bertambah dalam ≥ 2 jam pada fase aktif atau tidak terjadi penurunan kepala janin), sehingga memerlukan intervensi medis atau operatif.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus partus macet pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total persalinan pervaginam pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	$\leq$ standar internal rumah sakit (misal $\leq 5\%$) atau tren menurun setiap tahun.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh persalinan pervaginam yang dipantau di rumah sakit. Eksklusi: Persalinan dengan indikasi seksio sesarea elektif sebelum inpartu atau kasus rujukan dengan partus macet yang sudah terjadi sebelum masuk rumah sakit (dicatat terpisah).
l) Formula	$(\text{Jumlah kasus partus macet} \div \text{Total persalinan pervaginam}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit register persalinan, telaah partograf, dan rekam medis maternitas.
n) Sumber Data	Rekam medis, partograf, laporan tindakan obstetri, dan laporan komplikasi.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit komplikasi persalinan dan checklist kepatuhan pengisian partograf.
p) Populasi / Sampel	Seluruh persalinan pervaginam pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel dan grafik tren kejadian, analisis faktor risiko, serta evaluasi kepatuhan penggunaan partograf.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas, Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Audit Maternal Perinatal

43. Kejadian eklamsi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Eklamsi
b) Dasar Pemikiran	Eklamsi merupakan komplikasi berat dari preeklampsia yang ditandai dengan kejang pada ibu hamil, bersalin, atau nifas, dan berisiko tinggi menyebabkan kematian ibu dan janin. Monitoring kejadian eklamsi penting untuk mengevaluasi deteksi dini preeklampsia, kepatuhan tata laksana, serta kesiapan penanganan kegawatdaruratan obstetri.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Manajemen Risiko
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan kejadian eklamsi melalui peningkatan skrining, monitoring, dan tata laksana preeklampsia sesuai standar.
e) Definisi Operasional	Eklamsi adalah terjadinya kejang umum dan/atau koma pada ibu hamil, bersalin, atau dalam masa nifas (≤ 42 hari postpartum) yang tidak disebabkan oleh kondisi neurologis lain, dan berhubungan dengan preeklampsia.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus eklamsi yang terjadi pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total persalinan pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	$\leq$ standar internal rumah sakit (misal $\leq 1-2\%$) atau tren menurun setiap tahun; 0 kasus yang dapat dicegah (preventable).
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh ibu hamil, bersalin, atau nifas yang mengalami eklamsi selama dirawat di rumah sakit. Eksklusi: Pasien rujukan dengan eklamsi yang sudah terjadi sebelum masuk rumah sakit (dicatat terpisah sebagai kasus rujukan).
l) Formula	$(\text{Jumlah kasus eklamsi} \div \text{Total persalinan}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap register maternitas, audit rekam medis, dan laporan komplikasi obstetri.
n) Sumber Data	Rekam medis, partograf, laporan tindakan obstetri, dan laporan komplikasi.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit komplikasi obstetri dan checklist tata laksana preeklampsia/eklamsi.
p) Populasi / Sampel	Seluruh persalinan dalam periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel dan grafik tren kejadian eklamsi, analisis faktor risiko, serta evaluasi kepatuhan pemberian MgSO_4 dan monitoring tekanan darah.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas, Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Audit Maternal Perinatal

44. Kejadian pre eklamsi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Preeklampsia
b) Dasar Pemikiran	Preeklampsia merupakan salah satu komplikasi utama kehamilan yang dapat berkembang menjadi eklamsi, sindrom HELLP, perdarahan, hingga kematian ibu dan janin. Monitoring kejadian preeklampsia penting untuk mengevaluasi kualitas skrining antenatal, deteksi dini, dan tata laksana hipertensi dalam kehamilan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Manajemen Risiko, Continuity of Care
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan kejadian preeklampsia serta mencegah progresi menjadi komplikasi berat melalui peningkatan deteksi dan penatalaksanaan sesuai standar.
e) Definisi Operasional	Preeklampsia adalah kondisi hipertensi pada kehamilan (≥ 20 minggu) dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg yang disertai proteinuria atau tanda gangguan organ lainnya, sesuai pedoman klinis yang berlaku.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus preeklampsia yang terdiagnosis pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total ibu hamil yang melahirkan atau dirawat karena kehamilan pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	Sesuai standar internal rumah sakit (misal $\leq 5\text{--}10\%$) atau tren stabil/menurun dengan 0 kasus yang tidak tertangani sesuai standar.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh ibu hamil ≥ 20 minggu yang terdiagnosis preeklampsia saat dirawat di rumah sakit. Eksklusi: Hipertensi kronis tanpa tanda preeklampsia atau kasus rujukan dengan diagnosis sebelum masuk (dicatat terpisah untuk analisis rujukan).
l) Formula	$(\text{Jumlah kasus preeklampsia} \div \text{Total ibu hamil yang dirawat/melahirkan}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap register maternitas, audit rekam medis antenatal dan persalinan, serta laporan komplikasi obstetri.
n) Sumber Data	Rekam medis, buku register ANC, partograf, dan laporan komplikasi.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit hipertensi dalam kehamilan dan checklist kepatuhan tata laksana.
p) Populasi / Sampel	Seluruh ibu hamil yang dirawat/melahirkan pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel dan grafik tren kejadian, klasifikasi ringan/berat, serta analisis kepatuhan manajemen (monitoring TD, lab, pemberian MgSO_4 bila indikasi).
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas, Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Audit Maternal Perinatal

45. Kejadian infeksi nifas

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Infeksi Nifas (Puerperal Infection)
b) Dasar Pemikiran	Infeksi nifas merupakan salah satu komplikasi masa postpartum yang dapat meningkatkan morbiditas ibu dan berkontribusi terhadap kematian maternal. Monitoring kejadian infeksi nifas penting untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip pencegahan infeksi, teknik aseptik, serta tata laksana perawatan postpartum.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Manajemen Risiko
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan kejadian infeksi nifas melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar pencegahan infeksi dan tata laksana postpartum.
e) Definisi Operasional	Infeksi nifas adalah infeksi pada traktus genitalia atau organ terkait yang terjadi dalam ≤ 42 hari setelah persalinan, ditandai dengan demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ selama ≥ 2 hari berturut-turut (tidak termasuk 24 jam pertama), disertai tanda klinis seperti nyeri abdomen bawah, lochia berbau, atau tanda infeksi luka operasi.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus infeksi nifas yang terdiagnosis pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total persalinan (normal dan seksio sesarea) pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	$\leq$ standar internal rumah sakit (misal $\leq 2\text{--}5\%$) atau tren menurun setiap tahun.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh ibu postpartum ≤ 42 hari yang terdiagnosis infeksi nifas saat dirawat atau kontrol di rumah sakit. Eksklusi: Infeksi yang sudah terjadi sebelum masuk rumah sakit atau infeksi non-obstetri yang tidak berhubungan dengan persalinan.
l) Formula	$(\text{Jumlah kasus infeksi nifas} \div \text{Total persalinan}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap register maternitas, audit rekam medis postpartum, dan laporan surveilans infeksi.
n) Sumber Data	Rekam medis, laporan persalinan, laporan PPI, dan laporan kontrol nifas.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit komplikasi postpartum dan checklist surveilans infeksi.
p) Populasi / Sampel	Seluruh persalinan dalam periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel dan grafik tren kejadian, klasifikasi berdasarkan jenis persalinan, serta analisis faktor risiko dan kepatuhan PPI.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas, Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

46. Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Non MKJP

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi (MKJP dan Non-MKJP)
b) Dasar Pemikiran	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan, risiko komplikasi kehamilan, dan kematian ibu. Monitoring capaian pelayanan KB per metode, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) maupun Non-MKJP, penting untuk mengevaluasi akses, pilihan metode, dan efektivitas program.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Aksesibilitas, Patient Centered Care, Continuity of Care
d) Tujuan	Meningkatkan cakupan pelayanan KB serta memastikan ketersediaan dan pemanfaatan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan pasien.
e) Definisi Operasional	Angka capaian pelayanan KB adalah persentase akseptor KB yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi berdasarkan jenis metode dalam periode pengukuran. MKJP meliputi IUD, implan, MOW, dan MOP. Non-MKJP meliputi pil, suntik, kondom, dan metode jangka pendek lainnya.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses / Cakupan Pelayanan
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%) per metode
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi sesuai metode tertentu (MKJP atau Non-MKJP) pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total akseptor KB yang mendapatkan pelayanan pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	Sesuai target internal/program (misal $\geq 40\%$ MKJP dari total akseptor KB, atau sesuai target regulator).
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh akseptor KB yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit pada periode pengukuran. Eksklusi: Konseling tanpa tindakan pemasangan/pemberian kontrasepsi.
l) Formula	$(\text{Jumlah akseptor per metode} \div \text{Total akseptor KB}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap pelayanan KB dari unit maternitas/rawat jalan dan laporan program KB.
n) Sumber Data	Register KB, rekam medis, SIMRS, laporan program KB.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form rekapitulasi capaian pelayanan KB per metode.
p) Populasi / Sampel	Seluruh akseptor KB pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel distribusi persentase per metode, grafik tren MKJP vs Non-MKJP, serta analisis preferensi metode.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas/KB, Koordinator Program KB, Komite Mutu

47. Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
b) Dasar Pemikiran	Pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran merupakan strategi penting untuk mencegah kehamilan yang terlalu cepat, menurunkan risiko komplikasi maternal, serta mendukung perencanaan keluarga yang sehat. Monitoring capaian indikator ini penting untuk memastikan setiap ibu mendapatkan konseling dan akses kontrasepsi sebelum pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Continuity of Care, Patient Centered Care, Aksesibilitas
d) Tujuan	Meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran sesuai standar program kesehatan reproduksi.
e) Definisi Operasional	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran adalah persentase ibu yang mendapatkan metode kontrasepsi (MKJP atau Non-MKJP) sebelum pulang atau dalam masa nifas awal setelah persalinan/keguguran pada periode pengukuran.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses / Cakupan Pelayanan
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah ibu pasca persalinan dan pasca keguguran yang mendapatkan pelayanan KB pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total ibu pasca persalinan dan pasca keguguran pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≥ 60–80% sesuai target internal/program/regulator.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh ibu yang melahirkan atau mengalami keguguran dan dirawat di rumah sakit pada periode pengukuran. Eksklusi: Ibu dengan kontraindikasi medis terhadap kontrasepsi atau menolak setelah konseling (didokumentasikan).
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah ibu mendapat KB pasca persalinan/keguguran}}{\text{Total ibu pasca persalinan/keguguran}} \times 100\% \right)$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap register persalinan dan keguguran, laporan pelayanan KB, dan audit rekam medis.
n) Sumber Data	Rekam medis maternitas, register persalinan, laporan program KB, SIMRS.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form rekapitulasi pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran.
p) Populasi / Sampel	Seluruh ibu pasca persalinan dan pasca keguguran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase capaian, grafik tren bulanan, serta distribusi metode (MKJP vs Non-MKJP).
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas/KB, Koordinator Program KB, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

48. Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca keguguran

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Tidak Dilakukannya KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
b) Dasar Pemikiran	Tidak dilakukannya pelayanan KB pada ibu pasca persalinan dan pasca keguguran meningkatkan risiko kehamilan berulang dalam jarak waktu dekat (unmet need), yang berpotensi meningkatkan komplikasi maternal dan neonatal. Monitoring indikator ini penting untuk mengevaluasi efektivitas konseling dan akses pelayanan KB sebelum pasien pulang.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Continuity of Care, Patient Centered Care, Manajemen Risiko
d) Tujuan	Menurunkan proporsi ibu pasca persalinan dan pasca keguguran yang tidak mendapatkan pelayanan KB, serta memastikan konseling dan dokumentasi dilakukan dengan baik.
e) Definisi Operasional	Kejadian tidak dilakukannya KB adalah kondisi dimana ibu pasca persalinan atau pasca keguguran tidak mendapatkan metode kontrasepsi sebelum pulang atau dalam masa nifas awal, tanpa adanya kontraindikasi medis atau penolakan tertulis setelah konseling.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome / Gap Pelayanan
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah ibu pasca persalinan dan pasca keguguran yang tidak mendapatkan pelayanan KB pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total ibu pasca persalinan dan pasca keguguran pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≤ 20% (atau sesuai target internal/program), dengan 100% terdokumentasi konseling KB.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh ibu pasca persalinan dan pasca keguguran pada periode pengukuran. Eksklusi: Ibu dengan kontraindikasi medis atau yang menolak KB setelah konseling dan terdokumentasi dalam rekam medis.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah ibu tidak mendapat KB}}{\text{Total ibu pasca persalinan/keguguran}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit register persalinan dan keguguran, rekap pelayanan KB, serta telaah rekam medis.
n) Sumber Data	Rekam medis maternitas, register persalinan, laporan pelayanan KB, SIMRS.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit pelayanan dan konseling KB pasca persalinan/keguguran.
p) Populasi / Sampel	Seluruh ibu pasca persalinan dan pasca keguguran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kejadian, grafik tren, analisis alasan tidak dilakukan KB (administratif, stok, tenaga, konseling tidak optimal).
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas/KB, Koordinator Program KB, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

49. Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Tidak Dilakukan Edukasi RSSIB pada Pasien Post Partum dan Post SC
b) Dasar Pemikiran	Edukasi RSSIB (Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi) pada pasien post partum dan post sectio caesarea (SC) sangat penting untuk mendukung keberhasilan menyusui, perawatan ibu dan bayi, serta pencegahan komplikasi. Tidak dilakukannya edukasi dapat berdampak pada rendahnya keberhasilan ASI eksklusif dan kurangnya kesiapan ibu dalam perawatan mandiri di rumah. Oleh karena itu perlu dilakukan monitoring kepatuhan edukasi RSSIB.
c) Dimensi Mutu	Patient Centered Care, Efektivitas, Keselamatan (Safety), Continuity of Care
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam memberikan dan mendokumentasikan edukasi RSSIB kepada seluruh pasien post partum dan post SC.
e) Definisi Operasional	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB adalah kondisi dimana pasien post partum atau post SC tidak mendapatkan edukasi sesuai standar RSSIB (misalnya IMD, ASI eksklusif, perawatan bayi, tanda bahaya ibu dan bayi, KB pasca persalinan) dan tidak terdokumentasi dalam rekam medis.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien post partum dan post SC yang tidak mendapatkan atau tidak terdokumentasi edukasi RSSIB pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	-
j) Target Pencapaian	≤ 5% kejadian atau ≥ 95% pasien mendapatkan edukasi RSSIB terdokumentasi.
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien post partum (normal maupun SC) yang dirawat di rumah sakit. Eksklusi: Pasien dengan kondisi gawat darurat berat yang tidak memungkinkan diberikan edukasi sebelum dirujuk/meninggal (didokumentasikan).
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pasien tidak mendapat edukasi RSSIB}}{\text{Total pasien post partum dan post SC}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis dan checklist edukasi RSSIB.
n) Sumber Data	Rekam medis maternitas, form edukasi pasien, dan SIMRS.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kepatuhan edukasi RSSIB.
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien post partum dan post SC (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kepatuhan edukasi, grafik tren, serta analisis komponen edukasi yang paling sering tidak diberikan.

t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Maternitas, Tim RSSIB, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
---------------------	--

50. Angka Kematian Bayi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kematian Bayi (AKB)
b) Dasar Pemikiran	Angka Kematian Bayi merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan maternal–neonatal. Tingginya kematian bayi mencerminkan masalah dalam pelayanan antenatal, persalinan, perawatan neonatal, serta sistem rujukan. Monitoring AKB penting untuk evaluasi mutu pelayanan dan upaya penurunan risiko kematian.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Keselamatan (Safety), Akses dan Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Menurunkan angka kematian bayi melalui peningkatan mutu pelayanan perinatal dan neonatal serta sistem deteksi dan tata laksana dini komplikasi.
e) Definisi Operasional	Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi usia 0–11 bulan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama. Dalam konteks rumah sakit, dihitung berdasarkan kematian bayi yang lahir hidup di fasilitas tersebut.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Per 1.000 kelahiran hidup
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kematian bayi usia 0–11 bulan pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	Mengacu pada target nasional / target internal rumah sakit (misalnya < 10 per 1.000 kelahiran hidup untuk RS rujukan dengan risiko terkontrol).
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua bayi lahir hidup dan tercatat pada periode pengukuran. Eksklusi: Bayi lahir mati (stillbirth) tidak dihitung sebagai kelahiran hidup.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia 0–11 bulan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \right) \times 1.000$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap laporan kelahiran hidup dan kematian bayi, audit kematian (perinatal/neonatal review).
n) Sumber Data	Register persalinan, register neonatus, rekam medis, laporan kematian, SIMRS.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form rekap kelahiran dan kematian bayi, form audit kematian neonatal.
p) Populasi / Sampel	Total populasi (seluruh kelahiran hidup dan kematian bayi).
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel AKB per periode, grafik tren tahunan, analisis penyebab kematian (BBLR, asfiksia, infeksi, prematuritas, kelainan kongenital).
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Perinatologi/Neonatal, Kepala Instalasi Maternitas, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

51. Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Keterlambatan Pemasangan Intubasi pada Pasien dengan Indikasi
b) Dasar Pemikiran	Intubasi endotrakeal pada pasien dengan indikasi kegawatdaruratan (gagal napas, penurunan kesadaran, henti napas, distress respirasi berat) merupakan tindakan penyelamatan jiwa. Keterlambatan pemasangan dapat meningkatkan risiko hipoksia, kerusakan organ, hingga kematian. Monitoring indikator ini penting untuk menjamin respons cepat dan kesiapan tim kegawatdaruratan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan (Safety), Efektivitas, Ketepatan Waktu (Timeliness)
d) Tujuan	Memastikan tindakan intubasi dilakukan secara tepat waktu sesuai standar klinis pada pasien dengan indikasi.
e) Definisi Operasional	Keterlambatan pemasangan intubasi adalah tindakan intubasi yang dilakukan melebihi batas waktu standar sejak indikasi ditegakkan atau sejak pasien dinyatakan membutuhkan airway definitif (misalnya >10–15 menit di IGD/ruang rawat tanpa alasan klinis yang dapat dipertanggungjawabkan dan terdokumentasi).
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien dengan indikasi intubasi yang mengalami keterlambatan pemasangan pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien dengan indikasi intubasi pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua pasien dengan indikasi klinis intubasi (gagal napas, GCS ≤ 8, henti napas, distress berat, dll.). Eksklusi: Pasien dengan DNR (Do Not Resuscitate), penolakan keluarga, atau kondisi khusus dengan pertimbangan klinis terdokumentasi.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah keterlambatan intubasi}}{\text{Total pasien dengan indikasi intubasi}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis, lembar observasi IGD/ICU, dan catatan waktu tindakan (time stamp).
n) Sumber Data	Rekam medis, logbook tindakan IGD/ICU, SIMRS.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit response time tindakan airway management.
p) Populasi / Sampel	Total sampling seluruh kasus dengan indikasi intubasi.
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase keterlambatan, grafik tren response time, analisis penyebab (ketersediaan alat, tenaga, komunikasi tim, overload pasien).
t) Penanggung Jawab	Kepala IGD, Kepala ICU, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

52. Kejadian SHK yang di tolak Dinkes

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian SHK yang Ditolak Dinkes
b) Dasar Pemikiran	Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) merupakan program nasional untuk deteksi dini gangguan tiroid pada bayi baru lahir. Penolakan sampel SHK oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan penanganan, sehingga perlu dilakukan pemantauan mutu untuk memastikan kualitas pengambilan dan pengiriman sampel sesuai standar.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Efektivitas, Ketepatan Waktu
d) Tujuan	Mengurangi kejadian penolakan sampel SHK oleh Dinkes melalui peningkatan kualitas pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman sampel.
e) Definisi Operasional	Kejadian SHK yang ditolak Dinkes adalah jumlah sampel skrining hipotiroid kongenital yang tidak diterima/ditolak oleh Dinas Kesehatan karena tidak memenuhi kriteria (misalnya: sampel tidak sesuai standar, pengisian identitas tidak lengkap, atau keterlambatan pengiriman).
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah sampel SHK yang ditolak oleh Dinkes pada periode pengukuran
i) Denominator (Penyebut)	-
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua sampel SHK yang dikirim ke Dinkes. Eksklusi: Sampel yang belum dikirim, sampel rusak sebelum pengiriman, atau data tidak terdokumentasi.
l) Formula	$(\text{Jumlah sampel SHK ditolak} / \text{Total sampel SHK dikirim}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit laporan SHK, register bayi baru lahir, dan laporan pengiriman sampel ke Dinkes
n) Sumber Data	Buku register SHK, rekam medis, laporan laboratorium, SIMRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit SHK, checklist kelengkapan sampel, logbook pengiriman
p) Populasi / Sampel	Total sampling seluruh sampel SHK yang dikirim
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase penolakan, grafik tren, analisis penyebab (misal: kesalahan teknik pengambilan, keterlambatan pengiriman, kelengkapan data)
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruangan Perinatologi/NICU, Petugas Laboratorium, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

53. Kejadian re operasi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Re-Operasi
b) Dasar Pemikiran	Re-operasi merupakan tindakan operasi ulang yang dilakukan akibat komplikasi atau ketidaksempurnaan hasil operasi sebelumnya. Tingginya angka re-operasi dapat mencerminkan masalah dalam kualitas pelayanan bedah, keselamatan pasien, serta ketepatan prosedur klinis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan sebagai indikator mutu layanan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan angka kejadian re-operasi melalui peningkatan kualitas tindakan bedah dan perawatan pasca operasi
e) Definisi Operasional	Kejadian re-operasi adalah tindakan operasi ulang yang dilakukan pada pasien yang sama dalam periode tertentu (misalnya ≤ 30 hari dari operasi pertama) akibat komplikasi, kegagalan tindakan sebelumnya, atau indikasi klinis lain yang berhubungan dengan operasi awal
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien yang mengalami re-operasi dalam periode pengukuran
i) Denominator (Penyebut)	-
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua pasien yang menjalani operasi dan mengalami re-operasi terkait tindakan awal dalam ≤ 30 hari. Eksklusi: Re-operasi yang direncanakan (staged surgery), operasi lanjutan yang memang menjadi bagian dari terapi, atau kasus rujukan dari RS lain
l) Formula	$(\text{Jumlah kejadian re-operasi} / \text{Total operasi}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis, laporan operasi, dan re

54. Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO

Komponen	Uraian
Judul Indikator	Ketidaklengkapan pengisian E-RM laporan operasi dan anestesi/sedasi pasien selama di IKO
Unit Terkait	Instalasi Kamar Operasi (IKO), Rekam Medis
Jenis Indikator	Indikator Outcome
Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien & Kepatuhan Dokumentasi
Tujuan	Menurunkan angka ketidaklengkapan dokumentasi laporan operasi dan anestesi/sedasi dalam E-Rekam Medis untuk menjamin mutu, legalitas, dan kesinambungan pelayanan
Definisi Operasional	Persentase E-RM laporan operasi dan anestesi/sedasi yang tidak terisi lengkap sesuai standar rumah sakit dalam periode audit
Numerator	Jumlah laporan operasi dan anestesi/sedasi yang tidak lengkap
Denominator	Jumlah seluruh laporan operasi dan anestesi/sedasi yang diaudit
Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
Target / Standar	0
Kriteria Ketidaklengkapan	- Tidak ada laporan operasi lengkap - Tidak ada laporan anestesi/sedasi - Tidak mencantumkan diagnosis pre/post operasi - Tidak mencantumkan jenis anestesi - Tidak ada tanda tangan/validasi DPJP atau dokter anestesi - Tidak mencatat komplikasi/tindakan intraoperatif
Metode Pengumpulan Data	Audit E-Rekam Medis
Sumber Data	Sistem E-RM, logbook operasi, laporan anestesi
Frekuensi Pengumpulan Data	Bulanan
Unit / Penanggung Jawab	Kepala IKO, Komite Medik, Unit Rekam Medis
Kriteria Inklusi	Semua pasien yang menjalani operasi atau tindakan dengan anestesi/sedasi di IKO
Kriteria Eksklusi	Tindakan minor tanpa anestesi/sedasi sesuai kebijakan RS
Analisis Data	Deskriptif (persentase dan tren ketidaklengkapan)
Pelaporan	Dilaporkan kepada Komite Medik dan Komite Mutu
Tindak Lanjut	Penguatan kewajiban pengisian E-RM sebelum pasien keluar dari IKO, notifikasi sistem (hard stop), audit berkala dan umpan balik ke DPJP/anestesi

55. Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi

Komponen	Uraian
Judul Indikator	Keterlambatan hasil Patologi Anatomi sesuai regulasi
Unit Terkait	Instalasi Patologi Anatomi / Laboratorium
Jenis Indikator	Indikator Outcome
Dimensi Mutu	Efektivitas Pelayanan & Keselamatan Pasien
Tujuan	Menjamin hasil pemeriksaan Patologi Anatomi tersedia tepat waktu sesuai regulasi dan standar pelayanan rumah sakit
Definisi Operasional	Persentase hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang melebihi waktu standar penyelesaian (Turn Around Time/TAT) sesuai regulasi atau kebijakan rumah sakit
Numerator	Jumlah hasil Patologi Anatomi yang selesai melebihi waktu standar (TAT)
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan Patologi Anatomi dalam periode pengukuran
Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
Target / Standar	0%
Standar Waktu (TAT)	Sesuai regulasi/kebijakan RS, misal ≤ 5 hari kerja untuk histopatologi rutin
Metode Pengumpulan Data	Audit tanggal penerimaan spesimen dan tanggal hasil terbit
Sumber Data	Logbook Patologi Anatomi, SIMRS/LIS
Frekuensi Pengumpulan Data	Bulanan
Unit / Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Patologi Anatomi
Kriteria Inklusi	Semua pemeriksaan Patologi Anatomi rutin
Kriteria Eksklusi	Pemeriksaan khusus (imunohistokimia, konsultasi eksternal) yang memerlukan waktu tambahan sesuai kebijakan
Analisis Data	Deskriptif (Analisa penyebab keterlambatan)
Pelaporan	Dilaporkan kepada Manajemen dan Komite Mutu
Tindak Lanjut	Evaluasi alur kerja, pemantauan beban kerja, koordinasi pengiriman spesimen, penguatan sistem tracking spesimen

56. Kejadian Ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien

Komponen	Uraian
Judul Indikator	Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien
Unit Terkait	Instalasi Radiologi
Jenis Indikator	Indikator Outcome
Dimensi Mutu	Akurasi Diagnostik & Keselamatan Pasien
Tujuan	Menurunkan kejadian ketidaksesuaian interpretasi hasil radiologi dengan kondisi klinis pasien untuk meningkatkan ketepatan diagnosis dan terapi
Definisi Operasional	Hasil interpretasi radiologi yang dinyatakan tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien setelah dilakukan evaluasi/audit klinis atau second opinion
Numerator	Jumlah hasil bacaan radiologi yang terbukti tidak sesuai dengan klinis pasien
Denominator	-
Formula	-
Target / Standar	0
Kriteria Ketidakcocokan	- Perbedaan signifikan antara hasil radiologi dan temuan klinis/operatif - Koreksi diagnosis melalui audit klinis/second reading - Berdampak pada perubahan terapi
Metode Pengumpulan Data	Audit klinis, review kasus, dan second reading
Sumber Data	Laporan radiologi, rekam medis pasien, hasil audit klinis
Frekuensi Pengumpulan Data	Triwulanan
Unit / Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Radiologi, Komite Medik
Kriteria Inklusi	Pemeriksaan radiologi yang dilakukan audit atau memiliki indikasi ketidaksesuaian
Kriteria Eksklusi	Variasi minor yang tidak berdampak klinis
Analisis Data	Deskriptif (persentase dan analisis penyebab)
Pelaporan	Dilaporkan kepada Komite Medik dan Komite Mutu
Tindak Lanjut	Audit klinis berkala, second reading rutin, diskusi kasus (clinical meeting), peningkatan kompetensi dokter radiologi

57. Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi

Komponen	Uraian
Judul Indikator	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai regulasi
Unit Terkait	Instalasi Radiologi
Jenis Indikator	Indikator Outcome
Dimensi Mutu	Efektivitas Pelayanan & Keselamatan Pasien
Tujuan	Menjamin hasil pemeriksaan radiologi tersedia tepat waktu sesuai standar/regulasi untuk mendukung keputusan klinis yang cepat dan tepat
Definisi Operasional	Persentase hasil pemeriksaan radiologi yang melebihi waktu standar penyelesaian (Turn Around Time/TAT) sesuai regulasi atau kebijakan rumah sakit
Numerator	Jumlah hasil radiologi yang selesai melebihi waktu standar (TAT)
Denominator	-
Formula	-
Target / Standar	0
Standar Waktu (TAT)	Misal:- IGD: ≤ 1 jam- Rawat Inap: ≤ 24 jam- Rawat Jalan: ≤ 1 x 24 jam(<i>disesuaikan dengan SPO RS</i>)
Metode Pengumpulan Data	Audit waktu permintaan pemeriksaan dan waktu hasil tervalidasi
Sumber Data	SIMRS/RIS, logbook radiologi
Frekuensi Pengumpulan Data	Bulanan
Unit / Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Radiologi
Kriteria Inklusi	Semua pemeriksaan radiologi rutin
Kriteria Eksklusi	Pemeriksaan khusus (CT kontras kompleks, MRI khusus, atau rujukan eksternal) sesuai kebijakan
Analisis Data	Deskriptif (persentase keterlambatan dan analisis penyebab)
Pelaporan	Dilaporkan kepada Manajemen dan Komite Mutu
Tindak Lanjut	Evaluasi alur kerja, pembagian beban kerja dokter radiologi, optimalisasi sistem RIS, monitoring rutin TAT

58. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh Petugas Pengolahan
b) Dasar Pemikiran	Penggunaan APD merupakan upaya penting dalam mencegah risiko paparan bahaya kerja, seperti infeksi, bahan kimia, maupun cedera fisik pada petugas pengolahan (misalnya pengolahan limbah medis, laundry, CSSD, atau dapur). Ketidakpatuhan penggunaan APD dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan infeksi nosokomial sehingga perlu dilakukan pemantauan sebagai indikator mutu.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Keamanan, Efektivitas
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan petugas pengolahan dalam menggunakan APD sesuai standar untuk mencegah risiko kerja dan infeksi
e) Definisi Operasional	Kepatuhan penggunaan APD adalah kesesuaian penggunaan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, apron, pelindung mata, sepatu pelindung, dll) oleh petugas pengolahan sesuai dengan standar/prosedur yang berlaku pada saat melakukan pekerjaan
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah petugas pengolahan yang menggunakan APD sesuai standar saat dilakukan observasi
i) Denominator (Penyebut)	Total petugas pengolahan yang diobservasi
j) Target Pencapaian	≥ 100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh petugas pengolahan (limbah medis, laundry, CSSD, dapur) yang sedang bekerja dan diobservasi. Eksklusi: Petugas yang tidak sedang melakukan aktivitas kerja atau tidak terpapar risiko langsung
l) Formula	$(\text{Jumlah petugas patuh menggunakan APD} / \text{Total petugas yang diobservasi}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung menggunakan checklist kepatuhan APD
n) Sumber Data	Hasil observasi lapangan, laporan PPI/K3RS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist kepatuhan APD
p) Populasi / Sampel	Sampling petugas pengolahan sesuai jadwal observasi
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel kepatuhan APD, grafik tren, analisis ketidakpatuhan (misalnya: ketersediaan APD, kepatuhan perilaku, pengawasan)
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit Terkait, Tim PPI, Tim K3RS, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

59. Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien oleh Penyaji
b) Dasar Pemikiran	Identifikasi pasien merupakan bagian penting dari keselamatan pasien untuk mencegah kesalahan pemberian layanan, termasuk pemberian makanan/diet. Ketidakpatuhan dalam identifikasi pasien oleh penyaji dapat menyebabkan kesalahan diet yang berdampak pada kondisi klinis pasien, sehingga perlu dilakukan pemantauan sebagai indikator mutu.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Efektivitas
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan penyaji dalam melakukan identifikasi pasien secara benar sebelum memberikan makanan/diet
e) Definisi Operasional	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji adalah kesesuaian pelaksanaan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (misalnya nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis) sebelum pemberian makanan kepada pasien sesuai standar yang berlaku
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah penyaji yang melakukan identifikasi pasien dengan benar saat pemberian makanan
i) Denominator (Penyebut)	Total penyaji yang diobservasi saat pemberian makanan
j) Target Pencapaian	≥ 100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh penyaji makanan pasien yang sedang melakukan distribusi makanan dan diobservasi. Eksklusi: Penyaji yang tidak sedang bertugas atau tidak melakukan distribusi makanan
l) Formula	$(\text{Jumlah penyaji yang patuh melakukan identifikasi pasien} / \text{Total penyaji yang diobservasi}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung saat distribusi makanan menggunakan checklist
n) Sumber Data	Hasil observasi lapangan, laporan instalasi gizi
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist identifikasi pasien
p) Populasi / Sampel	Sampling penyaji makanan sesuai jadwal observasi
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel kepatuhan, grafik tren, analisis ketidakpatuhan (misalnya: tidak melakukan identifikasi dua identitas, terburu-buru, kurangnya edukasi)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi, Tim PPI, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

60. Angka Kelengkapan Asuhan Gizi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kelengkapan Asuhan Gizi
b) Dasar Pemikiran	Asuhan gizi merupakan bagian integral dari pelayanan pasien yang meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi gizi. Ketidaklengkapan dokumentasi asuhan gizi dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan asuhan gizi terdokumentasi secara lengkap dan sesuai standar.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Keselamatan Pasien, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Meningkatkan kelengkapan dokumentasi asuhan gizi sesuai standar pelayanan gizi di rumah sakit
e) Definisi Operasional	Angka kelengkapan asuhan gizi adalah persentase rekam medis pasien yang memiliki dokumentasi asuhan gizi lengkap meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi sesuai standar yang berlaku
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah rekam medis pasien dengan asuhan gizi yang terdokumentasi lengkap sesuai standar
i) Denominator (Penyebut)	Total rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan asuhan gizi
j) Target Pencapaian	≥ 95%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien yang mendapatkan pelayanan asuhan gizi. Eksklusi: Rekam medis yang tidak lengkap karena pasien pulang paksa atau data tidak tersedia
l) Formula	$(\text{Jumlah rekam medis dengan asuhan gizi lengkap} / \text{Total rekam medis pasien dengan asuhan gizi}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis pasien
n) Sumber Data	Rekam medis, catatan asuhan gizi, SIMRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kelengkapan asuhan gizi
p) Populasi / Sampel	Sampling rekam medis pasien yang mendapatkan asuhan gizi
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kelengkapan, grafik tren, analisis ketidaklengkapan (misalnya: pengkajian tidak lengkap, diagnosis tidak ditulis, evaluasi tidak terdokumentasi)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi, Ahli Gizi, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

61. Kejadian kesalahan pemberian diet

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemberian Diet
b) Dasar Pemikiran	Pemberian diet yang tepat sesuai kondisi klinis pasien merupakan bagian penting dalam terapi. Kesalahan pemberian diet (jenis, jumlah, atau waktu) dapat berdampak pada keselamatan pasien dan memperburuk kondisi klinis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk mencegah dan menurunkan kejadian kesalahan pemberian diet.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Efektivitas, Ketepatan
d) Tujuan	Menurunkan kejadian kesalahan pemberian diet kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan gizi
e) Definisi Operasional	Kejadian kesalahan pemberian diet adalah setiap ketidaksesuaian antara diet yang diberikan kepada pasien dengan diet yang seharusnya berdasarkan instruksi medis/ahli gizi (misalnya salah jenis diet, salah pasien, salah porsi, atau salah waktu pemberian)
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pemberian diet dalam periode pengukuran
i) Denominator (Penyebut)	-
j) Target Pencapaian	zero error
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua kejadian kesalahan pemberian diet pada pasien rawat inap. Eksklusi: Perubahan diet yang sudah dikonfirmasi dan didokumentasikan sesuai prosedur
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah kejadian kesalahan pemberian diet}}{\text{Total pemberian diet}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Pelaporan insiden, observasi langsung, dan audit rekam medis
n) Sumber Data	Laporan insiden keselamatan pasien, catatan instalasi gizi

62. Kejadian adanya benda asing dalam makanan

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Adanya Benda Asing dalam Makanan
b) Dasar Pemikiran	Keamanan pangan merupakan aspek penting dalam pelayanan gizi rumah sakit. Adanya benda asing dalam makanan (misalnya rambut, serangga, plastik, logam, dll) dapat membahayakan pasien dan menurunkan mutu pelayanan serta kepercayaan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Keamanan, Efektivitas
d) Tujuan	Menurunkan dan mencegah kejadian adanya benda asing dalam makanan yang disajikan kepada pasien
e) Definisi Operasional	Kejadian adanya benda asing dalam makanan adalah ditemukannya benda yang tidak seharusnya terdapat dalam makanan yang disajikan kepada pasien, baik sebelum maupun saat dikonsumsi
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pada periode pengukuran
i) Denominator (Penyebut)	
j) Target Pencapaian	zero incident
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien. Eksklusi: Benda yang memang merupakan bagian dari bahan makanan dan aman dikonsumsi
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Pelaporan insiden, observasi, dan audit proses pengolahan makanan
n) Sumber Data	Laporan insiden keselamatan pasien, laporan instalasi gizi, keluhan pasien
o) Instrumen Pengambilan Data	Form laporan insiden, checklist higiene dan sanitasi makanan
p) Populasi / Sampel	Total seluruh porsi makanan pasien
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel kejadian, grafik tren, analisis penyebab (misalnya: higiene petugas, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi makanan)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi, Petugas Pengolahan Makanan, Tim PPI, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

63. Kejadian makanan basi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Makanan Basi
b) Dasar Pemikiran	Makanan yang basi atau tidak layak konsumsi dapat membahayakan kesehatan pasien dan menurunkan mutu pelayanan gizi rumah sakit. Kejadian ini dapat disebabkan oleh proses pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Keamanan, Efektivitas
d) Tujuan	Mencegah dan menurunkan kejadian makanan basi yang disajikan kepada pasien
e) Definisi Operasional	Kejadian makanan basi adalah ditemukannya makanan yang sudah tidak layak konsumsi (misalnya berbau, berubah rasa/warna/tekstur) saat sebelum atau pada saat diberikan kepada pasien
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian makanan basi yang ditemukan dalam periode pengukuran
i) Denominator (Penyebut)	Total porsi makanan yang disajikan kepada pasien dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	0% (zero incident)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua kejadian makanan basi yang ditemukan sebelum atau saat distribusi kepada pasien. Eksklusi: Makanan yang tidak dikonsumsi karena alasan non-kualitas (misalnya pasien tidak nafsu makan)
l) Formula	$(\text{Jumlah kejadian makanan basi} / \text{Total porsi makanan disajikan}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi, pelaporan insiden, dan audit proses pengolahan serta distribusi makanan
n) Sumber Data	Laporan instalasi gizi, laporan insiden keselamatan pasien, keluhan pasien
o) Instrumen Pengambilan Data	Form laporan insiden, checklist higiene sanitasi makanan
p) Populasi / Sampel	Total seluruh porsi makanan pasien
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel kejadian, grafik tren, analisis penyebab (misalnya: penyimpanan tidak sesuai suhu, keterlambatan distribusi, proses pengolahan tidak higienis)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi, Petugas Pengolahan Makanan, Tim PPI, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

64. Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan > 30 Menit
b) Dasar Pemikiran	Pelayanan farmasi yang cepat dan tepat merupakan bagian penting dalam mutu pelayanan rumah sakit. Keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan dapat menurunkan kepuasan pasien dan berpotensi mengganggu keberlanjutan terapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar.
c) Dimensi Mutu	Ketepatan Waktu, Efisiensi, Kepuasan Pasien
d) Tujuan	Menurunkan angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan lebih dari 30 menit
e) Definisi Operasional	Keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan adalah waktu tunggu pasien sejak penyerahan resep hingga obat diterima pasien melebihi 30 menit untuk obat non racikan
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah resep obat jadi rawat jalan yang waktu penyediaannya > 30 menit
i) Denominator (Penyebut)	Total resep obat jadi rawat jalan yang dilayani
j) Target Pencapaian	≤ 10% (atau sesuai kebijakan RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua resep obat jadi (non racikan) rawat jalan. Eksklusi: Resep racikan, resep dengan obat tidak tersedia (stok kosong), atau resep yang ditunda atas permintaan pasien
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah resep dengan waktu tunggu} > 30 \text{ menit}}{\text{Total resep obat jadi rawat jalan}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Pencatatan waktu pelayanan resep (time tracking), observasi, dan audit sistem farmasi
n) Sumber Data	SIMRS, sistem informasi farmasi, log pelayanan resep
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring waktu tunggu pelayanan obat
p) Populasi / Sampel	Total sampling seluruh resep obat jadi rawat jalan
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase keterlambatan, grafik tren, analisis penyebab (misalnya: antrean tinggi, keterbatasan SDM, sistem pelayanan, ketersediaan obat)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi, Apoteker Penanggung Jawab, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

65. Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap
b) Dasar Pemikiran	Retur obat rawat inap yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan ketidaksesuaian stok, pemborosan biaya, serta potensi risiko keselamatan pasien. Kepatuhan dalam proses retur obat penting untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan keamanan penggunaan obat di rumah sakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan sebagai indikator mutu.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Keselamatan Pasien, Akuntabilitas
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pelaksanaan retur obat rawat inap sesuai standar prosedur
e) Definisi Operasional	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap adalah setiap ketidaksesuaian dalam proses pengembalian obat dari unit perawatan ke instalasi farmasi yang tidak sesuai dengan prosedur (misalnya: obat tidak dikembalikan, dokumentasi tidak lengkap, kondisi obat tidak sesuai, atau keterlambatan retur)
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian ketidakpatuhan dalam proses retur obat rawat inap
i) Denominator (Penyebut)	Total kejadian retur obat rawat inap
j) Target Pencapaian	≤ 5%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua proses retur obat dari ruang rawat inap ke farmasi. Eksklusi: Obat yang habis digunakan sesuai terapi atau tidak memenuhi syarat retur (misalnya obat rusak karena penggunaan)
l) Formula	$(\text{Jumlah kejadian ketidakpatuhan retur obat} / \text{Total retur obat rawat inap}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen retur obat, observasi, dan pencatatan farmasi
n) Sumber Data	Form retur obat, laporan instalasi farmasi, SIMRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kepatuhan retur obat
p) Populasi / Sampel	Total sampling seluruh kejadian retur obat rawat inap
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase ketidakpatuhan, grafik tren, analisis penyebab (misalnya: kurangnya pemahaman SOP, dokumentasi tidak lengkap, koordinasi antar unit)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Ruangan Rawat Inap, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

66. Keterlambatan sediaan farmasi datang

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Keterlambatan Sediaan Farmasi Datang
b) Dasar Pemikiran	Ketersediaan sediaan farmasi yang tepat waktu sangat penting untuk menjamin kontinuitas pelayanan dan terapi pasien. Keterlambatan kedatangan sediaan farmasi dari distributor dapat menyebabkan kekosongan stok, penundaan terapi, dan menurunkan mutu pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan sebagai indikator mutu.
c) Dimensi Mutu	Ketepatan Waktu, Efisiensi, Kesenambungan Pelayanan
d) Tujuan	Mengurangi keterlambatan kedatangan sediaan farmasi agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu
e) Definisi Operasional	Keterlambatan sediaan farmasi datang adalah keterlambatan penerimaan obat/bahan medis habis pakai dari distributor/penyedia melebihi waktu yang telah disepakati dalam pemesanan atau kontrak
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian keterlambatan kedatangan sediaan farmasi dalam periode pengukuran
i) Denominator (Penyebut)	Total pemesanan sediaan farmasi dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 10% (atau sesuai kebijakan RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua pemesanan sediaan farmasi (obat dan BMHP) ke distributor. Eksklusi: Keterlambatan akibat force majeure (bencana alam, gangguan sistem nasional) atau kebijakan pemerintah
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah keterlambatan kedatangan sediaan farmasi}}{\text{Total pemesanan}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen pemesanan dan penerimaan barang, pencatatan logistik
n) Sumber Data	Surat pesanan (SP), faktur, buku penerimaan barang, SIMRS/logistik
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring pemesanan dan penerimaan sediaan farmasi
p) Populasi / Sampel	Total sampling seluruh pemesanan sediaan farmasi
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase keterlambatan, grafik tren, analisis penyebab (misalnya: keterlambatan distributor, perencanaan stok kurang optimal, kendala pengiriman)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi, Petugas Logistik Farmasi, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

67. Kesalahan pembelian sediaan farmasi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kesalahan Pembelian Sediaan Farmasi
b) Dasar Pemikiran	Proses pembelian sediaan farmasi harus tepat jenis, jumlah, spesifikasi, dan waktu agar menjamin ketersediaan obat yang aman dan efektif bagi pasien. Kesalahan dalam pembelian dapat menyebabkan ketidaksesuaian stok, pemborosan anggaran, serta berpotensi mengganggu pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk menekan kejadian kesalahan pembelian.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Mengurangi dan mengendalikan kejadian kesalahan dalam pembelian sediaan farmasi di gudang farmasi
e) Definisi Operasional	Kesalahan pembelian sediaan farmasi adalah ketidaksesuaian antara permintaan dengan realisasi pembelian, meliputi kesalahan jenis obat, jumlah, spesifikasi, atau ketidaktepatan perencanaan pembelian
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pembelian sediaan farmasi dalam periode pengukuran
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh transaksi pembelian sediaan farmasi dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 2% (atau sesuai kebijakan RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh transaksi pembelian sediaan farmasi. Eksklusi: Pembelian yang dibatalkan sebelum proses final dan kejadian force majeure (bencana alam, gangguan sistem nasional/kebijakan pemerintah)
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah kesalahan pembelian sediaan farmasi}}{\text{Total pembelian sediaan farmasi}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen pemesanan dan pembelian, telaah laporan insiden
n) Sumber Data	Dokumen purchase order (PO), faktur pembelian, laporan penerimaan barang, SIMRS/logistik
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit pembelian, checklist monitoring, laporan insiden
p) Populasi / Sampel	Total sampling seluruh transaksi pembelian sediaan farmasi
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kesalahan, grafik tren, analisis penyebab (misalnya: kesalahan perencanaan, human error, kesalahan input sistem)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi, Petugas Gudang Farmasi, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

68. Selisih stok opname

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Selisih Stok Opname
b) Dasar Pemikiran	Kesesuaian antara stok fisik dan stok pada sistem sangat penting untuk menjamin akurasi persediaan, perencanaan pengadaan, serta mencegah kerugian finansial dan gangguan pelayanan. Selisih stok opname menunjukkan adanya ketidaksesuaian pencatatan atau pengelolaan stok sehingga perlu dimonitor dan dikendalikan.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Keselamatan, Akuntabilitas
d) Tujuan	Mengendalikan dan menurunkan kejadian selisih antara stok fisik dengan stok sistem di gudang farmasi
e) Definisi Operasional	Selisih stok opname adalah perbedaan antara jumlah stok fisik sediaan farmasi yang dihitung saat opname dengan jumlah stok yang tercatat dalam sistem/logistik pada periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah item sediaan farmasi yang mengalami selisih stok (lebih atau kurang) saat stok opname
i) Denominator (Penyebut)	Total item sediaan farmasi yang dilakukan stok opname pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 1% (atau sesuai kebijakan RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh item sediaan farmasi yang dilakukan stok opname. Eksklusi: Item dalam proses retur, barang rusak yang belum tercatat, atau kondisi force majeure (bencana, gangguan sistem)
l) Formula	$(\text{Jumlah item yang mengalami selisih stok} / \text{Total item yang diopname}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung dan pencocokan antara stok fisik dengan data pada sistem (stock opname)
n) Sumber Data	Kartu stok, laporan stok opname, sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS/logistik)
o) Instrumen Pengambilan Data	Form stok opname, checklist audit stok, laporan hasil opname
p) Populasi / Sampel	Total sampling seluruh item sediaan farmasi yang dilakukan stok opname
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan (atau sesuai kebijakan, bisa juga triwulanan)
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan

s) Penyajian Data	Tabel persentase selisih stok, grafik tren, serta analisis penyebab (misalnya: kesalahan pencatatan, kehilangan, kedaluwarsa, kesalahan distribusi)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi, Petugas Gudang Farmasi, Tim Logistik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

69. Resptime memasukkan master barang baru 1X24 Jam

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Resptime Memasukkan Master Barang Baru 1x24 Jam
b) Dasar Pemikiran	Kecepatan dalam memasukkan master data barang baru ke dalam sistem sangat penting untuk menjamin kelancaran proses pengadaan, distribusi, dan pelayanan farmasi. Keterlambatan input master barang dapat menyebabkan hambatan dalam pemesanan, stok tidak tercatat, serta keterlambatan pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap waktu respons input master barang baru.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Efisiensi, Ketepatan Waktu
d) Tujuan	Menjamin ketepatan waktu input master barang baru ke dalam sistem maksimal 1x24 jam sejak pengajuan disetujui
e) Definisi Operasional	Resptime memasukkan master barang baru adalah waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan item/barang baru disetujui hingga item tersebut terinput dan aktif dalam sistem (SIMRS/logistik), dengan standar waktu $\leq 1x24$ jam
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah item master barang baru yang dimasukkan ke dalam sistem $\leq 1x24$ jam
i) Denominator (Penyebut)	Total pengajuan master barang baru yang disetujui dalam periode pengukuran
j) Target Pencapaian	$\geq 95\%$
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pengajuan master barang baru yang telah disetujui. Eksklusi: Pengajuan yang tertunda karena gangguan sistem, hari libur nasional (jika tidak ada layanan), atau force majeure
l) Formula	$(\text{Jumlah master barang baru yang diinput} \leq 1x24 \text{ jam} / \text{Total pengajuan yang disetujui}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Telaah dokumen dan pencatatan waktu pada sistem (tracking waktu pengajuan dan input)
n) Sumber Data	Form pengajuan barang baru, log sistem SIMRS/logistik
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring pengajuan master barang, checklist waktu input
p) Populasi / Sampel	Total sampling seluruh pengajuan master barang baru
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan

s) Penyajian Data	Tabel persentase ketepatan waktu, grafik tren, analisis penyebab keterlambatan (misalnya: beban kerja, kendala sistem, kelengkapan data)
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi, Petugas Pengadaan/Logistik Farmasi, Tim IT/SIMRS, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

70. IDO (Infeksi Daerah Operasi)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Infeksi Daerah Operasi (IDO)
b) Dasar Pemikiran	Infeksi daerah operasi merupakan salah satu indikator penting dalam keselamatan pasien dan mutu pelayanan bedah. IDO dapat meningkatkan morbiditas, lama rawat, biaya perawatan, serta risiko komplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk menurunkan angka kejadian IDO sesuai standar pelayanan kesehatan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Menurunkan angka kejadian infeksi daerah operasi pada pasien yang menjalani tindakan pembedahan
e) Definisi Operasional	Infeksi Daerah Operasi (IDO) adalah infeksi yang terjadi pada luka operasi dalam waktu ≤ 30 hari pasca operasi atau ≤ 1 tahun bila terdapat implan, yang ditandai dengan adanya tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, bengkak, keluar cairan/nanah, atau hasil kultur positif
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien yang mengalami infeksi daerah operasi dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien yang menjalani tindakan operasi pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	$\leq 1,5\%$ (atau sesuai standar RS/Kemenkes)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua pasien yang menjalani tindakan operasi. Eksklusi: Pasien dengan infeksi sebelum operasi atau luka yang sudah terinfeksi sebelumnya
l) Formula	$(\text{Jumlah kejadian IDO} / \text{Total tindakan operasi}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Surveilans aktif dan pasif, observasi klinis, serta telaah rekam medis
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, laporan operasi, laporan surveilans PPI
o) Instrumen Pengambilan Data	Form surveilans IDO, checklist PPI, laporan infeksi nosokomial
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien yang menjalani operasi (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel angka kejadian IDO, grafik tren, serta analisis faktor risiko (jenis operasi, lama operasi, teknik aseptik, dll.)
t) Penanggung Jawab	Tim PPI, Dokter Bedah, Kepala Ruang OK/Perawatan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

71. IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)
b) Dasar Pemikiran	Infeksi aliran darah primer merupakan salah satu infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) yang berdampak serius terhadap keselamatan pasien, meningkatkan morbiditas, mortalitas, lama rawat, dan biaya pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan pengendalian yang ketat untuk menurunkan angka kejadian IADP.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Menurunkan angka kejadian infeksi aliran darah primer pada pasien selama perawatan di rumah sakit
e) Definisi Operasional	Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) adalah infeksi yang terjadi pada aliran darah yang tidak berhubungan dengan infeksi di tempat lain, ditandai dengan hasil kultur darah positif dan/atau tanda klinis infeksi pada pasien, umumnya terkait penggunaan akses intravena (misalnya kateter vena sentral/perifer)
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%) atau per 1000 patient days (sesuai kebijakan RS)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian IADP dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien terpasang akses intravena / total hari pemasangan kateter (patient days) dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 1‰ (per 1000 patient days) atau sesuai standar RS
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien dengan akses intravena (perifer/central line). Eksklusi: Pasien dengan infeksi dari sumber lain (secondary bloodstream infection) atau infeksi sebelum pemasangan akses
l) Formula	$(\text{Jumlah kejadian IADP} / \text{Total patient days penggunaan akses intravena}) \times 1000$
m) Metode Pengumpulan Data	Surveilans aktif dan pasif, observasi klinis, serta telaah rekam medis dan hasil laboratorium
n) Sumber Data	Rekam medis, hasil laboratorium (kultur darah), laporan PPI, catatan pemasangan kateter
o) Instrumen Pengambilan Data	Form surveilans HAIs, checklist PPI, form monitoring pemasangan kateter
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien dengan pemasangan akses intravena (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel angka kejadian per 1000 patient days, grafik tren, serta analisis faktor risiko (lama pemasangan kateter, teknik aseptik, kepatuhan bundle, dll.)
t) Penanggung Jawab	Tim PPI, Perawat Ruangan, Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

72. VAP (Ventilation Associated Pneumonia)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Ventilator Associated Pneumonia (VAP)
b) Dasar Pemikiran	VAP merupakan salah satu infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) yang sering terjadi pada pasien dengan ventilator mekanik. VAP dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, lama rawat, serta biaya pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan pencegahan melalui kepatuhan terhadap bundle ventilator.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Menurunkan angka kejadian VAP pada pasien yang menggunakan ventilator mekanik
e) Definisi Operasional	Ventilator Associated Pneumonia (VAP) adalah pneumonia yang terjadi ≥ 48 jam setelah pemasangan ventilator mekanik, ditandai dengan gejala klinis (demam, leukositosis/leukopenia, sekret purulen), serta didukung temuan radiologis dan/atau mikrobiologis
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Per 1000 ventilator days
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian VAP dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total hari penggunaan ventilator (ventilator days) dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 5 per 1000 ventilator days (atau sesuai standar RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien yang menggunakan ventilator ≥ 48 jam. Eksklusi: Pasien yang sudah mengalami pneumonia sebelum pemasangan ventilator
l) Formula	$(\text{Jumlah kejadian VAP} / \text{Total ventilator days}) \times 1000$
m) Metode Pengumpulan Data	Surveilans aktif dan pasif, observasi klinis, serta telaah rekam medis dan hasil penunjang
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, catatan penggunaan ventilator, hasil radiologi dan laboratorium, laporan PPI
o) Instrumen Pengambilan Data	Form surveilans HAIs, checklist bundle VAP, form monitoring ventilator
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien yang menggunakan ventilator mekanik (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel angka kejadian VAP per 1000 ventilator days, grafik tren, serta analisis faktor risiko (durasi ventilator, kepatuhan bundle, posisi pasien, oral hygiene, dll.)
t) Penanggung Jawab	Tim PPI, Perawat ICU, Dokter ICU/DPJP, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

73. ISK (Infeksi Saluran Kencing)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Infeksi Saluran Kencing (ISK / CAUTI)
b) Dasar Pemikiran	Infeksi saluran kencing merupakan salah satu infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) yang sering terjadi, terutama pada pasien dengan pemasangan kateter urin. ISK dapat meningkatkan lama rawat, biaya pelayanan, serta risiko komplikasi. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan untuk menurunkan angka kejadian ISK.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Menurunkan angka kejadian infeksi saluran kencing pada pasien yang dirawat di rumah sakit, khususnya yang menggunakan kateter urin
e) Definisi Operasional	Infeksi Saluran Kencing (ISK) adalah infeksi pada saluran kemih yang terjadi pada pasien selama perawatan, terutama ≥ 48 jam setelah pemasangan kateter urin (CAUTI), ditandai dengan gejala klinis (demam, disuria, nyeri suprapubik) dan/atau hasil pemeriksaan laboratorium
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Per 1000 catheter days
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian ISK (CAUTI) dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total hari pemasangan kateter urin (catheter days) dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 5 per 1000 catheter days (atau sesuai standar RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien dengan pemasangan kateter urin ≥ 48 jam. Eksklusi: Pasien dengan infeksi saluran kemih sebelum pemasangan kateter
l) Formula	$(\text{Jumlah kejadian ISK} / \text{Total catheter days}) \times 1000$
m) Metode Pengumpulan Data	Surveilans aktif dan pasif, observasi klinis, serta telaah rekam medis dan hasil laboratorium
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, catatan pemasangan kateter, hasil laboratorium urin, laporan PPI
o) Instrumen Pengambilan Data	Form surveilans HAIs, checklist bundle kateter, form monitoring pemasangan kateter
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien dengan pemasangan kateter urin (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel angka kejadian ISK per 1000 catheter days, grafik tren, serta analisis faktor risiko (lama pemasangan kateter, teknik aseptik, kepatuhan bundle, dll.)
t) Penanggung Jawab	Tim PPI, Perawat Ruangan, Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

74. Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Infeksi Aliran Darah Perifer / ILI (Phlebitis)
b) Dasar Pemikiran	Phlebitis merupakan salah satu komplikasi akibat pemasangan infus perifer yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien, infeksi lanjutan, serta memperpanjang masa perawatan. Pemantauan angka kejadian phlebitis penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Menurunkan angka kejadian phlebitis pada pasien dengan pemasangan infus perifer
e) Definisi Operasional	Phlebitis adalah peradangan pada vena akibat pemasangan infus perifer yang ditandai dengan gejala seperti kemerahan, nyeri, pembengkakan, hangat, atau teraba keras di area pemasangan infus, yang terjadi $\geq 24-48$ jam setelah pemasangan
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%) atau per 1000 catheter days
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian phlebitis pada pasien dengan infus perifer dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien dengan pemasangan infus perifer / total hari pemasangan infus (catheter days)
j) Target Pencapaian	$\leq 5\%$ atau ≤ 5 per 1000 catheter days (sesuai kebijakan RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien dengan pemasangan infus perifer. Eksklusi: Pasien dengan peradangan/infeksi pada vena sebelum pemasangan infus
l) Formula	$(\text{Jumlah kejadian phlebitis} / \text{Total pasien dengan infus perifer atau catheter days}) \times 100\%$ atau $\times 1000$
m) Metode Pengumpulan Data	Surveilans aktif dan pasif, observasi langsung kondisi area infus, serta telaah rekam medis
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, catatan pemasangan infus, laporan PPI
o) Instrumen Pengambilan Data	Form surveilans phlebitis, checklist bundle pemasangan infus, form monitoring infus
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien dengan pemasangan infus perifer (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel angka kejadian phlebitis, grafik tren, serta analisis faktor risiko (lama pemasangan, teknik aseptik, jenis cairan/obat, lokasi pemasangan)
t) Penanggung Jawab	Tim PPI, Perawat Ruangan, Kepala Ruangan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

75. Angka Decubitus

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Dekubitus (Pressure Ulcer)
b) Dasar Pemikiran	Dekubitus merupakan cedera pada kulit dan jaringan akibat tekanan berkepanjangan, terutama pada pasien tirah baring. Kejadian dekubitus mencerminkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan pasien. Pencegahan yang optimal dapat menurunkan morbiditas, lama rawat, serta biaya perawatan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Menurunkan angka kejadian dekubitus pada pasien rawat inap
e) Definisi Operasional	Dekubitus adalah luka pada kulit dan/atau jaringan di bawahnya akibat tekanan terus-menerus, biasanya terjadi pada area penonjolan tulang, yang muncul selama perawatan di rumah sakit (bukan luka yang sudah ada saat masuk)
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien yang mengalami dekubitus selama perawatan di rumah sakit
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien rawat inap dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 1% (atau sesuai kebijakan RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien rawat inap dengan risiko dekubitus (tirah baring, imobilisasi). Eksklusi: Pasien yang sudah memiliki dekubitus saat masuk rumah sakit
l) Formula	$(\text{Jumlah pasien mengalami dekubitus} / \text{Total pasien rawat inap}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung, asesmen risiko (misalnya skala Braden), serta telaah rekam medis
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, catatan asuhan keperawatan, form asesmen risiko dekubitus
o) Instrumen Pengambilan Data	Form surveilans dekubitus, skala Braden, checklist pencegahan dekubitus
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien rawat inap (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel angka kejadian dekubitus, grafik tren, serta analisis faktor risiko (lama tirah baring, nutrisi, mobilisasi, kelembaban kulit)
t) Penanggung Jawab	Perawat Ruangan, Kepala Ruangan, Tim PPI, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

76. Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Petugas Tertusuk Jarum Bekas Pasien (Pajanan)
b) Dasar Pemikiran	Pajanan akibat tertusuk jarum bekas pasien merupakan risiko kerja yang dapat menularkan penyakit infeksi seperti HIV, Hepatitis B, dan Hepatitis C kepada petugas kesehatan. Kejadian ini mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri (APD), sehingga perlu dimonitor untuk meningkatkan keselamatan petugas.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas
d) Tujuan	Menurunkan angka kejadian pajanan tertusuk jarum pada petugas kesehatan
e) Definisi Operasional	Kejadian tertusuk jarum adalah insiden dimana petugas kesehatan mengalami luka tusuk akibat jarum atau benda tajam bekas penggunaan pada pasien yang berpotensi menularkan infeksi
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Angka kejadian per 100 petugas atau persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total petugas kesehatan yang berisiko atau total hari kerja petugas dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	0 kejadian (zero accident)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua kejadian tertusuk jarum/benda tajam pada petugas kesehatan. Eksklusi: Luka tusuk yang tidak berhubungan dengan tindakan medis atau tidak terkait pajanan pasien
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Pelaporan insiden (incident report), surveilans K3RS, dan telaah laporan kejadian
n) Sumber Data	Laporan insiden K3RS, laporan PPI, rekam kejadian pajanan
o) Instrumen Pengambilan Data	Form laporan insiden, form pajanan petugas, checklist K3RS
p) Populasi / Sampel	Seluruh petugas kesehatan yang berisiko (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel jumlah kejadian, grafik tren, serta analisis penyebab (misalnya: recapping jarum, tidak menggunakan APD, teknik yang tidak sesuai SOP)
t) Penanggung Jawab	Tim K3RS, Tim PPI, Kepala Unit, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

77. Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Keterlambatan Pengurusan SIP/SIK
b) Dasar Pemikiran	Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK) merupakan persyaratan legal bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan. Keterlambatan dalam pengurusan atau perpanjangan SIP/SIK dapat berdampak pada aspek legalitas pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap ketepatan waktu pengurusan SIP/SIK.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Kepatuhan, Legalitas
d) Tujuan	Menjamin seluruh tenaga kesehatan memiliki SIP/SIK yang aktif dan tidak terjadi keterlambatan dalam pengurusan atau perpanjangan
e) Definisi Operasional	Keterlambatan pengurusan SIP/SIK adalah kondisi dimana pengajuan baru atau perpanjangan SIP/SIK dilakukan tidak sesuai waktu yang ditetapkan sehingga terjadi masa tidak aktif/expired
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah tenaga kesehatan yang mengalami keterlambatan dalam pengurusan atau perpanjangan SIP/SIK dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total tenaga kesehatan yang wajib memiliki atau melakukan perpanjangan SIP/SIK dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	0 (tidak ada keterlambatan)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh tenaga kesehatan yang wajib memiliki atau memperpanjang SIP/SIK. Eksklusi: Tenaga kesehatan yang sedang cuti panjang, tidak aktif bekerja, atau kondisi force majeure
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Telaah dokumen kepegawaian dan monitoring masa berlaku SIP/SIK
n) Sumber Data	Data kepegawaian, dokumen SIP/SIK, database SDM
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring SIP/SIK, checklist masa berlaku izin
p) Populasi / Sampel	Total sampling seluruh tenaga kesehatan
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase keterlambatan, grafik tren, serta analisis penyebab (misalnya: keterlambatan pengajuan, kelengkapan berkas, proses administrasi eksternal)
t) Penanggung Jawab	Bagian SDM/Kepegawaian, Kepala Instalasi, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

78. Angka turn over staf

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Turn Over Staf
b) Dasar Pemikiran	Tingginya angka turn over staf dapat berdampak pada kontinuitas pelayanan, peningkatan beban kerja, biaya rekrutmen, serta penurunan mutu pelayanan. Oleh karena itu, pemantauan turn over staf penting untuk menjaga stabilitas dan kualitas sumber daya manusia di rumah sakit.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Mengetahui dan menurunkan angka turn over staf di rumah sakit
e) Definisi Operasional	Turn over staf adalah jumlah tenaga kerja yang keluar (resign, pensiun, PHK, atau meninggal dunia) dibandingkan dengan total tenaga kerja dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah staf yang keluar dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Rata-rata jumlah staf dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 10% per tahun (atau sesuai kebijakan RS)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh staf yang keluar (resign, pensiun, PHK, meninggal). Eksklusi: Staf kontrak jangka pendek yang telah selesai masa kontraknya sesuai perjanjian
l) Formula	$(\text{Jumlah staf keluar} / \text{Rata-rata jumlah staf}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Telaah data kepegawaian dan laporan SDM
n) Sumber Data	Data SDM/kepegawaian, laporan resign, database karyawan
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring SDM, laporan keluar masuk pegawai
p) Populasi / Sampel	Seluruh staf rumah sakit (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel angka turn over, grafik tren, serta analisis penyebab (misalnya: kepuasan kerja, beban kerja, kompensasi, lingkungan kerja)
t) Penanggung Jawab	Bagian SDM/Kepegawaian, Kepala Unit, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

79. Kesalahan pendaftaran pasien

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kesalahan Pendaftaran Pasien
b) Dasar Pemikiran	Proses pendaftaran pasien merupakan tahap awal dalam pelayanan kesehatan yang sangat menentukan ketepatan identitas pasien. Kesalahan pada tahap ini dapat berdampak pada kesalahan pelayanan, keselamatan pasien, serta administrasi dan klaim. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk meminimalkan kesalahan pendaftaran.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Akurasi, Efektivitas
d) Tujuan	Menurunkan angka kejadian kesalahan dalam proses pendaftaran pasien
e) Definisi Operasional	Kesalahan pendaftaran pasien adalah ketidaksesuaian data identitas pasien (nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, alamat, jenis kelamin, atau data penting lainnya) yang terjadi pada saat proses pendaftaran
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	0
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pendaftaran pasien dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua kejadian kesalahan input data pasien saat pendaftaran. Eksklusi: Perubahan data yang dilakukan atas permintaan pasien dan telah melalui prosedur yang benar
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Audit data pendaftaran, telaah rekam medis, dan laporan insiden
n) Sumber Data	Sistem pendaftaran/SIMRS, rekam medis, laporan insiden
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit pendaftaran, checklist verifikasi identitas pasien
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien yang melakukan pendaftaran (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kesalahan, grafik tren, serta analisis penyebab (misalnya: human error, sistem, kurangnya verifikasi identitas)
t) Penanggung Jawab	Petugas Pendaftaran, Kepala Unit Pendaftaran, Instalasi Rekam Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

80. Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Pasien BPJS TK Tidak Memasukkan dalam Sistem E-PLKK
b) Dasar Pemikiran	Sistem E-PLKK digunakan untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan pasien BPJS Ketenagakerjaan. Ketidakinputan data pasien ke dalam sistem dapat berdampak pada klaim, pelaporan, serta aspek administrasi dan legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan untuk memastikan seluruh pasien BPJS TK tercatat dalam sistem.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Akurasi, Kepatuhan, Administrasi
d) Tujuan	Menjamin seluruh pasien BPJS TK terinput dalam sistem E-PLKK secara tepat dan lengkap
e) Definisi Operasional	Kejadian pasien BPJS TK tidak dimasukkan dalam sistem E-PLKK adalah kondisi dimana pasien peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan pelayanan tidak tercatat/input dalam sistem E-PLKK pada periode pelayanan
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien BPJS TK yang tidak terinput dalam sistem E-PLKK dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua pasien peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan pelayanan. Eksklusi: Pasien dengan kendala sistem nasional (down system), atau kondisi force majeure yang terdokumentasi
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Audit data pelayanan dan pencocokan dengan data pada sistem E-PLKK
n) Sumber Data	Data pendaftaran pasien, SIMRS, sistem E-PLKK
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit E-PLKK, checklist verifikasi input data
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien BPJS TK (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kejadian, grafik tren, serta analisis penyebab (misalnya: kelalaian petugas, kendala sistem, kurangnya verifikasi)
t) Penanggung Jawab	Petugas Pendaftaran, Petugas Klaim/Billing, Kepala Unit Rekam Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

81. Kegagalan Pelaksanaan Layanan di Rawat Jalan akibat Kesalahan Pelayanan

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kegagalan Pelaksanaan Layanan di Rawat Jalan akibat Kesalahan Pelayanan
b) Dasar Pemikiran	Kegagalan pelayanan di rawat jalan akibat kesalahan internal (administratif, sistem, tenaga kesehatan, atau sarana) dapat menurunkan mutu layanan, meningkatkan ketidakpuasan pasien, serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pasien. Monitoring indikator ini penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab kegagalan pelayanan setiap hari.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Efisiensi, Keselamatan (Safety), Patient Centered Care
d) Tujuan	Menurunkan angka kegagalan pelayanan rawat jalan akibat kesalahan internal dan meningkatkan kelancaran pelayanan pasien setiap hari.
e) Definisi Operasional	Kegagalan pelaksanaan layanan rawat jalan adalah kondisi dimana pasien yang telah terdaftar tidak mendapatkan pelayanan sesuai rencana pada hari yang sama akibat kesalahan internal rumah sakit (misalnya: dokter tidak hadir tanpa pengganti, kesalahan administrasi, sistem error, ketidaksiapan sarana/prasarana).
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%) atau Jumlah kejadian per hari
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien rawat jalan yang gagal mendapatkan pelayanan akibat kesalahan internal pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien rawat jalan yang terdaftar pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≤ 1% per bulan atau 0 kejadian per hari (sesuai kebijakan rumah sakit).
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat jalan yang telah melakukan pendaftaran dan dijadwalkan mendapatkan pelayanan pada hari tersebut. Eksklusi: Pasien batal atas permintaan sendiri, datang terlambat, atau kondisi force majeure di luar kendali rumah sakit (bencana, gangguan eksternal besar).
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pasien gagal pelayanan akibat kesalahan internal}}{\text{Total pasien rawat jalan terdaftar}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap harian unit rawat jalan, laporan komplain, dan laporan insiden pelayanan.
n) Sumber Data	Buku register rawat jalan, SIMRS, laporan insiden mutu, laporan komplain pasien.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring kegagalan pelayanan rawat jalan harian.
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien rawat jalan pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Harian (direkap bulanan).
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan.
s) Penyajian Data	Tabel rekap harian dan bulanan, grafik tren kejadian, serta analisis akar masalah (RCA) untuk kejadian berulang.
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Pelayanan Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.

82. Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Ketidaksesuaian Tanggal Pengunjungan Pasien Rawat Inap dengan SPRI
b) Dasar Pemikiran	Ketepatan pencatatan tanggal pengunjungan pasien rawat inap dengan Surat Perintah Rawat Inap (SPRI) sangat penting untuk menjamin akurasi data pelayanan, kelancaran administrasi, serta ketepatan klaim pembiayaan. Ketidaksesuaian data dapat berdampak pada kesalahan klaim dan mutu pelayanan.
c) Dimensi Mutu	Akurasi, Efektivitas, Kepatuhan, Administrasi
d) Tujuan	Menjamin kesesuaian tanggal pengunjungan pasien rawat inap dengan data pada SPRI
e) Definisi Operasional	Ketidaksesuaian tanggal pengunjungan adalah kondisi dimana tanggal masuk/rawat pasien di sistem atau rekam medis tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam SPRI
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien rawat inap dengan SPRI dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	-
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat inap yang menggunakan SPRI. Eksklusi: Perubahan tanggal yang telah dikoreksi sesuai prosedur dan terdokumentasi, serta kendala sistem (force majeure)
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen dan pencocokan data antara rekam medis/SIMRS dengan SPRI
n) Sumber Data	Rekam medis, SIMRS, dokumen SPRI
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kesesuaian data, checklist verifikasi SPRI
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien rawat inap dengan SPRI (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase ketidaksesuaian, grafik tren, serta analisis penyebab (human error, kesalahan input, kurangnya verifikasi)
t) Penanggung Jawab	Petugas Pendaftaran, Instalasi Rekam Medis, Petugas Rawat Inap, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

83. Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kegagalan Pelaksanaan Layanan di Rawat Jalan akibat Kesalahan Pelayanan
b) Dasar Pemikiran	Kegagalan pelayanan di rawat jalan akibat kesalahan internal (administratif, sistem, tenaga kesehatan, atau sarana) dapat menurunkan mutu layanan, meningkatkan ketidakpuasan pasien, serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pasien. Monitoring indikator ini penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab kegagalan pelayanan setiap hari.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Efisiensi, Keselamatan (Safety), Patient Centered Care
d) Tujuan	Menurunkan angka kegagalan pelayanan rawat jalan akibat kesalahan internal dan meningkatkan kelancaran pelayanan pasien setiap hari.
e) Definisi Operasional	Kegagalan pelaksanaan layanan rawat jalan adalah kondisi dimana pasien yang telah terdaftar tidak mendapatkan pelayanan sesuai rencana pada hari yang sama akibat kesalahan internal rumah sakit (misalnya: dokter tidak hadir tanpa pengganti, kesalahan administrasi, sistem error, ketidaksiapan sarana/prasarana).
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%) atau Jumlah kejadian per hari
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien rawat jalan yang gagal mendapatkan pelayanan akibat kesalahan internal pada periode pengukuran.
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien rawat jalan yang terdaftar pada periode yang sama.
j) Target Pencapaian	≤ 1% per bulan atau 0 kejadian per hari (sesuai kebijakan rumah sakit).
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat jalan yang telah melakukan pendaftaran dan dijadwalkan mendapatkan pelayanan pada hari tersebut. Eksklusi: Pasien batal atas permintaan sendiri, datang terlambat, atau kondisi force majeure di luar kendali rumah sakit (bencana, gangguan eksternal besar).
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pasien gagal pelayanan akibat kesalahan internal}}{\text{Total pasien rawat jalan terdaftar}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap harian unit rawat jalan, laporan komplain, dan laporan insiden pelayanan.
n) Sumber Data	Buku register rawat jalan, SIMRS, laporan insiden mutu, laporan komplain pasien.
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring kegagalan pelayanan rawat jalan harian.
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien rawat jalan pada periode pengukuran (total sampling).
q) Periode Pengumpulan Data	Harian (direkap bulanan).
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan.
s) Penyajian Data	Tabel rekap harian dan bulanan, grafik tren kejadian, serta analisis akar masalah (RCA) untuk kejadian berulang.

t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Pelayanan Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
---------------------	---

84. Ketidakpatuhan pembuatan PCRA

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Ketidakpatuhan Pembuatan PCRA (Pre Construction Risk Assessment)
b) Dasar Pemikiran	PCRA diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko selama kegiatan konstruksi/renovasi di rumah sakit, terutama terkait pencegahan infeksi, keselamatan pasien, dan keselamatan kerja. Ketidakpatuhan dalam pembuatan PCRA dapat meningkatkan risiko kejadian infeksi dan insiden keselamatan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Kepatuhan
d) Tujuan	Memastikan seluruh kegiatan konstruksi/renovasi di rumah sakit diawali dengan pembuatan PCRA sesuai standar guna meminimalkan risiko
e) Definisi Operasional	Persentase kegiatan konstruksi/renovasi yang tidak dilengkapi dokumen PCRA sebelum pelaksanaan pekerjaan dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kegiatan konstruksi/renovasi yang tidak memiliki dokumen PCRA
i) Denominator (Penyebut)	Total kegiatan konstruksi/renovasi yang dilakukan dalam periode tertentu
j) Target Pencapaian	0% (tidak ada kegiatan tanpa PCRA)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua kegiatan konstruksi, renovasi, perbaikan fasilitas di lingkungan rumah sakit. Eksklusi: Kegiatan pemeliharaan ringan yang tidak berisiko (misalnya perbaikan kecil tanpa potensi debu/kontaminasi) sesuai kebijakan RS
l) Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen dan observasi lapangan
n) Sumber Data	Dokumen PCRA, laporan unit sarana prasarana, dan hasil monitoring PPI
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kepatuhan PCRA
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh kegiatan konstruksi/renovasi di RS. Sampel: Total sampling (seluruh kegiatan dalam periode berjalan)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan (atau setiap ada kegiatan)
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat PPI dan PMKP
s) Penyajian Data	Tabel persentase kepatuhan, grafik tren bulanan
t) Penanggung Jawab	Tim PPI, Bagian Sarana Prasarana, K3RS, Komite PMKP

85. Klaim pending IRJA <0,5%

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Klaim Pending IRJA < 0,5%
b) Dasar Pemikiran	Klaim pending pada pelayanan rawat jalan dapat menghambat arus kas rumah sakit dan mencerminkan ketidaksesuaian administrasi, coding, atau kelengkapan berkas klaim. Pengendalian klaim pending penting untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan finansial rumah sakit.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas, Kepatuhan
d) Tujuan	Menurunkan angka klaim pending rawat jalan melalui peningkatan kelengkapan dan ketepatan proses klaim
e) Definisi Operasional	Persentase klaim rawat jalan (IRJA) yang dinyatakan pending oleh verifikator dibandingkan dengan total klaim yang diajukan dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah klaim IRJA yang dinyatakan pending
i) Denominator (Penyebut)	Total klaim IRJA yang diajukan dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	< 0,5%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh klaim rawat jalan yang diajukan ke penjamin (misal BPJS). Eksklusi: Klaim yang belum diajukan atau masih dalam proses internal verifikasi RS
l) Formula	(Numerator / Denominator) x 100%
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi data klaim dari unit klaim/casemix
n) Sumber Data	SIMRS, INA-CBG's, laporan verifikasi klaim
o) Instrumen Pengambilan Data	Laporan rekap klaim pending IRJA
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh klaim rawat jalan. Sampel: Total sampling (seluruh klaim dalam periode berjalan)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel persentase klaim pending, analisis penyebab pending
t) Penanggung Jawab	Unit Klaim/Casemix, Bagian Keuangan, Komite PMKP

86. Klaim pending IRNA <0,1%

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Klaim Pending IRNA < 0,1%
b) Dasar Pemikiran	Klaim pending pada pelayanan rawat inap berdampak signifikan terhadap cash flow rumah sakit dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam aspek administrasi, coding, maupun kelengkapan dokumen medis. Pengendalian klaim pending penting untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas, Kepatuhan
d) Tujuan	Menurunkan angka klaim pending rawat inap melalui peningkatan kualitas dokumentasi dan ketepatan proses klaim
e) Definisi Operasional	Persentase klaim rawat inap (IRNA) yang dinyatakan pending oleh verifikator dibandingkan dengan total klaim rawat inap yang diajukan dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah klaim IRNA yang dinyatakan pending
i) Denominator (Penyebut)	Total klaim IRNA yang diajukan dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	< 0,1%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh klaim rawat inap yang diajukan ke penjamin (misal BPJS). Eksklusi: Klaim yang belum diajukan atau masih dalam proses verifikasi internal rumah sakit
l) Formula	(Numerator / Denominator) x 100%
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi data klaim dari unit klaim/casemix
n) Sumber Data	SIMRS, INA-CBG's, laporan verifikasi klaim
o) Instrumen Pengambilan Data	Laporan rekap klaim pending IRNA
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh klaim rawat inap. Sampel: Total sampling (seluruh klaim dalam periode berjalan)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel persentase klaim pending, analisis penyebab pending (administrasi, coding, medis)
t) Penanggung Jawab	Unit Klaim/Casemix, Bagian Keuangan, Komite PMKP

87. Klaim tidak layak IRNA (Standart 0)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Klaim Tidak Layak IRNA (Standar 0%)
b) Dasar Pemikiran	Klaim tidak layak pada pelayanan rawat inap menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam aspek administrasi, indikasi medis, coding, maupun kelengkapan dokumen. Hal ini berdampak pada kerugian finansial rumah sakit serta mencerminkan mutu pelayanan yang belum optimal.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas, Kepatuhan
d) Tujuan	Mencapai 0% klaim tidak layak rawat inap melalui peningkatan kualitas dokumentasi, ketepatan coding, dan kepatuhan terhadap regulasi klaim
e) Definisi Operasional	Persentase klaim rawat inap (IRNA) yang dinyatakan tidak layak bayar (rejected) oleh verifikator dibandingkan dengan total klaim yang diajukan dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah klaim IRNA yang dinyatakan tidak layak (rejected)
i) Denominator (Penyebut)	Total klaim IRNA yang diajukan dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	0%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh klaim rawat inap yang diajukan ke penjamin (misal BPJS). Eksklusi: Klaim yang masih dalam proses verifikasi atau belum diajukan
l) Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi laporan hasil verifikasi klaim dari unit klaim/casemix
n) Sumber Data	SIMRS, INA-CBG's, laporan verifikator klaim
o) Instrumen Pengambilan Data	Laporan rekap klaim tidak layak (reject) IRNA
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh klaim rawat inap. Sampel: Total sampling (seluruh klaim dalam periode berjalan)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen, keuangan, dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel jumlah dan persentase klaim tidak layak, analisis penyebab (administrasi, medis, coding)
t) Penanggung Jawab	Unit Klaim/Casemix, Bagian Keuangan, Komite Medik, Komite PMKP

88. Klaim tidak layak IRJA (Standart 0)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Klaim Tidak Layak IRJA (Standar 0%)
b) Dasar Pemikiran	Klaim tidak layak pada pelayanan rawat jalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam administrasi, indikasi medis, coding, maupun kelengkapan dokumen. Hal ini berdampak pada kerugian finansial rumah sakit dan mencerminkan mutu pelayanan yang belum optimal.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas, Kepatuhan
d) Tujuan	Mencapai 0% klaim tidak layak rawat jalan melalui peningkatan kualitas dokumentasi, ketepatan coding, dan kepatuhan terhadap regulasi klaim
e) Definisi Operasional	Persentase klaim rawat jalan (IRJA) yang dinyatakan tidak layak bayar (rejected) oleh verifikator dibandingkan dengan total klaim yang diajukan dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah klaim IRJA yang dinyatakan tidak layak (rejected)
i) Denominator (Penyebut)	Total klaim IRJA yang diajukan dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	0%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh klaim rawat jalan yang diajukan ke penjamin (misal BPJS). Eksklusi: Klaim yang masih dalam proses verifikasi atau belum diajukan
l) Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi laporan hasil verifikasi klaim dari unit klaim/casemix
n) Sumber Data	SIMRS, INA-CBG's, laporan verifikator klaim
o) Instrumen Pengambilan Data	Laporan rekap klaim tidak layak (reject) IRJA
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh klaim rawat jalan. Sampel: Total sampling (seluruh klaim dalam periode berjalan)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen, keuangan, dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel jumlah dan persentase klaim tidak layak, analisis penyebab (administrasi, medis, coding)
t) Penanggung Jawab	Unit Klaim/Casemix, Bagian Keuangan, Komite Medik, Komite PMKP

89. Audit pasca klaim IRJA <1 juta

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Audit Pasca Klaim IRJA < 1 Juta
b) Dasar Pemikiran	Audit pasca klaim diperlukan untuk memastikan kesesuaian klaim dengan pelayanan yang diberikan serta mencegah potensi klaim tidak layak atau temuan audit eksternal. Klaim dengan nominal kecil (<1 juta) tetap berisiko apabila tidak diaudit secara sistematis.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas, Kepatuhan
d) Tujuan	Menjamin seluruh klaim IRJA dengan nominal < 1 juta telah melalui proses audit pasca klaim secara tepat dan sesuai standar
e) Definisi Operasional	Persentase klaim rawat jalan (IRJA) dengan nominal < 1 juta yang telah dilakukan audit pasca klaim dibandingkan dengan seluruh klaim IRJA < 1 juta dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah klaim IRJA < 1 juta yang telah diaudit pasca klaim
i) Denominator (Penyebut)	Total klaim IRJA < 1 juta dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh klaim IRJA dengan nominal < 1 juta yang telah diajukan. Eksklusi: Klaim yang masih dalam proses verifikasi awal atau belum diajukan
l) Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen klaim dan rekap laporan audit internal
n) Sumber Data	SIMRS, data klaim/casemix, laporan audit internal
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit pasca klaim IRJA
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh klaim IRJA < 1 juta. Sampel: Total sampling (seluruh klaim dalam periode berjalan)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat keuangan dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel capaian audit, analisis temuan audit
t) Penanggung Jawab	Unit Klaim/Casemix, SPI (Satuan Pengawas Internal), Bagian Keuangan, Komite PMKP

90. Audit pasca klaim IRNA 1-2 juta

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Audit Pasca Klaim IRNA 1–2 Juta
b) Dasar Pemikiran	Audit pasca klaim rawat inap penting untuk memastikan kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan klaim yang diajukan. Klaim dengan nominal 1–2 juta memiliki potensi risiko ketidaksesuaian yang perlu dikendalikan melalui audit internal.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas, Kepatuhan
d) Tujuan	Menjamin seluruh klaim IRNA dengan nominal 1–2 juta telah dilakukan audit pasca klaim secara tepat dan sesuai standar
e) Definisi Operasional	Persentase klaim rawat inap (IRNA) dengan nominal 1–2 juta yang telah dilakukan audit pasca klaim dibandingkan dengan seluruh klaim IRNA nominal 1–2 juta dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah klaim IRNA 1–2 juta yang telah diaudit pasca klaim
i) Denominator (Penyebut)	Total klaim IRNA dengan nominal 1–2 juta dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh klaim IRNA dengan nominal 1–2 juta yang telah diajukan. Eksklusi: Klaim yang masih dalam proses verifikasi awal atau belum diajukan
l) Formula	$(\text{Numerator} / \text{Denominator}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen klaim dan rekap laporan audit internal
n) Sumber Data	SIMRS, data klaim/casemix, laporan audit internal
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit pasca klaim IRNA
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh klaim IRNA 1–2 juta. Sampel: Total sampling (seluruh klaim dalam periode berjalan)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat keuangan, SPI, dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel capaian audit, analisis temuan audit
t) Penanggung Jawab	Unit Klaim/Casemix, SPI (Satuan Pengawas Internal), Bagian Keuangan, Komite PMKP

91. Selisih klaim (tarif RS > INACBGs) IRJA <50 juta

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Selisih Klaim (Tarif RS > INA-CBGs) IRJA < 50 Juta
b) Dasar Pemikiran	Perbedaan antara tarif rumah sakit dengan tarif INA-CBGs pada pelayanan rawat jalan dapat menyebabkan potensi kerugian finansial. Monitoring selisih klaim penting untuk menjaga efisiensi biaya dan kesesuaian pelayanan dengan standar pembiayaan.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas
d) Tujuan	Mengendalikan selisih negatif klaim rawat jalan agar tetap dalam batas yang ditetapkan guna menjaga keberlanjutan finansial rumah sakit
e) Definisi Operasional	Total selisih klaim dimana tarif rumah sakit lebih besar dari tarif INA-CBGs pada pelayanan rawat jalan (IRJA) dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Rupiah (Rp)
h) Numerator (Pembilang)	Total nilai selisih klaim (tarif RS > INA-CBGs) pada IRJA
i) Denominator (Penyebut)	Tidak menggunakan denominator (indikator berbasis total nilai)
j) Target Pencapaian	< Rp 50.000.000 per bulan
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh klaim IRJA dengan selisih tarif RS lebih besar dari INA-CBGs. Eksklusi: Klaim dengan tarif sesuai atau lebih kecil dari INA-CBGs
l) Formula	Σ (Tarif RS – Tarif INA-CBGs) untuk IRJA
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi data klaim dari sistem casemix
n) Sumber Data	SIMRS, INA-CBGs, laporan unit klaim/casemix
o) Instrumen Pengambilan Data	Laporan rekap selisih klaim IRJA
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh klaim IRJA. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat keuangan dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren nilai selisih per bulan, tabel per poliklinik/diagnosa
t) Penanggung Jawab	Unit Klaim/Casemix, Bagian Keuangan, Komite PMKP

92. Selisih klaim RITL 50 - 100 juta

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Selisih Klaim (Tarif RS > INA-CBGs) IRJA < 50 Juta
b) Dasar Pemikiran	Perbedaan antara tarif rumah sakit dengan tarif INA-CBGs pada pelayanan rawat jalan dapat menyebabkan potensi kerugian finansial. Monitoring selisih klaim penting untuk menjaga efisiensi biaya dan kesesuaian pelayanan dengan standar pembiayaan.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas
d) Tujuan	Mengendalikan selisih negatif klaim rawat jalan agar tetap dalam batas yang ditetapkan guna menjaga keberlanjutan finansial rumah sakit
e) Definisi Operasional	Total selisih klaim dimana tarif rumah sakit lebih besar dari tarif INA-CBGs pada pelayanan rawat jalan (IRJA) dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Rupiah (Rp)
h) Numerator (Pembilang)	Total nilai selisih klaim (tarif RS > INA-CBGs) pada IRJA
i) Denominator (Penyebut)	Tidak menggunakan denominator (indikator berbasis total nilai)
j) Target Pencapaian	< Rp 50.000.000 per bulan
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh klaim IRJA dengan selisih tarif RS lebih besar dari INA-CBGs. Eksklusi: Klaim dengan tarif sesuai atau lebih kecil dari INA-CBGs
l) Formula	Σ (Tarif RS – Tarif INA-CBGs) untuk IRJA
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi data klaim dari sistem casemix
n) Sumber Data	SIMRS, INA-CBGs, laporan unit klaim/casemix
o) Instrumen Pengambilan Data	Laporan rekap selisih klaim IRJA
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh klaim IRJA. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat keuangan dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren nilai selisih per bulan, tabel per poliklinik/diagnosa
t) Penanggung Jawab	Unit Klaim/Casemix, Bagian Keuangan, Komite PMKP

93. Waktu tanggap respon dan penanganan pelaporan kerusakan unit

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Waktu Tanggap Respon dan Penanganan Pelaporan Kerusakan Unit (Mutu IPSRS)
b) Dasar Pemikiran	Kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit dapat mengganggu pelayanan dan membahayakan keselamatan pasien serta petugas. Respon cepat dan penanganan tepat dari IPSRS sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan mutu pelayanan.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Efisiensi, Keselamatan
d) Tujuan	Meningkatkan kecepatan respon dan ketepatan penanganan terhadap setiap laporan kerusakan sarana dan prasarana
e) Definisi Operasional	Waktu yang dihitung sejak laporan kerusakan diterima oleh IPSRS sampai dilakukan respon awal dan penanganan sesuai standar waktu yang ditetapkan
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah laporan kerusakan yang direspon dan ditangani sesuai standar waktu tanggap
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh laporan kerusakan yang diterima IPSRS
j) Target Pencapaian	≥ 90%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh laporan kerusakan sarana dan prasarana yang masuk ke IPSRS Eksklusi: 1. Kerusakan berat yang membutuhkan vendor/pihak ketiga 2. Laporan tidak resmi
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah laporan sesuai waktu tanggap}}{\text{Total laporan kerusakan}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi laporan kerusakan dari logbook/sistem IPSRS
n) Sumber Data	Buku log IPSRS, Sistem pelaporan kerusakan, Aplikasi maintenance
o) Instrumen Pengambilan Data	Form laporan kerusakan / Logbook IPSRS
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh laporan kerusakan. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren waktu tanggap, tabel per unit/lokasi kerusakan
t) Penanggung Jawab	Kepala IPSRS

94. Kejadian kerusakan sarana prasarana

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Kerusakan Sarana dan Prasarana
b) Dasar Pemikiran	Sarana dan prasarana yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu pelayanan, menurunkan mutu layanan, serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pasien dan petugas. Pemantauan kejadian kerusakan diperlukan untuk meningkatkan pemeliharaan fasilitas.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Mengidentifikasi dan menurunkan angka kejadian kerusakan sarana dan prasarana di rumah sakit
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian kerusakan atau tidak berfungsinya sarana dan prasarana yang dilaporkan dan tercatat dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian kerusakan sarana dan prasarana dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Tidak menggunakan denominator (indikator berbasis jumlah kejadian)
j) Target Pencapaian	-
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh kerusakan sarana dan prasarana yang dilaporkan Eksklusi: Kerusakan ringan yang tidak mempengaruhi pelayanan dan tidak dilaporkan
l) Formula	Σ kejadian kerusakan sarana dan prasarana dalam 1 bulan
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi laporan kerusakan dari unit dan IPSRS
n) Sumber Data	Buku laporan kerusakan, sistem pelaporan IPSRS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form laporan kerusakan / Logbook IPSRS
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh kejadian kerusakan. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren jumlah kejadian per bulan
t) Penanggung Jawab	Kepala IPSRS

95. Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Ketidakpatuhan Pengambilan Barang oleh Unit (Mutu Unit Gudang Umum)
b) Dasar Pemikiran	Ketidaksesuaian dalam proses pengambilan barang oleh unit dapat menyebabkan ketidaktertiban administrasi, selisih stok, serta gangguan dalam pengendalian logistik. Pemantauan kepatuhan diperlukan untuk menjaga akurasi dan efisiensi pengelolaan barang.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas, Akurasi
d) Tujuan	Mengendalikan dan menurunkan kejadian ketidakpatuhan dalam pengambilan barang oleh unit
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian pengambilan barang oleh unit yang tidak sesuai dengan prosedur (tanpa permintaan resmi, tidak sesuai jadwal, tanpa bukti serah terima, atau tidak melalui sistem) dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian pengambilan barang yang tidak sesuai prosedur
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh pengambilan barang oleh unit
j) Target Pencapaian	≤ 5%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pengambilan barang oleh unit Eksklusi: Pengambilan darurat yang telah mendapat persetujuan dan dicatat sesuai prosedur
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pengambilan tidak sesuai prosedur}}{\text{Total pengambilan barang}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit log pengeluaran barang dan telaah dokumen permintaan barang
n) Sumber Data	Buku pengeluaran barang, sistem logistik/gudang
o) Instrumen Pengambilan Data	Form permintaan barang, bukti serah terima, checklist audit
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh transaksi pengambilan barang. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren persentase ketidakpatuhan per bulan, tabel per unit
t) Penanggung Jawab	Kepala Gudang Umum / Logi

96. Resptime menanggapi keluhan unit <10 menit

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Respon Time Menanggapi Keluhan Unit < 10 Menit (Mutu Unit Cleaning Service)
b) Dasar Pemikiran	Keluhan terkait kebersihan lingkungan rumah sakit harus ditangani secara cepat untuk menjaga kenyamanan, keselamatan, dan pencegahan infeksi. Respon yang lambat dapat berdampak pada mutu pelayanan dan kepuasan pengguna layanan.
c) Dimensi Mutu	Responsiveness, Keselamatan, Efektivitas
d) Tujuan	Meningkatkan kecepatan respon petugas cleaning service terhadap keluhan unit
e) Definisi Operasional	Waktu yang dibutuhkan sejak keluhan diterima oleh petugas cleaning service sampai dengan dilakukan respon awal (datang ke lokasi) kurang dari 10 menit
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah keluhan unit yang direspon $\leq$ 10 menit
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh keluhan unit yang masuk
j) Target Pencapaian	$\geq$ 90%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh keluhan kebersihan dari unit pelayanan Eksklusi: Keluhan di luar jam operasional atau kondisi force majeure
l) Formula	$(\text{Jumlah keluhan direspon} \leq 10 \text{ menit} / \text{Total keluhan}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi laporan keluhan dan waktu respon dari logbook/sistem
n) Sumber Data	Buku keluhan unit, sistem pelaporan cleaning service
o) Instrumen Pengambilan Data	Form keluhan / Logbook cleaning service
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh keluhan unit. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren waktu respon, tabel per unit
t) Penanggung Jawab	Koordinator Cleaning Service / Kepala Rumah Tangga

97. Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS (saat akhir rapat)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Ketidaklengkapan Pengumpulan Dokumen Meeting RS (Saat Akhir Rapat)
b) Dasar Pemikiran	Kelengkapan dokumen rapat (notulen, daftar hadir, undangan, materi, dan tindak lanjut) sangat penting sebagai bukti administrasi, dasar pengambilan keputusan, serta monitoring tindak lanjut. Ketidaklengkapan dokumen dapat menghambat koordinasi dan akuntabilitas organisasi.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Akurasi, Akuntabilitas
d) Tujuan	Mengendalikan dan menurunkan kejadian ketidaklengkapan dokumen meeting RS
e) Definisi Operasional	Persentase rapat yang dokumennya tidak lengkap (notulen, daftar hadir, undangan, materi, atau hasil keputusan) pada saat akhir rapat dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah rapat dengan dokumen tidak lengkap saat akhir rapat
i) Denominator (Penyebut)	Total seluruh rapat yang dilaksanakan
j) Target Pencapaian	≤ 5%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh rapat resmi RS (rapat manajemen, komite, unit) Eksklusi: Rapat informal yang tidak diwajibkan memiliki dokumen resmi
l) Formula	$(\text{Jumlah rapat dengan dokumen tidak lengkap} / \text{Total rapat}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit kelengkapan dokumen rapat dan checklist administrasi
n) Sumber Data	Arsip dokumen rapat, notulen, daftar hadir
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist kelengkapan dokumen meeting
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh rapat RS. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Setiap kegiatan rapat
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren persentase ketidaklengkapan, tabel per jenis rapat/unit
t) Penanggung Jawab	Sekretaris RS / Bagian Administrasi

98. Kejadian linen ruang perawatan hilang

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Linen Ruang Perawatan Hilang (Mutu Unit Laundry)
b) Dasar Pemikiran	Linen merupakan bagian penting dalam pelayanan rumah sakit. Kehilangan linen dapat mengganggu pelayanan, meningkatkan biaya operasional, serta mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan dan distribusi linen.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas
d) Tujuan	Mengendalikan dan menurunkan kejadian kehilangan linen di ruang perawatan
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian linen yang tidak dapat ditemukan/hilang dari ruang perawatan berdasarkan pencatatan distribusi dan pengembalian linen dalam periode tertentu
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah linen yang hilang dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total linen yang didistribusikan ke ruang perawatan
j) Target Pencapaian	≤ 1%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh linen yang didistribusikan ke ruang perawatan Eksklusi: Linen rusak atau afkir yang tercatat resmi
l) Formula	$(\text{Jumlah linen hilang} / \text{Total linen didistribusikan}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi distribusi dan pengembalian linen serta audit stok linen
n) Sumber Data	Buku distribusi linen, log laundry, laporan unit
o) Instrumen Pengambilan Data	Form distribusi & pengembalian linen, checklist audit linen
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh linen yang didistribusikan. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren kehilangan linen, tabel per unit ruang perawatan
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit Laundry

99. Kejadian Tercampur Benda Asing

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Tercampur Benda Asing (Mutu Unit Laundry)
b) Dasar Pemikiran	Linen yang tercampur benda asing (misalnya alat medis, benda tajam, atau barang pribadi) dapat membahayakan petugas laundry, merusak peralatan, serta menurunkan mutu pelayanan. Pemantauan diperlukan untuk meningkatkan keselamatan kerja dan kualitas pengelolaan linen.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Efisiensi
d) Tujuan	Mengurangi kejadian tercampurnya benda asing dalam linen yang diproses di laundry
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian ditemukannya benda asing (jarum, alat medis, benda tajam, atau barang lain) di dalam linen saat proses penerimaan, pencucian, atau sortir
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian linen yang ditemukan mengandung benda asing
i) Denominator (Penyebut)	Total linen yang diterima/diproses di laundry
j) Target Pencapaian	0 (Zero Incident)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh linen yang masuk ke unit laundry Eksklusi: Benda asing yang sudah teridentifikasi dan dipisahkan sebelum proses laundry
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung dan pencatatan kejadian oleh petugas laundry
n) Sumber Data	Logbook laundry, laporan insiden
o) Instrumen Pengambilan Data	Form laporan kejadian / checklist penerimaan linen
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh linen yang diproses. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren kejadian, tabel per unit pengirim linen
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit Laundry

100. Kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Keterlambatan Penyediaan Kasa Steril (Mutu Unit CSSD)
b) Dasar Pemikiran	Kasa steril merupakan bahan penting dalam tindakan medis. Keterlambatan penyediaannya dapat menghambat pelayanan, meningkatkan risiko infeksi, serta menurunkan mutu pelayanan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan terhadap ketepatan waktu penyediaan kasa steril oleh CSSD.
c) Dimensi Mutu	Ketepatan Waktu, Keselamatan, Efektivitas
d) Tujuan	Mengurangi kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril agar pelayanan berjalan optimal
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril oleh CSSD yang tidak sesuai dengan waktu standar yang telah ditetapkan
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril
i) Denominator (Penyebut)	Total permintaan kasa steril dari unit pelayanan
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh permintaan kasa steril dari unit pelayanan Eksklusi: Permintaan mendadak (emergency) di luar kapasitas standar atau kondisi force majeure
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Rekapitulasi permintaan dan waktu pemenuhan dari log CSSD
n) Sumber Data	Buku permintaan CSSD, log distribusi steril
o) Instrumen Pengambilan Data	Form permintaan alat/kasa steril, checklist distribusi
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh permintaan kasa steril. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren keterlambatan, tabel per unit peminta
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit CSSD

101. Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Ditemukannya Instrumen Hilang atau Kurang (Mutu Unit CSSD)
b) Dasar Pemikiran	Instrumen yang tidak lengkap atau hilang dapat mengganggu pelayanan, menunda tindakan medis, serta berisiko terhadap keselamatan pasien. Pengendalian dan monitoring diperlukan untuk menjaga akurasi dan keamanan proses sterilisasi serta distribusi instrumen.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Efektivitas, Akurasi
d) Tujuan	Menurunkan kejadian instrumen hilang atau kurang dalam proses pelayanan CSSD
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian ditemukannya instrumen yang tidak lengkap atau hilang saat proses penerimaan, pencucian, perakitan, sterilisasi, atau distribusi instrumen
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian instrumen hilang atau kurang
i) Denominator (Penyebut)	Total set instrumen yang diproses/distribusikan
j) Target Pencapaian	0 (Zero Incident)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh set instrumen yang diproses di CSSD Eksklusi: Instrumen yang sudah rusak dan telah dicatat sebagai afkir
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi dan pencatatan pada setiap tahapan proses CSSD
n) Sumber Data	Logbook CSSD, checklist set instrumen
o) Instrumen Pengambilan Data	Form checklist instrumen, form laporan kejadian
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh set instrumen. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren kejadian, tabel per jenis instrumen/unit
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit CSSD

102. Kejadian CCTV tidak terecord

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian CCTV Tidak Terekam (Mutu Unit IT)
b) Dasar Pemikiran	Sistem CCTV berfungsi untuk keamanan dan monitoring aktivitas di lingkungan rumah sakit. Ketidakberfungsian rekaman CCTV dapat menghambat investigasi kejadian, menurunkan keamanan, serta berdampak pada mutu pelayanan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Keamanan, Efektivitas
d) Tujuan	Mengendalikan dan menurunkan kejadian CCTV yang tidak terekam
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian dimana CCTV tidak melakukan perekaman (tidak ada data rekaman) sesuai waktu operasional yang seharusnya
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian CCTV tidak terekam
i) Denominator (Penyebut)	Total unit CCTV yang terpasang dan seharusnya aktif
j) Target Pencapaian	0 (Zero Incident)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh CCTV aktif di lingkungan RS Eksklusi: CCTV yang sedang dalam perbaikan terjadwal atau maintenance resmi
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Monitoring sistem CCTV dan audit rekaman secara berkala
n) Sumber Data	Sistem CCTV/NVR, log monitoring IT
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist monitoring CCTV, log system
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh CCTV aktif. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren kejadian, tabel per lokasi CCTV
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit IT

103. Kejadian Komputer dan internet lemot

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Komputer dan Internet Lemot (Mutu Unit IT)
b) Dasar Pemikiran	Kinerja komputer dan jaringan internet yang lambat dapat menghambat pelayanan, memperlambat input data, serta menurunkan produktivitas dan kepuasan pengguna. Monitoring diperlukan untuk menjaga kelancaran sistem informasi rumah sakit.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Efisiensi, Responsiveness
d) Tujuan	Mengendalikan dan menurunkan kejadian gangguan kinerja komputer dan internet
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian dimana komputer atau jaringan internet mengalami penurunan performa (lambat/lemot) yang mengganggu pelayanan dan dilaporkan oleh pengguna
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian komputer/internet lemot yang dilaporkan
i) Denominator (Penyebut)	Total unit komputer atau pengguna aktif sistem
j) Target Pencapaian	≤ 5
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh komputer dan jaringan internet yang digunakan untuk pelayanan RS Eksklusi: Gangguan akibat maintenance terjadwal atau faktor eksternal (misal gangguan provider)
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap laporan gangguan dari pengguna dan monitoring sistem IT
n) Sumber Data	Helpdesk IT, log sistem, laporan unit
o) Instrumen Pengambilan Data	Form laporan gangguan / tiket IT
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh komputer/pengguna aktif. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren kejadian, tabel per unit kerja
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit IT

104. Kelengkapan APD pada ruang jenazah

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kelengkapan APD pada Ruang Jenazah
b) Dasar Pemikiran	Petugas di ruang jenazah memiliki risiko tinggi terhadap paparan infeksi. Ketersediaan dan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) sangat penting untuk melindungi petugas serta mencegah penularan penyakit.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Kepatuhan, Efektivitas
d) Tujuan	Menjamin ketersediaan dan kelengkapan APD di ruang jenazah sesuai standar
e) Definisi Operasional	Persentase ketersediaan APD sesuai standar (sarung tangan, masker, gown, pelindung wajah, dll) di ruang jenazah dalam kondisi siap pakai
f) Jenis Indikator	Indikator Struktur
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah jenis APD yang tersedia lengkap sesuai standar
i) Denominator (Penyebut)	Total jenis APD yang seharusnya tersedia sesuai standar
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh jenis APD yang wajib tersedia di ruang jenazah Eksklusi: APD yang sedang dalam proses pengadaan resmi
l) Formula	$(\text{Jumlah APD tersedia lengkap} / \text{Total standar APD}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung dan checklist ketersediaan APD
n) Sumber Data	Ruang jenazah, logistik/APD
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist kelengkapan APD
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh jenis APD di ruang jenazah. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian / Mingguan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Checklist dan grafik capaian kelengkapan APD
t) Penanggung Jawab	Penanggung jawab ruang jenazah / Unit terkait (IPSR/Logistik/PPI)

105. Kejadian permintaan driver yang bersamaan

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Permintaan Driver yang Bersamaan
b) Dasar Pemikiran	Permintaan driver yang terjadi secara bersamaan dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan, terutama untuk kebutuhan operasional dan pelayanan pasien. Pemantauan diperlukan untuk memastikan ketersediaan driver yang optimal dan mengurangi gangguan pelayanan.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Responsiveness, Efektivitas
d) Tujuan	Mengendalikan dan menurunkan kejadian permintaan driver yang bersamaan
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian dimana terdapat lebih dari satu permintaan driver pada waktu yang sama sehingga tidak dapat langsung terpenuhi seluruhnya
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Frekuensi kejadian
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian permintaan driver yang bersamaan dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total permintaan driver
j) Target Pencapaian	≤ 5%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh permintaan driver dari unit pelayanan Eksklusi: Permintaan yang sudah dijadwalkan dan terkoordinasi sebelumnya
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap permintaan driver dan waktu permintaan dari logbook/sistem
n) Sumber Data	Buku permintaan driver, sistem transportasi RS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form permintaan driver / logbook
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh permintaan driver. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren kejadian, tabel per unit peminta
t) Penanggung Jawab	Koordinator Transport / Umum

106. Kejadian Oncall driver

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Oncall Driver
b) Dasar Pemikiran	Ketersediaan dan respon cepat driver ambulans sangat penting dalam mendukung pelayanan rujukan, evakuasi pasien, dan kegawatdaruratan. Keterlambatan atau ketidaksiapan driver oncall dapat berdampak pada keselamatan pasien dan mutu layanan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Ketepatan Waktu (Timeliness), Efektivitas
d) Tujuan	Menjamin kesiapsiagaan dan ketepatan respon driver oncall dalam mendukung pelayanan transportasi pasien
e) Definisi Operasional	Persentase kejadian keterlambatan atau ketidaksiapan driver oncall dalam merespon panggilan layanan ambulans sesuai standar waktu yang ditetapkan
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian keterlambatan/ketidaksiapan driver oncall dalam merespon panggilan
i) Denominator (Penyebut)	Total jumlah panggilan layanan ambulans (oncall driver) dalam periode tertentu
j) Target Pencapaian	≤ 5 kejadian keterlambatan/ketidaksiapan
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua panggilan ambulans yang memerlukan driver oncall (rujukan, penjemputan, emergensi). Eksklusi: Panggilan yang dibatalkan sebelum driver dihubungi atau kondisi force majeure (bencana, gangguan sistem besar)
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Pencatatan logbook ambulans dan laporan kejadian
n) Sumber Data	Buku register ambulans, log call center/IGD, laporan insiden
o) Instrumen Pengambilan Data	Form monitoring respon time driver oncall
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh panggilan ambulans. Sampel: Total sampling (seluruh kejadian dalam periode berjalan)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Analisis bulanan, dilaporkan dalam rapat mutu dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren bulanan, tabel jumlah kejadian, analisis penyebab keterlambatan
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Ambulans/Transportasi, IGD, Komite PMKP

107. Kejadian Penggunaan ambulance Luar RS

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Penggunaan Ambulance Luar RS
b) Dasar Pemikiran	Penggunaan ambulance luar RS menunjukkan adanya keterbatasan armada internal atau ketidaksiapan layanan transportasi RS. Hal ini dapat berdampak pada mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi biaya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Keselamatan, Efektivitas
d) Tujuan	Mengendalikan dan menurunkan penggunaan ambulance luar RS
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian penggunaan ambulance dari luar RS untuk pelayanan pasien karena armada internal tidak tersedia atau tidak siap digunakan
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian penggunaan ambulance luar RS
i) Denominator (Penyebut)	Total permintaan layanan ambulance
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh permintaan ambulance untuk pelayanan pasien Eksklusi: Penggunaan ambulance luar RS yang sudah direncanakan (kerjasama resmi)
l) Formula	
m) Metode Pengumpulan Data	Rekap permintaan dan penggunaan ambulance dari log transport
n) Sumber Data	Buku log ambulance, sistem transport RS
o) Instrumen Pengambilan Data	Form permintaan ambulance / logbook transport
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh permintaan ambulance. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren penggunaan ambulance luar RS, tabel per unit
t) Penanggung Jawab	Koordinator Transport / Umum

108. Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kelolosan Tamu Tidak Menggunakan Kartu Visitor
b) Dasar Pemikiran	Penggunaan kartu visitor merupakan bagian dari sistem keamanan rumah sakit untuk mengontrol akses pengunjung. Kelolosan tamu tanpa kartu visitor dapat meningkatkan risiko keamanan dan mengganggu ketertiban lingkungan RS.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Keamanan, Kepatuhan
d) Tujuan	Menurunkan kejadian tamu yang masuk tanpa menggunakan kartu visitor
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian ditemukannya tamu/pengunjung di area RS yang tidak menggunakan kartu visitor sesuai ketentuan
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian tamu tanpa kartu visitor yang lolos pengawasan
i) Denominator (Penyebut)	Total jumlah tamu/pengunjung yang masuk ke RS
j) Target Pencapaian	0 (Zero Incident)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh tamu/pengunjung RS Eksklusi: Pengunjung dengan akses khusus yang telah terdaftar (misal pegawai, vendor resmi dengan ID khusus)
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung dan pencatatan oleh petugas security
n) Sumber Data	Buku tamu, log security, laporan kejadian
o) Instrumen Pengambilan Data	Form visitor, checklist pengawasan security
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh pengunjung RS. Sampel: Total sampling
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren kejadian, tabel per area/shift
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit Security

109. Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Ketidaktertiban Pengunjung Rawat Inap
b) Dasar Pemikiran	Ketidaktertiban pengunjung dapat mengganggu kenyamanan pasien, menurunkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan risiko keselamatan. Monitoring kejadian ini penting untuk memastikan lingkungan rawat inap tetap aman dan kondusif.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Kepatuhan, Pengalaman Pasien
d) Tujuan	Menurunkan kejadian pengunjung yang tidak tertib di ruang rawat inap sehingga tercipta lingkungan aman dan nyaman bagi pasien dan staf.
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian di mana pengunjung rawat inap melakukan perilaku tidak tertib, misalnya melanggar jam kunjung, berteriak, merusak fasilitas, mengganggu pasien lain atau staf, atau memasuki area terlarang.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian pengunjung rawat inap yang tidak tertib selama periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total jumlah kunjungan pengunjung rawat inap selama periode yang sama
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua pengunjung rawat inap Eksklusi: Staf, kontraktor, vendor resmi dengan ID khusus
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung oleh petugas keamanan/perawat dan pencatatan insiden
n) Sumber Data	Buku tamu, log security, laporan insiden
o) Instrumen Pengambilan Data	Form laporan insiden pengunjung, checklist pengawasan security
p) Populasi / Sampel	Populasi: Semua pengunjung rawat inap Sampel: Total sampling atau kejadian yang tercatat
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan pada rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren kejadian, tabel per unit/shift
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit Security

110. Kesalahan pelunasan yang dilakukan

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kesalahan Pelunasan yang Dilakukan oleh Kasir
b) Dasar Pemikiran	Kesalahan pelunasan dapat menimbulkan risiko finansial bagi rumah sakit, menurunkan kepercayaan pasien, dan mempengaruhi efektivitas administrasi keuangan. Monitoring kesalahan pelunasan membantu memastikan akurasi transaksi dan kepatuhan prosedur kasir.
c) Dimensi Mutu	Akurasi, Keselamatan Finansial, Kepatuhan
d) Tujuan	Meminimalkan kesalahan pelunasan oleh kasir sehingga transaksi keuangan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
e) Definisi Operasional	Setiap kejadian di mana kasir melakukan kesalahan dalam pelunasan pasien atau pihak terkait, termasuk salah nominal, salah metode pembayaran, atau salah input data transaksi.
f) Jenis Indikator	Indikator Outcome / Proses
g) Satuan Pengukuran	Kejadian
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kesalahan pelunasan yang dilakukan kasir selama periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total transaksi pelunasan yang dilakukan kasir selama periode yang sama
j) Target Pencapaian	Zero Error Target
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua transaksi pelunasan pasien dan pihak terkait oleh kasir Eksklusi: Transaksi yang dibatalkan/direvisi secara resmi atau transaksi internal staf rumah sakit
l) Formula	
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi dan audit transaksi kasir, review laporan keuangan harian
n) Sumber Data	Buku kas, sistem pembayaran elektronik, laporan transaksi kasir
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kasir, checklist verifikasi transaksi, log sistem pembayaran
p) Populasi / Sampel	Populasi: Semua transaksi pelunasan kasir Sampel: Total sampling transaksi harian atau sampel acak dari laporan harian
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan pada rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Grafik tren kesalahan pelunasan per hari/bulan, tabel per kasir/unit
t) Penanggung Jawab	Kepala Kasir / Kepala Bagian Keuangan

111. Keterlambatan pelunasan pembayaran

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Keterlambatan Pelunasan Pembayaran
b) Dasar Pemikiran	Keterlambatan pelunasan pembayaran dapat menghambat alur pelayanan pasien, menurunkan kepuasan pasien, serta berdampak pada arus kas dan efektivitas pengelolaan keuangan rumah sakit. Monitoring indikator ini diperlukan untuk memastikan proses pelunasan berjalan tepat waktu dan sesuai standar.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Ketepatan Waktu, Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Menurunkan angka keterlambatan pelunasan pembayaran oleh pasien atau penjamin sehingga proses administrasi keuangan menjadi lebih efektif dan pelayanan pasien tidak terhambat.
e) Definisi Operasional	Keterlambatan pelunasan pembayaran adalah kondisi di mana pasien atau pihak penjamin belum menyelesaikan pembayaran sesuai batas waktu yang telah ditetapkan setelah layanan selesai atau pasien dinyatakan boleh pulang.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah transaksi pelunasan pembayaran yang mengalami keterlambatan dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total transaksi pelunasan pembayaran dalam periode yang sama
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh transaksi pelunasan pembayaran pasien rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis. Eksklusi: Transaksi yang ditangguhkan karena proses klaim penjamin resmi (BPJS/asuransi), transaksi batal, atau kebijakan khusus manajemen.
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi administrasi, audit laporan transaksi kasir, review sistem informasi keuangan
n) Sumber Data	Sistem informasi rumah sakit (SIMRS), laporan kasir harian, bukti transaksi pembayaran
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kasir, laporan transaksi harian/bulanan, log sistem pembayaran
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh transaksi pelunasan pembayaran pasien Sampel: Total sampling seluruh transaksi pada periode pengumpulan data
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan dalam rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren keterlambatan pelunasan per bulan
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit Kasir / Kepala Bagian Keuangan

112. Kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Pemulangan Pasien Rawat Inap Lebih dari 15 Menit
b) Dasar Pemikiran	Keterlambatan proses administrasi pelunasan di unit kasir dapat menyebabkan tertundanya pemulangan pasien rawat inap, berdampak pada ketidaknyamanan pasien, menurunkan kepuasan, serta menghambat efisiensi pemanfaatan tempat tidur. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan keterlambatan pemulangan pasien terkait proses kasir.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Ketepatan Waktu, Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Menurunkan angka keterlambatan pemulangan pasien rawat inap akibat proses pelunasan pembayaran di unit kasir sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
e) Definisi Operasional	Kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit adalah kondisi di mana waktu penyelesaian administrasi pelunasan pembayaran di kasir melebihi 15 menit sejak pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	0
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien rawat inap yang proses pemulangannya melebihi 15 menit akibat proses pelunasan di kasir dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien rawat inap yang menjalani proses pemulangan pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien rawat inap yang telah mendapatkan instruksi pulang dan menyelesaikan proses pelunasan pembayaran di kasir. Eksklusi: Pasien dengan penundaan pulang karena alasan klinis, administrasi non-kasir (obat belum siap, transportasi), klaim penjamin resmi (BPJS/asuransi), atau permintaan pasien/keluarga.
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi waktu pelayanan, audit administrasi kasir, review data SIMRS
n) Sumber Data	SIMRS, laporan kasir rawat inap, catatan waktu instruksi pulang pasien
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit waktu pemulangan pasien, checklist monitoring kasir, laporan sistem
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh pasien rawat inap yang dipulangkan Sampel: Total sampling seluruh pemulangan pasien rawat inap pada periode pengumpulan data
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan pada rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren kejadian pemulangan >15 menit per bulan
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit Kasir / Kepala Bagian Keuangan

113. Keterlambatan pengantaran obat

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Pemulangan Pasien Rawat Inap Lebih dari 15 Menit
b) Dasar Pemikiran	Keterlambatan proses administrasi pelunasan di unit kasir dapat menyebabkan tertundanya pemulangan pasien rawat inap, berdampak pada ketidaknyamanan pasien, menurunkan kepuasan, serta menghambat efisiensi pemanfaatan tempat tidur. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan keterlambatan pemulangan pasien terkait proses kasir.
c) Dimensi Mutu	Efisiensi, Ketepatan Waktu, Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Menurunkan angka keterlambatan pemulangan pasien rawat inap akibat proses pelunasan pembayaran di unit kasir sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
e) Definisi Operasional	Kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit adalah kondisi di mana waktu penyelesaian administrasi pelunasan pembayaran di kasir melebihi 15 menit sejak pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien rawat inap yang proses pemulangannya melebihi 15 menit akibat proses pelunasan di kasir dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien rawat inap yang menjalani proses pemulangan pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≤ 5% kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien rawat inap yang telah mendapatkan instruksi pulang dan menyelesaikan proses pelunasan pembayaran di kasir. Eksklusi: Pasien dengan penundaan pulang karena alasan klinis, administrasi non-kasir (obat belum siap, transportasi), klaim penjamin resmi (BPJS/asuransi), atau permintaan pasien/keluarga.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah pemulangan >15 menit}}{\text{Total pemulangan pasien rawat inap}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi waktu pelayanan, audit administrasi kasir, review data SIMRS
n) Sumber Data	SIMRS, laporan kasir rawat inap, catatan waktu instruksi pulang pasien
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit waktu pemulangan pasien, checklist monitoring kasir, laporan sistem
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh pasien rawat inap yang dipulangkan Sampel: Total sampling seluruh pemulangan pasien rawat inap pada periode pengumpulan data
q) Periode Pengumpulan Data	Harian
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, dilaporkan pada rapat manajemen dan PMKP
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren kejadian pemulangan >15 menit per bulan
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit Kasir / Kepala Bagian Keuangan

114. Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan PPA dalam Pengisian Form Edukasi Kolaborasi
b) Dasar Pemikiran	Edukasi kolaborasi oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) merupakan bagian penting dalam kesinambungan pelayanan dan keselamatan pasien. Ketidakpatuhan pengisian form edukasi kolaborasi dapat menyebabkan informasi edukasi tidak terdokumentasi dengan baik, berpotensi menurunkan mutu pelayanan dan kepatuhan terhadap standar akreditasi.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Efektivitas, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan PPA dalam melakukan dan mendokumentasikan edukasi kolaborasi secara lengkap dan tepat waktu.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi adalah kondisi di mana PPA mengisi form edukasi kolaborasi secara lengkap, benar, dan sesuai waktu yang ditetapkan pada pasien yang membutuhkan edukasi kolaboratif.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah form edukasi kolaborasi yang diisi lengkap dan benar oleh PPA
i) Denominator (Penyebut)	Total form edukasi kolaborasi yang seharusnya diisi oleh PPA
j) Target Pencapaian	≥ 90% kepatuhan
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien yang mendapatkan edukasi kolaborasi dan memiliki form edukasi kolaborasi. Eksklusi: Pasien yang tidak memerlukan edukasi kolaborasi atau kondisi khusus yang terdokumentasi (misal pasien tidak kooperatif, gawat darurat).
l) Formula	$(\text{Jumlah form terisi lengkap} \div \text{Total form yang seharusnya diisi}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis, observasi dokumentasi edukasi, review e-RM
n) Sumber Data	Rekam medis pasien (manual/e-RM), laporan unit pelayanan
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit form edukasi kolaborasi
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh pasien yang mendapatkan edukasi kolaborasi Sampel: Total sampling atau sampling acak sesuai kebijakan mutu
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan dalam rapat PMKP dan manajemen
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik kepatuhan per unit/profesi
t) Penanggung Jawab	Ketua Tim PPA / Kepala Ruangan / Komite Keperawatan & Medik

115. Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi "Read Back" pada Instruksi Verbal

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi "Read Back" pada Instruksi Verbal
b) Dasar Pemikiran	Instruksi verbal memiliki risiko tinggi terjadinya kesalahan komunikasi yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. Penerapan metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) serta konfirmasi "read back" yang didokumentasikan secara lengkap merupakan strategi penting untuk mencegah kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Efektivitas, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam mendokumentasikan instruksi verbal menggunakan metode SBAR dan konfirmasi "read back" secara lengkap dan benar.
e) Definisi Operasional	Kelengkapan dokumentasi SBAR dan "read back" pada instruksi verbal adalah kondisi di mana setiap instruksi verbal yang diberikan didokumentasikan secara lengkap mencakup komponen SBAR serta disertai bukti konfirmasi "read back" oleh penerima instruksi.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah instruksi verbal yang didokumentasikan lengkap menggunakan metode SBAR dan disertai konfirmasi "read back"
i) Denominator (Penyebut)	Total instruksi verbal yang diberikan pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 95% kelengkapan dokumentasi
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh instruksi verbal medis dan keperawatan yang memerlukan tindak lanjut. Eksklusi: Instruksi tertulis/elektronik, instruksi pada kondisi gawat darurat yang terdokumentasi khusus sesuai kebijakan.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah instruksi verbal terdokumentasi lengkap}}{\text{Total instruksi verbal}}\right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis, observasi dokumentasi, review e-RM
n) Sumber Data	Rekam medis pasien (manual atau elektronik), catatan instruksi verbal
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit dokumentasi SBAR dan "read back"
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh instruksi verbal yang diberikan Sampel: Total sampling atau sampling acak dari rekam medis sesuai kebijakan mutu
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan dalam rapat PMKP dan manajemen
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren kelengkapan dokumentasi
t) Penanggung Jawab	Ketua Tim Keselamatan Pasien / Kepala Ruangan / Komite Mutu

116. Angka Kepatuhan Petugas dalam Survei kelengkapan Form Edukasi Kolaborasi Oleh PPA

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kepatuhan Petugas dalam Survei Kelengkapan Form Edukasi Kolaborasi oleh PPA
b) Dasar Pemikiran	Form edukasi kolaborasi merupakan bukti pelaksanaan edukasi terintegrasi oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Survei kelengkapan form yang dilakukan secara konsisten oleh petugas menjadi penting untuk memastikan kepatuhan PPA, kesinambungan pelayanan, serta pemenuhan standar mutu dan akreditasi rumah sakit.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Efektivitas, Tata Kelola Klinis
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melakukan survei/audit kelengkapan form edukasi kolaborasi oleh PPA secara rutin dan berkesinambungan.
e) Definisi Operasional	Angka kepatuhan petugas dalam survei kelengkapan form edukasi kolaborasi oleh PPA adalah persentase pelaksanaan survei/audit yang dilakukan sesuai jadwal, prosedur, dan instrumen yang ditetapkan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah survei kelengkapan form edukasi kolaborasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan
i) Denominator (Penyebut)	Total survei kelengkapan form edukasi kolaborasi yang direncanakan
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Survei/audit kelengkapan form edukasi kolaborasi oleh PPA yang dilakukan petugas mutu/unit. Eksklusi: Survei yang tidak dilaksanakan karena alasan terdokumentasi (cuti, bencana, kebijakan khusus manajemen).
l) Formula	$(\text{Jumlah survei terlaksana sesuai ketentuan} \div \text{Total survei yang direncanakan}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit pelaksanaan survei, review laporan survei, observasi
n) Sumber Data	Laporan survei mutu, jadwal survei, notulen kegiatan mutu
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist kepatuhan survei, form monitoring kegiatan mutu
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh kegiatan survei kelengkapan form edukasi kolaborasi Sampel: Total sampling seluruh survei pada periode berjalan
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan pada rapat PMKP dan manajemen
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik kepatuhan pelaksanaan survei
t) Penanggung Jawab	Ketua Tim Mutu / Komite PMKP / Kepala Ruangan

117. Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kepatuhan Petugas dalam Memberikan Edukasi Kelompok
b) Dasar Pemikiran	Edukasi kelompok merupakan salah satu metode edukasi kesehatan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemandirian pasien serta keluarga. Ketidakpatuhan petugas dalam melaksanakan edukasi kelompok dapat berdampak pada rendahnya pemahaman pasien dan tidak optimalnya pencapaian tujuan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok secara terencana dan terdokumentasi.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Berorientasi pada Pasien, Kestinambungan Pelayanan
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan edukasi kelompok sesuai standar dan jadwal yang ditetapkan.
e) Definisi Operasional	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok adalah persentase pelaksanaan kegiatan edukasi kelompok yang dilakukan oleh petugas sesuai rencana, standar materi, dan terdokumentasi dengan baik.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kegiatan edukasi kelompok yang dilaksanakan sesuai standar dan terdokumentasi
i) Denominator (Penyebut)	Total kegiatan edukasi kelompok yang direncanakan pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Kegiatan edukasi kelompok yang dilaksanakan oleh petugas sesuai program unit. Eksklusi: Kegiatan yang tidak terlaksana karena alasan terdokumentasi (misalnya kondisi darurat, peserta tidak mencukupi, kebijakan khusus manajemen).
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah edukasi kelompok terlaksana sesuai standar}}{\text{Total edukasi kelompok yang direncanakan}}\right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi kegiatan edukasi, audit dokumentasi, review laporan kegiatan
n) Sumber Data	Jadwal edukasi kelompok, laporan pelaksanaan edukasi, rekam dokumentasi unit
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist kepatuhan edukasi kelompok, form laporan kegiatan edukasi
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh kegiatan edukasi kelompok Sampel: Total sampling seluruh kegiatan edukasi kelompok pada periode berjalan
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan dalam rapat PMKP dan manajemen
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit / Koordinator Edukasi Pasien / Tim PMKP

118. Angka Kepatuhan Pasien Mengambil Obat di Rumah Sakit

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kepatuhan Pasien Mengambil Obat di Rumah Sakit
b) Dasar Pemikiran	Pengambilan obat oleh pasien di rumah sakit merupakan bagian penting dari kesinambungan terapi. Ketidakpatuhan pasien dalam mengambil obat dapat menyebabkan terapi tidak optimal, meningkatkan risiko kekambuhan, serta menurunkan mutu dan keselamatan pelayanan. Oleh karena itu, kepatuhan pasien dalam mengambil obat perlu dipantau secara berkala.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Keselamatan Pasien, Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengambil obat yang telah diresepkan di rumah sakit agar terapi dapat berjalan efektif dan aman.
e) Definisi Operasional	Angka kepatuhan pasien mengambil obat adalah persentase pasien yang mengambil obat di instalasi farmasi rumah sakit sesuai resep yang telah diterbitkan dalam periode tertentu.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien yang mengambil obat di rumah sakit sesuai resep
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien yang mendapatkan resep obat dari rumah sakit
j) Target Pencapaian	≥ 95% kepatuhan
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien rawat jalan dan pasien pulang rawat inap yang mendapatkan resep obat dari rumah sakit. Eksklusi: Pasien rujukan internal tanpa obat, resep dibatalkan, atau obat tidak tersedia dan telah didokumentasikan.
l) Formula	$(\text{Jumlah pasien mengambil obat} \div \text{Total pasien mendapat resep}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Review resep dan transaksi farmasi, audit SIMRS
n) Sumber Data	SIMRS, laporan instalasi farmasi, data resep pasien
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kepatuhan pengambilan obat, laporan farmasi
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh pasien yang mendapatkan resep obat Sampel: Total sampling seluruh pasien pada periode pengumpulan data
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan pada rapat PMKP dan manajemen
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren kepatuhan pengambilan obat
t) Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi / Apoteker Penanggung Jawab / Tim PMKP

119. Angka Kepatuhan Petugas dalam Melakukan Edukasi Kelompok sebagai Upaya Pencegahan Penularan TB (4x/bln)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kepatuhan Petugas dalam Melakukan Edukasi Kelompok sebagai Upaya Pencegahan Penularan TB (4x/Bulan)
b) Dasar Pemikiran	Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang memerlukan upaya pencegahan berkelanjutan melalui edukasi kesehatan. Edukasi kelompok yang dilakukan secara rutin oleh petugas kesehatan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan pasien dan pengunjung mengenai pencegahan penularan TB. Pemantauan kepatuhan petugas diperlukan untuk menjamin pelaksanaan edukasi sesuai program yang telah ditetapkan.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan Pasien, Promotif dan Preventif, Efektivitas
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan edukasi kelompok pencegahan penularan TB sebanyak minimal 4 kali setiap bulan.
e) Definisi Operasional	Angka kepatuhan petugas dalam melakukan edukasi kelompok pencegahan penularan TB adalah persentase pelaksanaan kegiatan edukasi kelompok yang dilakukan oleh petugas sesuai jadwal dan standar materi sebanyak 4 kali dalam satu bulan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kegiatan edukasi kelompok pencegahan penularan TB yang terlaksana sesuai standar dalam satu bulan
i) Denominator (Penyebut)	Jumlah kegiatan edukasi kelompok pencegahan penularan TB yang direncanakan (4 kali/bulan)
j) Target Pencapaian	100% (4 dari 4 kegiatan terlaksana setiap bulan)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Kegiatan edukasi kelompok pencegahan penularan TB yang dilaksanakan oleh petugas sesuai program. Eksklusi: Kegiatan yang tidak terlaksana karena alasan terdokumentasi (misalnya kondisi darurat, tidak ada peserta, kebijakan khusus manajemen).
l) Formula	$(\text{Jumlah edukasi kelompok TB terlaksana} \div 4) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi kegiatan edukasi, audit dokumentasi, review laporan promosi kesehatan
n) Sumber Data	Jadwal edukasi TB, laporan kegiatan promkes, dokumentasi foto/daftar hadir
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist pelaksanaan edukasi TB, form laporan edukasi kelompok
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh kegiatan edukasi kelompok pencegahan TB Sampel: Total sampling seluruh kegiatan edukasi TB dalam satu bulan
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, direkap dan dilaporkan triwulanan pada rapat PMKP dan manajemen
s) Penyajian Data	Tabel capaian bulanan dan grafik tren kepatuhan pelaksanaan edukasi TB

t) Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program TB / Kepala Unit / Tim Promosi Kesehatan RS
---------------------	--

120. Kepatuhan DPJP terhadap PPK/CP TBC

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kepatuhan DPJP terhadap PPK/CP TBC
b) Dasar Pemikiran	Penatalaksanaan Tuberkulosis (TBC) harus mengikuti Panduan Praktik Klinis (PPK) dan/atau Clinical Pathway (CP) agar terapi efektif, aman, dan sesuai standar nasional. Ketidakpatuhan DPJP terhadap PPK/CP TBC dapat berdampak pada kegagalan terapi, resistensi obat, serta meningkatnya risiko penularan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan kepatuhan DPJP secara berkesinambungan.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Keselamatan Pasien, Kepatuhan terhadap Standar
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan DPJP dalam menerapkan PPK/CP TBC sesuai standar yang telah ditetapkan rumah sakit.
e) Definisi Operasional	Kepatuhan DPJP terhadap PPK/CP TBC adalah kesesuaian tindakan medis DPJP dalam diagnosis, tata laksana, monitoring, dan evaluasi pasien TBC dengan PPK/CP TBC yang berlaku dan terdokumentasi di rekam medis.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kasus TBC yang ditangani DPJP sesuai PPK/CP TBC
i) Denominator (Penyebut)	Total kasus TBC yang ditangani DPJP pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 90% kepatuhan
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien dengan diagnosis TBC yang mendapatkan pelayanan oleh DPJP dan memiliki PPK/CP TBC. Eksklusi: Kasus rujukan keluar sebelum terapi berjalan, kondisi komorbid berat yang memerlukan deviasi terapi dengan alasan medis yang terdokumentasi.
l) Formula	$(\text{Jumlah kasus sesuai PPK/CP} \div \text{Total kasus TBC}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis, review CP TBC, telaah dokumentasi medis
n) Sumber Data	Rekam medis pasien, dokumen PPK/CP TBC, laporan program TBC
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kepatuhan PPK/CP TBC
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh pasien TBC yang ditangani DPJP Sampel: Total sampling atau sampling acak sesuai kebijakan mutu
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan pada rapat PMKP dan Komite Medik
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren kepatuhan DPJP terhadap PPK/CP TBC
t) Penanggung Jawab	Komite Medik / Penanggung Jawab Program TBC / Tim PMKP

121. Angka kepatuhan pengisian Kartu K4 KB

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kepatuhan Pengisian Kartu K4 KB
b) Dasar Pemikiran	Kartu K4 KB merupakan dokumen penting dalam pelayanan Keluarga Berencana untuk memantau status, riwayat, dan tindak lanjut akseptor. Ketidaktuntasan atau ketidakpatuhan pengisian Kartu K4 KB dapat mengganggu kesinambungan pelayanan, pelaporan program, serta pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Oleh karena itu, kepatuhan pengisian Kartu K4 KB perlu dimonitor secara berkala.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Kontinuitas Pelayanan, Kepatuhan terhadap Standar
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam mengisi Kartu K4 KB secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
e) Definisi Operasional	Angka kepatuhan pengisian Kartu K4 KB adalah persentase Kartu K4 KB yang diisi lengkap dan benar sesuai standar pada setiap pelayanan KB.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah Kartu K4 KB yang diisi lengkap dan benar
i) Denominator (Penyebut)	Total Kartu K4 KB yang seharusnya diisi pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh akseptor KB yang dilayani dan memiliki Kartu K4 KB. Eksklusi: Akseptor dengan kartu rusak/hilang atau kondisi khusus yang terdokumentasi.
l) Formula	$(\text{Jumlah Kartu K4 KB terisi lengkap} \div \text{Total Kartu K4 KB}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen KB, review rekam pelayanan KB
n) Sumber Data	Kartu K4 KB, buku register KB, laporan pelayanan KB
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kelengkapan Kartu K4 KB
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh akseptor KB yang dilayani Sampel: Total sampling atau sampling acak sesuai kebijakan mutu
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan pada rapat PMKP dan manajemen
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren kepatuhan pengisian Kartu K4 KB
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit KB / Bidan Koordinator / Tim PMKP

122. Angka Ibu Pasca Melahirkan dan Pasca Tindakan Curettage yang Mendapatkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Keluarga Berencana (KB)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Ibu Pasca Melahirkan dan Pasca Tindakan Curettage yang Mendapatkan KIE Keluarga Berencana (KB)
b) Dasar Pemikiran	Pemberian KIE Keluarga Berencana pada ibu pasca melahirkan dan pasca tindakan curettage sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, menjaga kesehatan ibu, serta mendukung program KB nasional. Pemantauan indikator ini diperlukan untuk memastikan setiap ibu mendapatkan informasi dan edukasi KB secara optimal dan terdokumentasi.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Keselamatan Pasien, Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Meningkatkan cakupan pemberian KIE KB pada ibu pasca melahirkan dan pasca tindakan curettage secara menyeluruh dan berkesinambungan.
e) Definisi Operasional	Angka ibu pasca melahirkan dan pasca tindakan curettage yang mendapatkan KIE KB adalah persentase ibu yang telah diberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai KB serta terdokumentasi dalam rekam medis sebelum pulang.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah ibu pasca melahirkan dan pasca tindakan curettage yang mendapatkan KIE KB
i) Denominator (Penyebut)	Total ibu pasca melahirkan dan pasca tindakan curettage pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh ibu pasca melahirkan dan pasca tindakan curettage yang dirawat/ditangani di rumah sakit. Eksklusi: Ibu dengan kondisi gawat darurat, rujukan keluar segera, atau menolak edukasi KB dengan alasan yang terdokumentasi.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah ibu mendapatkan KIE KB}}{\text{Total ibu pasca melahirkan \& pasca curettage}} \times 100\% \right)$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis, observasi dokumentasi KIE
n) Sumber Data	Rekam medis ibu, form KIE KB, register maternitas
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit pemberian KIE KB
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh ibu pasca melahirkan dan pasca tindakan curettage Sampel: Total sampling seluruh kasus pada periode pengumpulan data
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan dalam rapat PMKP dan manajemen
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren cakupan pemberian KIE KB
t) Penanggung Jawab	Kepala Ruang Maternitas / Penanggung Jawab Program KB / Tim PMKP

123. Angka Pelaksanaan Pelayanan Konseling KB bagi Calon Peserta dan Peserta Program KB

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Pelaksanaan Pelayanan Konseling KB bagi Calon Peserta dan Peserta Program KB
b) Dasar Pemikiran	Konseling Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi untuk membantu calon peserta dan peserta KB memahami pilihan metode, manfaat, risiko, serta efek samping. Pelaksanaan konseling KB yang optimal dan terdokumentasi dengan baik mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan keberhasilan program KB.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Berorientasi pada Pasien, Kontinuitas Pelayanan
d) Tujuan	Meningkatkan cakupan pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB secara menyeluruh dan sesuai standar.
e) Definisi Operasional	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB adalah persentase calon peserta dan peserta program KB yang mendapatkan pelayanan konseling KB sesuai standar dan terdokumentasi dalam rekam pelayanan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah calon peserta dan peserta program KB yang mendapatkan pelayanan konseling KB
i) Denominator (Penyebut)	Total calon peserta dan peserta program KB yang dilayani pada periode yang sama
j) Target Pencapaian	≥ 95%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Calon peserta dan peserta aktif program KB yang datang untuk pelayanan KB. Eksklusi: Peserta rujukan langsung tanpa konseling atau kondisi khusus dengan alasan medis yang terdokumentasi.
l) Formula	$\left(\frac{\text{Jumlah peserta yang mendapatkan konseling KB}}{\text{Total peserta program KB}} \right) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit rekam pelayanan KB, observasi dokumentasi konseling
n) Sumber Data	Rekam medis/pelayanan KB, form konseling KB, register KB
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit pelaksanaan konseling KB
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh calon peserta dan peserta program KB Sampel: Total sampling seluruh peserta pada periode pengumpulan data
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan pada rapat PMKP dan manajemen
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren pelaksanaan konseling KB
t) Penanggung Jawab	Kepala Unit KB / Bidan Koordinator / Tim PMKP

124. Angka Pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Pelaksanaan Kunjungan Rumah dan PKM Pasien Stunting & Wasting
b) Dasar Pemikiran	Stunting dan wasting merupakan masalah gizi kronis dan akut yang membutuhkan intervensi berkelanjutan, tidak hanya di fasilitas kesehatan tetapi juga melalui kunjungan rumah dan pelayanan kesehatan masyarakat (PKM). Pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM yang optimal sangat penting untuk pemantauan tumbuh kembang, edukasi keluarga, serta pencegahan perburukan kondisi gizi anak.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Promotif dan Preventif, Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Meningkatkan cakupan pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pada pasien stunting dan wasting sesuai rencana intervensi gizi.
e) Definisi Operasional	Angka pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien stunting & wasting adalah persentase pasien stunting dan wasting yang mendapatkan kunjungan rumah dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat sesuai rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien stunting & wasting yang mendapatkan kunjungan rumah dan/atau PKM sesuai rencana
i) Denominator (Penyebut)	Total pasien stunting & wasting yang seharusnya mendapatkan kunjungan rumah dan/atau PKM
j) Target Pencapaian	100%
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Pasien (bayi/balita/anak) dengan status stunting dan/atau wasting yang tercatat dan memiliki rencana tindak lanjut. Eksklusi: Pasien pindah domisili, menolak kunjungan, atau rujukan keluar dengan alasan terdokumentasi.
l) Formula	$(\text{Jumlah pasien yang dikunjungi} \div \text{Total pasien stunting \& wasting}) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Audit laporan kunjungan rumah, review catatan PKM, observasi dokumentasi
n) Sumber Data	Register gizi, laporan kunjungan rumah, laporan PKM, rekam medis
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist kunjungan rumah & PKM pasien stunting/wasting
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh pasien stunting & wasting Sampel: Total sampling seluruh pasien pada periode pengumpulan data
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, dilaporkan dalam rapat PMKP dan lintas program
s) Penyajian Data	Tabel rekapitulasi dan grafik tren pelaksanaan kunjungan rumah & PKM
t) Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Gizi / Koordinator PKM / Tim PMKP

125. Angka Kepatuhan Petugas dalam Memberikan edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln)

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Angka Kepatuhan Petugas dalam Memberikan Edukasi Kelompok sebagai Upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/Bulan)
b) Dasar Pemikiran	Stunting dan wasting merupakan masalah gizi yang berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Edukasi kelompok yang dilakukan secara rutin oleh petugas kesehatan merupakan strategi promotif dan preventif untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang gizi, pola asuh, dan pencegahan stunting & wasting. Pemantauan kepatuhan petugas diperlukan untuk menjamin pelaksanaan edukasi sesuai program yang telah ditetapkan.
c) Dimensi Mutu	Promotif dan Preventif, Efektivitas, Berorientasi pada Pasien
d) Tujuan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan edukasi kelompok pencegahan stunting & wasting minimal 4 kali setiap bulan.
e) Definisi Operasional	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok pencegahan stunting & wasting adalah persentase pelaksanaan kegiatan edukasi kelompok yang dilakukan oleh petugas sesuai jadwal, standar materi, dan terdokumentasi sebanyak 4 kali dalam satu bulan.
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Persentase (%)
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kegiatan edukasi kelompok pencegahan stunting & wasting yang terlaksana sesuai standar dalam satu bulan
i) Denominator (Penyebut)	Jumlah kegiatan edukasi kelompok pencegahan stunting & wasting yang direncanakan (4 kali/bulan)
j) Target Pencapaian	100% (4 dari 4 kegiatan terlaksana setiap bulan)
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Kegiatan edukasi kelompok pencegahan stunting & wasting yang dilaksanakan oleh petugas sesuai program. Eksklusi: Kegiatan yang tidak terlaksana karena alasan terdokumentasi (misalnya kondisi darurat, tidak ada peserta, kebijakan khusus manajemen).
l) Formula	$(\text{Jumlah edukasi kelompok stunting \& wasting terlaksana} \div 4) \times 100\%$
m) Metode Pengumpulan Data	Observasi kegiatan edukasi, audit dokumentasi, review laporan promosi kesehatan/gizi
n) Sumber Data	Jadwal edukasi, laporan kegiatan gizi/promkes, dokumentasi foto dan daftar hadir
o) Instrumen Pengambilan Data	Checklist pelaksanaan edukasi kelompok stunting & wasting
p) Populasi / Sampel	Populasi: Seluruh kegiatan edukasi kelompok pencegahan stunting & wasting Sampel: Total sampling seluruh kegiatan edukasi dalam satu bulan
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, direkap dan dilaporkan triwulanan dalam rapat PMKP
s) Penyajian Data	Tabel capaian bulanan dan grafik tren kepatuhan pelaksanaan edukasi

t) Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Gizi / Kepala Unit / Tim PMKP
---------------------	--

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 03 Januari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

